

Buku Ajar

KONSEP DASAR KEPERAWATAN

Endang Abdullah
Sarwoko



BUKU AJAR KONSEP DASAR KEPERAWATAN

Penulis:

Endang Abdullah, S.Kp., M.Si.

Sarwoko, S.Ag., S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.



BUKU AJAR KONSEP DASAR KEPERAWATAN

Penulis: Endang Abdullah, S.Kp., M.Si.
Sarwoko, S.Ag., S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7294-13-5

Cetakan Pertama : Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-
Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan ini dapat tersusun dengan baik. Buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep-konsep fundamental yang menjadi dasar praktik keperawatan profesional. Melalui pendekatan teoritis dan aplikatif, buku ini mengulas secara komprehensif tentang konsep caring, etik dan legal dalam praktik keperawatan, serta pentingnya pendidikan dan kolaborasi interprofesional dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Dalam buku ini, pembaca akan dipandu memahami konsep caring secara mendalam, termasuk berbagai teori, dimensi, perilaku, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi caring dalam praktik keperawatan. Selanjutnya, aspek etik dan legal juga disajikan secara jelas dan sistematis untuk membantu mahasiswa dan praktisi keperawatan memahami pentingnya penerapan kode etik serta aspek hukum dalam memberikan pelayanan yang aman, bermartabat, dan bertanggung jawab. Selain itu, buku ini juga mengintegrasikan konsep Interprofessional Education (IPE) dan Interprofessional Collaboration (IPC), yang menjadi kebutuhan penting di dunia kesehatan masa kini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, khususnya kepada para penulis yang telah berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Semoga buku ini menjadi sumber inspirasi serta referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, dosen, praktisi, dan seluruh pihak yang berkecimpung dalam dunia kesehatan. Kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 KONSEP <i>CARING</i>.....	1
A. Pengertian Caring	3
B. Teori Caring	5
C. Dimensi Caring	11
D. Komponen Caring	16
E. Caring dalam Praktek Keperawatan.....	17
F. Perilaku Caring	18
G. Faktor – factor yang Mempengaruhi Perilaku Caring	18
H. Faktor Pembentuk Perilaku Caring.....	19
I. Perilaku Caring dalam Praktek Keperawatan	20
J. Proses Keperawatan Berbasis Caring	21
K. Pengukuran Perilaku <i>Caring</i>	22
L. Latihan	28
M. Kunci Jawaban	30
N. Rangkuman Materi	30
O. Glosarium.....	31
P. Daftar Pustaka.....	32
BAB 2 ETIK DAN LEGAL DALAM KEPERAWATAN	35
A. Pendahuluan	36
B. Etik dalam Keperawatan	40
C. Legal dalam Keperawatan.....	54
D. Hubungan Etik dan Legal dalam Keperawatan	71
E. Latihan	76
F. Rangkuman Materi	79
G. Glosarium.....	82
H. Daftar Pustaka.....	88
BAB 3 INTERPROFESSIONAL EDUCATION DAN INTERPROFESSIONAL COLLABORATION DALAM KEPERAWATAN.....	99
A. Pengertian dan Prinsip Interprofessional Education (IPE).....	101

B. Konsep dan Komponen Interprofessional Collaboration (IPC).....	102
C. Peran Perawat dalam Tim Interprofesional.....	104
D. Manfaat dan Tantangan IPE dan IPC dalam Keperawatan.....	106
E. Strategi Implementasi IPE dan IPC dalam Pendidikan dan Praktik.....	108
F. Latihan Soal	110
G. Rangkuman Materi	112
H. Gloasarium	113
I. Daftar Pustaka.....	115
PROFIL PENULIS	117

BAB 1

KONSEP *CARING*

Pendahuluan:

Caring merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman secara fisik dan emosi dengan orang lain secara tulus. *Caring* merupakan sentral untuk praktek keperawatan, seorang perawat dituntut untuk lebih peduli kepada klien. Bab ini akan membahas tentang konsep *caring* dengan pendekatan teori Swanson. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami konsep *caring* dengan pendekatan teori Watson dan Swanson serta aplikasi dalam praktik keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi sarjana keperawatan.

Gambaran pembahasan pada Bab ini adalah pengertian *caring*, teori *caring*, dimensi *caring*, komponen *caring*, indikator perilaku *caring*, proses *caring*, langkah-langkah *caring* dan perilaku *caring* dalam praktik keperawatan. Untuk memberikan gambaran lebih nyata terkait praktek keperawatan di lahan praktek, akan dilengkapi juga dengan studi kasus singkat tentang asuhan keperawatan dengan pendekatan *caring*. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, instrumen pengukuran perilaku *caring*, latihan studi kasus dan dilengkapi dengan rangkuman.

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan pendekatan *caring* berdasarkan bukti ilmiah dan praktik terbaik.

Tujuan Instruksional Khusus:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian *caring*
2. Mahasiswa mampu menjelaskan teori *caring*
3. Mahasiswa mampu menjelaskan dimensi *caring*
4. Mahasiswa mampu menjelaskan komponen *caring*
5. Mahasiswa mampu menjelaskan *caring* dalam praktek keperawatan
6. Mahasiswa mampu menjelaskan perilaku *caring*
7. Mahasiswa mampu menjelaskan factor yang mempengaruhi perilaku *caring*

8. Mahasiswa mampu menjelaskan factor pembentuk perilaku *caring*
9. Mahasiswa mampu menjelaskan proses keperawatan berbasis *caring*
10. Mahasiswa mampu melakukan pengukuran perilaku *caring*
11. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan perilaku *caring* dalam praktik keperawatan.

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep-konsep penting terkait dengan *caring*.
2. Mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik melalui analisis kasus dan penerapan prinsip-prinsip keperawatan dalam skenario klinis.

Psikomotor:

1. Mahasiswa mampu melakukan tindakan keperawatan yang spesifik dan tepat, dengan pendekatan *caring*.

Afektif:

1. Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati, dan etika profesional dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarga, serta dalam tim perawatan kesehatan.
2. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari pengertian *caring*, teori *caring*, dimensi dan komponen *caring*, perilaku *caring*, factor yang mempengaruhi dan pembentuk perilaku *caring*, perilaku *caring* dalam praktik keperawatan, proses keperawatan berbasis *caring* dan pengukuran perilaku *caring*.

A. Pengertian Caring

Caring merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman secara fisik dan emosi dengan orang lain secara tulus. *Caring* merupakan sentral untuk praktek keperawatan, seorang perawat dituntut untuk lebih peduli kepada pasien. *Caring* digambarkan sebagai suatu dasar dalam kesatuan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, dimana *caring* digambarkan sebagai moral ideal keperawatan yang meliputi keinginan dan kesungguhan untuk merawat serta tindakan untuk merawat (Watson, 2005, dalam Tomey & Alligood, 2006). Tujuan perilaku *caring* adalah memberikan asuhan fisik dengan memperhatikan emosi sambil meningkatkan rasa aman dengan menunjukkan perhatian, perasaan empati dan cinta yang merupakan kehendak keperawatan (Gadow dan Woddings, 1984).

Caring merupakan fenomena universal yang mempengaruhi cara manusia berfikir, berperasaan, dan bersikap ketika berinteraksi dengan orang lain. Menghargai orang lain dan mempunyai perasaan memiliki serta bertanggung jawab (Potter & Perry, 2009). *Caring* merupakan sebuah proses interpersonal yang sangat penting yang mengharuskan perawat melakukan aktivitas peran yang spesifik melalui ekspresi emosi tertentu pada klien (Morrison & Burnard, 2009). *Caring* membuat perhatian, motivasi dan arahan bagi klien untuk melakukan sesuatu. *Caring* sebagai salah satu syarat utama untuk *coping*, dengan *caring* perawat mampu mengetahui intervensi yang baik dan tepat yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan perawatan selanjutnya.

Caring merupakan cara seseorang bereaksi terhadap sakit, penderitaan dan berbagai hal yang tidak menyenangkan yang terjadi (Leininger, 1973 dalam Potter & Perry, 2009). *Care* merupakan intisari dari keperawatan dan karakteristik yang dominan, yang tidak dapat dipisahkan dalam keperawatan. Tidak akan ada *cure* tanpa *curing*, tetapi dapat ada *caring* tanpa *curing* (Madeline Leininger, 1981).

Caring adalah, "a nurturing way of relating to valued other to ward whom one feels a personal sense of commitment and responsibility" (Swanson, 1991), yaitu bagaimana seorang perawat dapat merawat seseorang atau klien dengan tetap menghargai martabat orang tersebut dengan komitmen dan tanggungjawab. Dapat

diartikan juga sebuah cara untuk menciptakan dan atau memelihara kesehatan yang dapat dilakukan dengan menjalin hubungan yang bernilai dengan orang lain, sehingga mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan komitmen dan tanggungjawab.

Praktik *caring* sebagai pusat keperawatan, *caring* sebagai dasar dalam kesatuan nilai kemanusiaan yang universal, antara lain kebaikan, kepedulian, dan cinta terhadap diri sendiri dan orang lain. *Caring* digambarkan sebagai moral ideal keperawatan, yaitu keinginan dalam memberikan perawatan yang tulus, kesungguhan untuk merawat, dan tindakan *caring*. Tindakan *caring* meliputi komunikasi yang efektif dan terapeutik, selalu memberikan tanggapan yang positif pada orang lain, memberikan dukungan, memberikan intervensi sesuai harapan dan terstandar (Watson, 1985).

Caring adalah sentral dalam praktik keperawatan karena *caring* merupakan suatu cara pendekatan yang dinamis, dimana seorang perawat profesional dalam bekerja harus lebih perhatian dan bertanggung jawab kepada kliennya. *Caring* merupakan bagian inti yang penting terutama dalam praktik keperawatan, seorang klien yang sedang dirawat di rumah sakit sangat mengharapkan perhatian dan bantuan dari perawat profesional, klien berharap perawat profesional dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, klien mengharapkan kesembuhan dari masalah kesehatan yang dihadapi.

The National League for Nursing (2007) and *The American Association of Colleges of Nursing* (2008) menyatakan bahwa *caring* merupakan hal yang fundamen dalam keperawatan. Kompetensi yang dimiliki seorang perawat dan perilaku *caring*, keduanya penting dalam memberikan perawatan, agar klien merasa aman dan nyaman selama menjalani perawatan, dan *caring* penting untuk kualitas pelayanan keperawatan (Rhodes, et al., 2011).

Konsep *caring* dapat dianggap sebagai konsep yang abstrak, menjadi role model dalam berperilaku *caring* pada mahasiswa keperawatan sangat penting, *caring* tidak cukup untuk diajarkan namun lebih dari itu harus ditanamkan melalui perilaku keseharian, sehingga *caring* akan menjadi pola perilaku mahasiswa keperawatan. Nilai-nilai yang diyakini harus dimiliki oleh seorang perawat profesional, seperti kejujuran, ketulusan dan keikhlasan dalam memberikan pelayanan keperawatan, keramahan, sopan santun, tanggungjawab, empati, harus ditanamkan pada calon perawat atau pada mahasiswa yang sedang menempuh studi di pendidikan keperawatan. Beberapa perguruan tinggi percaya bahwa *caring* merupakan fenomena yang sangat kompleks dan perlu dimodelkan dalam pendidikan tinggi keperawatan sebagai bagian dari kurikulum (Begum & Slavin, 2012).

Pendidikan keperawatan harus dapat memberikan model yang terbaik terkait perilaku *caring* pada mahasiswa, agar mahasiswa dapat mengadopsi perilaku *caring* tersebut dengan benar. *Caring* dalam pendidikan keperawatan dan praktik keperawatan bukan merupakan konsep baru, mahasiswa dapat belajar *caring* melalui pemodelan perilaku *caring* di lingkungan tempat belajar (Fakultas/Prodi) serta yang dicontohkan oleh dosen selama kegiatan pembelajaran. Selama calon perawat profesional menempuh studi, pengajar atau dosen dapat menanamkan sikap dan perilaku *caring* agar menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan terbentuk rasa percaya diri, peduli pada orang lain, selalu memberikan yang terbaik untuk orang lain.

Berdasarkan pengertian tentang *caring* di atas, dapat disimpulkan bahwa *caring* adalah sikap kepedulian perawat terhadap klien dalam pemberian asuhan keperawatan dengan cara merawat klien dengan kesungguhan hati, keikhlasan, penuh kasih sayang, baik melalui komunikasi, pemberian dukungan, maupun tindakan secara langsung. *Caring* merupakan ideal moral keperawatan yang dalam penerapannya pada klien diperlukan pengembangan pengetahuan, ketrampilan, keahlian, empati, komunikasi, kompetensi klinik, keahlian teknik dan ketrampilan interpersonal perawat, serta rasa tanggung jawab. *Caring* juga merupakan dasar dalam melaksanakan praktek keperawatan profesional untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang dapat memberikan kepuasan pada klien dan keluarga.

B. Teori Caring

Dalam pelayanan keperawatan *caring* merupakan komponen umum, sebagai seorang perawat profesional penting memahami budaya klien. *Caring* bersifat sangat personal, sehingga pengungkapan *caring* pada tiap klien berbeda. Perawat perlu mempelajari budaya klien dan ungkapan *caring*, dalam memenuhi kebutuhan klien dalam memperoleh kesembuhan. *Caring* dapat membantu perawat dalam mengenal klien secara holistik, memahami masalah yang dihadapi dan dapat mencari solusi serta memberikan asuhan yang tepat.

Pendekatan teori *caring* dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan keperawatan, adapun teori – teori *caring* yang telah dikembangkan oleh pakar teori keperawatan sebagaimana dibawah ini:

1. Teori *Caring* menurut Jean Watson

Jean Watson mulai merintis teori *caring* pada manusia terkait metafisik dan transpersonalnya. Watson meyakini bahwa keperawatan lebih banyak menggunakan pendekatan eksistensial – fenomenologis untuk memadukan konsep kejiwaan dan transendensi. Jiwa adalah esensi dari seseorang, mengandung *geist* (roh atau kesan diri yang lebih tinggi), yang memiliki kesadaran, tingkat

kesadaran yang lebih tinggi, suatu kekuatan internal dan kekuatan yang dapat memperbesar kapasitas manusia serta memungkinkan seseorang untuk melebihi diri lazimnya. Transendensi mengacu pada kapasitas untuk eksis bersama dengan masa lalu, saat ini dan yang akan datang.

Transpersonal Human Caring dianggap baik sebagai ideal moral keperawatan maupun sebagai proses *caring*. Ideal moral berisi interaksi transpersonal dan intersubjektif dengan orang lain. Proses *caring* terdiri atas komitmen untuk melindungi, meningkatkan dan memulihkan humanitas dengan mengembalikan martabat, keselarasan bathin dan memfasilitasi penyembuhan. Perawat berperan untuk memberikan informasi pada orang lain, dan kesiapan untuk penyembuhan, yang memungkinkan mereka untuk meraih kembali rasa keselarasan bathin mereka.

Dasar teori watson adalah nilai dan penghormatannya yang sangat mendalam terhadap keajaiban dan misteri kehidupan, Watson mengakui adanya dimensi spiritual kehidupan dan keyakinan terhadap kekuatan internal proses perawatan dan penyembuhan. System ini dipadukan dengan sepuluh faktor karatif yang mencakup altruisme manusia, kepekaan terhadap diri dan orang lain, mencintai serta percaya akan hidup dan kekuatan bathin orang lain dan diri kita sendiri.

Watson mengidentifikasi asumsi dan prinsip holografis keperawatan transpersonal. Watson meyakini bahwa jiwa seseorang berada dalam tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagian dari asumsi Watson yang mendasari nilai-nilai asuhan manusia dalam keperawatan yaitu:

- a. Kasih sayang dan cinta merupakan kekuatan kosmik yang paling universal dan misterius yang tersusun atas energi psikis universal dan primal
- b. Setiap individu harus lebih menyayangi dan mencintai untuk memelihara humanitas mereka agar dapat bertahan hidup
- c. Hal yang penting sebelum seseorang bisa menghargai dan merawat orang lain dengan belas kasih yang penuh martabat sayangi dan cintai diri sendiri
- d. Esensi dari keperawatan dan merupakan fokus yang utama yang penyatu dalam praktik keperawatan adalah kasih sayang
- e. Meningkatnya penggunaan teknologi medis dan batasan birokrasi-manajerial institusi, peran merawat mungkin akan terancam dan mengalami penurunan dalam system layanan kesehatan
- f. Kontribusi moral, sosial dan ilmiah dalam keperawatan terhadap manusia dan masyarakat terletak pada komitmen yang ideal tentang perawatan manusia dalam teori, praktik dan penelitian.

Watson menerapkan beberapa prinsip holografis dasar kedalam perawatan transpersonal, yaitu:

- a. Kesadaran merawat-menyembuhkan yang utuh terkandung dalam suatu waktu perawatan tunggal.
- b. Merawat dan menyembuhkan adalah saling berhubungan dan berhubungan dengan manusia lain, lingkungan, dan dengan energy alam semesta yang lebih tinggi.
- c. Kesadaran merawat-menyembuhkan manusia atau sebaliknya dari perawat dikomunikasikan kepada orang yang mendapatkan perawatan
- d. Kesadaran merawat-menyembuhkan diberikan secara temporer dan spasial ; seperti kesadaran yang ada sepanjang waktu dan ruang

Watson mengungkapkan bahwa keperawatan adalah Ilmu tentang manusia tentang pengalaman sehat sakit serta penyembuhan yang diperantarai oleh transaksi perawatan manusia yang profesional, personal, ilmiah, estetik dan etik. Tujuan umum dari keperawatan yaitu meningkatkan pertumbuhan dan spiritual bagi diri sendiri dan orang lain juga untuk menemukan kekuatan bathin dan pengendalian diri seseorang. Didalam interaksi manusia transpersonal, perawat menggunakan sepuluh faktor perawatan sebagai pedoman dalam interaksi perawat-klien yang didasarkan pada kepekaan terhadap diri dan orang lain, yaitu:

- a. Membentuk nilai-nilai sistem humanistik dan altruistik
- b. Memelihara kejujuran dan harapan
- c. Menumbuhkan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain
- d. Meningkatkan hubungan kepedulian pada manusia yang membantu dan percaya
- e. Meningkatkan dan menerima ungkapan perasaan positif maupun negatif
- f. Menggunakan proses pemecahan masalah keperawatan yang kreatif
- g. Meningkatkan belajar mengajar transpersonal
- h. Menyediakan lingkungan yang mendukung, protektif, atau memperbaiki mental, fisik, sosiokultural dan spiritual
- i. Membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan kebutuhannya
- j. Memberikan keleluasaan kekuatan spiritual fenomenologikal-eksistensial spiritual.

Asumsi dasar teori Watson terletak pada 7 asumsi dasar yang menjadi kerangka kerja dalam pengembangan teori; yaitu:

- a. *Caring* dapat dilakukan dan dipraktikkan secara interpersonal.
- b. *Caring* meliputi faktor-faktor caratif yang dihasilkan dari kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
- c. *Caring* yang efektif akan meningkatkan status kesehatan dan perkembangan

individu dan keluarga.

- d. Respon caring adalah menerima seseorang tidak hanya sebagai seseorang berdasarkan kondisi saat ini tetapi seperti apa dia mungkin akan menjadi dimasa depannya.
- e. *Caring* environment, menyediakan perkembangan potensi dan memberikan keluasan memilih kegiatan yang terbaik bagi diri seseorang dalam waktu yang telah ditentukan.
- f. *Caring* lebih menekankan pada peningkatan kesehatan daripada pengobatan (*cure*). Praktek caring mengintegrasikan pengetahuan biopisikal dan perilaku manusia untuk meningkatkan kesehatan dan untuk membantu pasien yang sakit, dimana caring melengkapi *curing*.
- g. *Caring* merupakan inti dari keperawatan.

Nilai-nilai yang mendasari konsep caring menurut Jean Watson meliputi:

- a. Konsep tentang manusia

Manusia merupakan suatu fungsi yang utuh dari diri yang terintegrasi (ingin dirawat, dihormati, mendapatkan asuhan, dipahami dan dibantu). Manusia pada dasarnya mempunyai rasa ingin dimiliki oleh lingkungan sekitar dan menjadi bagian dari kelompok atau masyarakat, dan rasa dicintai dan rasa mencintai.

- b. Konsep tentang kesehatan

Kesehatan merupakan keutuhan dan keharmonisan pikiran fungsi fisik dan sosial. Menekankan fungsi pemeliharaan serta adaptasi untuk meningkatkan fungsi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kesehatan merupakan suatu keadaan terbebas dari keadaan penyakit, dan Jean Watson menekankan pada usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut.

- c. Konsep tentang lingkungan

Berdasarkan teori Jean Watson, caring dan nursing merupakan konstanta dalam setiap keadaan di masyarakat. Perilaku caring diwariskan berdasarkan pengaruh budaya sebagai strategi untuk melakukan mekanisme coping terhadap lingkungan tertentu bukan karena diwariskan oleh generasi sebelumnya.

- d. Konsep tentang keperawatan

Keperawatan berfokus pada promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan caring ditujukan untuk klien baik dalam keadaan sakit maupun sehat.

2. Teori *Caring* menurut Swanson

Teori *caring* Swanson masuk dalam *level middle range theory*, mempelajari tentang seorang perawat yang dapat merawat klien dengan tetap menghargai martabat klien tersebut dengan komitmen dan tanggungjawab yang tinggi. Teori

caring Swanson ini berkembang setelah Swanson melakukan riset terhadap 3 (tiga) studi perinatal yang terpisah, yaitu :

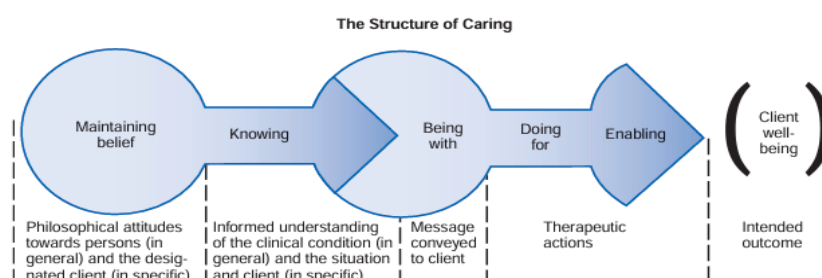
- a. studi pertama tentang pengalaman para wanita yang mengalami keguguran
- b. Studi kedua kepada para orang tua dan para professional kesehatan sebagai care giver di ruang newborn intensive care unit (NICU)
- c. Studi ketiga terhadap kelompok calon ibu dengan risiko tinggi.

The caring model mengembangkan 5 (lima) proses dasar, yaitu *knowing*, *being with*, *doing for*, *enabling* dan *maintaining belief*. Penjabaran 5 (lima) proses dasar ini bisa menjadi strategi untuk penerapan asuhan keperawatan yang dimulai dengan pengkajian sampai dengan evaluasi keperawatan. Dengan demikian caring mempunyai peran besar dalam pelaksanaan proses keperawatan. Kristen M. Swanson mampu memahami ruang lingkup *caring* secara keseluruhan dan pada saat yang sama menjelaskan dimensi spesifik dari keinginan seorang perawat untuk merawat klien.

Argumen merupakan bagian yang penting dalam kontribusinya untuk teori keperawatan dimana klien dipandang sebagai manusia yang utuh tidak terpisah-pisah. Hal yang menarik tentang pengertian klien ini adalah bahwa Swanson selalu menempatkan peran perawat dalam proses *becoming* tersebut, dimana perawat sebagai mitra dalam membantu klien untuk mencapai kesejahteraannya (*well being*).

Teori *caring* Swanson menyajikan permulaan yang baik untuk memahami kebiasaan dan proses dari karakteristik pelayanan. Teori *caring* Swanson menjelaskan tentang proses *caring* yang terdiri dari proses perawat memahami kejadian yang berarti di dalam hidup seseorang, hadir secara emosional, melakukan suatu hal kepada orang lain sama seperti melakukan terhadap diri sendiri, memberi informasi dan memudahkan jalan seseorang dalam menjalani transisi kehidupan serta menaruh kepercayaan seseorang dalam menjalani hidupnya.

Struktur *Caring* Swanson



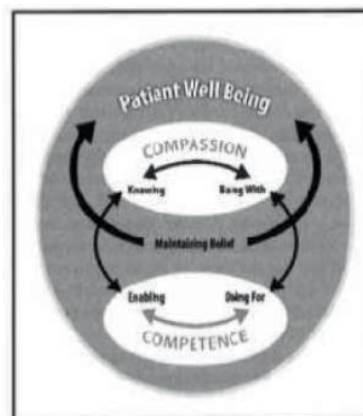
Gambar 1.1: Struktur Model Caring Menurut Swanson (1993)

Asumsi dasar dari teori ini ditemukan dalam gagasan *caring* yang dijelaskan Swanson, *Caring* adalah multifase yang selalu ada di dalam dinamika hubungan klien dan perawat. Ada yang melihat proses ini sebagai hubungan yang linear, namun juga harus dianggap sebagai hubungan siklik, dan proses yang terjadi haruslah terus diperbarui dimana perawat berperan dalam membantu klien untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan.

Secara umum, proses yang terjadi sebagai berikut, pertama perawat membantu klien mempertahankan keyakinannya, yang berarti bahwa perawat mendorong dan membantu klien untuk memperkuat harapan mereka dan mengatasi kesulitannya. Hal ini sangat penting terutama dalam kasus di mana klien menghadapi penyakit yang mengancam nyawa seperti kanker, atau peristiwa yang sangat traumatis seperti keguguran (Alligood & Tomey, 2010).

Sebagai pelengkap dan langkah berikutnya dalam proses untuk mempertahankan keyakinan, adalah *knowing*. Dalam proses *knowing*, perawat berusaha memahami situasi klien saat ini, karena ini bisa muncul untuk melatih perawat, yang menciptakan seseorang dengan rasa tertentu bagaimana kondisi fisik dan psikologis dapat mempengaruhi seseorang secara keseluruhan. Perawat bisa melanjutkan ke tahap proses *do for* apabila sudah tahu apa yang terjadi pada klien, lalu bisa memberikan intervensi pada klien. Proses *do for*, diikuti dengan proses *enabling* yang memungkinkan klien untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraannya (*well being*).

Swanson mengidentifikasi 3 tipe kondisi penyebab *caring*, yaitu klien, perawat dan organisasi. Kondisi organisasi meliputi beberapa komponen dari *Profesional Practice Model* (PPM) yaitu : (1) kepemimpinan, (2) kompensasi dan penghargaan, serta (3) Hubungan profesional. Apabila 3 komponen ini diciptakan dalam lingkungan kerja akan mendukung praktek *caring* dalam pelayanan (Tonges & Ray, 2011).



Gambar 1.2: Teori *Caring* Swanson : *Framing the Culture of Carolina Care* (Tonges & Ray, 2011)

Gambar diatas menunjukkan bahwa *knowing* dan *being with* sebagai wujud *compassion* (keharuan, kepedulian perawat terhadap emosi pasien atau empati, *responsiveness*, dan *respect*), sedangkan *enabling* dan *doing for* adalah untuk memperkuat pasien mampu memelihara dan merawat diri sendiri. *Maintenaining belief* adalah mempertahankan keyakinan pasien akan kesejahteraan/ kesehatan.

Komponen yang ada dalam struktur ini saling berintegrasi dan berhubungan dan tidak bisa berdiri sendiri, yang nantinya akan membentuk suatu perilaku caring. Hal ini adalah dasar dalam memelihara dan meningkatkan keyakinan dasar terhadap kehidupan manusia, memberi dukungan dengan mengetahui dan mengerti apa yang menjadi permasalahan klien. Selain itu juga harus menyampaikan permasalahan klien dengan memperhatikan aspek fisik dan emosional, melakukan tindakan keperawatan yang sesuai dengan kondisi aktual maupun potensial klien. Pada kenyataannya, knowing, being with, doing for, enabling, dan maintening belief adalah komponen penting dari setiap hubungan perawat-klien (Swanson, 1983).

C. Dimensi Caring

Dimensi caring menurut Swanson, ada lima dimensi yang mendasari konsep caring, yaitu:

1. Maintening belief

Maintening belief adalah kepekaan diri seseorang terhadap harapan yang diinginkan orang lain ataupun membangun harapan. Indikator yang terdapat pada kepekaan diri, yaitu:

- a. Rasa percaya diri yang tinggi
- b. Mempertahankan perilaku yang siap memberikan harapan orang lain
- c. Berfikir realistis
- d. Mendampingi klien dan siap memberikan bantuan.

Menumbuhkan keyakinan dalam diri seseorang melalui setiap peristiwa hidup dan masa transisi dalam hidupnya serta menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan, mempercayai kemampuan orang lain, menimbulkan sikap optimis, membantu menemukan arti atau mengambil hikmah dari setiap peristiwa, dan selalu ada untuk orang lain dalam situasi apapun. Tujuannya adalah untuk membantu orang lain supaya bisa menemukan arti dan mempertahankan sikap yang penuh harap. Memelihara dan mempertahankan keyakinan nilai hidup seseorang adalah dasar dari caring dalam praktik keperawatan.

Subdimensi dari *maintaining belief* antara lain:

- a. *Believing in*: perawat merespon apa yang dialami klien dan mempercayai

bahwa hal itu wajar dan dapat terjadi pada siapa saja yang sedang mengalami masa transisi.

- b. *Offering a hope – filled attitude*: memperlihatkan perilaku yang peduli pada masalah yang terjadi pada klien dengan sikap tubuh, kontak mata dan intonasi bicara perawat.
- c. *Maintaining realistic optimism*: menjaga dan memperlihatkan sikap optimisme perawat dan harapan terhadap apa yang dialami klien secara realistis dan berusaha mempengaruhi klien untuk punya sikap yang optimisme dan harapan yang sama.
- d. *Helping to find meaning*: membantu klien menemukan arti dari masalah yang dialami sehingga klien bisa secara perlahan menerima bahwa siapa pun bisa mengalami hal yang sama dengan klien.
- e. *Going the distance* (menjaga jarak): semakin jauh menjalin/menyelami hubungan dengan tetap menjaga hubungan sebagai perawat-klien agar klien bisa percaya sepenuhnya pada perawat dan responsibility serta *Caring* secara total oleh perawat kepada klien.

2. Knowing (mengetahui)

Perawat harus mengetahui kondisi klien, memahami arti dari suatu peristiwa dalam kehidupan, menghindari asumsi, fokus pada klien, mencari isyarat, menilai secara cermat dan menarik. Efisiensi dan efektivitas terapeutik *caring* ditingkatkan oleh pengetahuan secara empiris, etika dan estetika yang berhubungan dengan masalah kesehatan baik secara aktual dan potensial. Indikator *knowing* adalah:

- a. Mengetahui kebutuhan dan harapan klien
- b. Manfaat perawatan dan kejelasan rencana perawatan
- c. Hindari persyaratan untuk bertindak, karena perawat peduli klien
- d. Tidak hanya mengerti kebutuhan dan harapan tetapi fokus pada merawat yang benar atau efisien dan berhasil guna atau efektif.

Knowing adalah berusaha agar mampu mengetahui dan paham terhadap peristiwa yang mempunyai arti dalam kehidupan klien. Mempertahankan kepercayaan merupakan dasar dari *caring* keperawatan, *knowing* adalah memahami pengalaman hidup klien dengan mengesampingkan asumsi perawat mengetahui kebutuhan klien, menggali/menyelami informasi klien secara detail, sensitive terhadap petunjuk verbal dan non verbal, fokus pada satu tujuan keperawatan, serta mengikutsertakan orang yang memberi asuhan dan orang yang diberi asuhan dan menyamakan persepsi antara perawat dan klien. *Knowing* adalah penghubung dari keyakinan keperawatan terhadap realita kehidupan.

Subdimensi dari *knowing* antara lain :

- a. *Avoiding assumptions*, menghindari asumsi-asumsi

- b. *Assessing thoroughly*, melakukan pengkajian menyeluruh meliputi bio, psiko, sosial, spiritual dan kultural
- c. *Seeking clues*, perawat menggali informasi secara mendalam (4) *Centering on the one cared for*, perawat fokus pada klien dalam memberikan asuhan keperawatan
- d. *Engaging the self of both*, melibatkan diri sebagai perawat secara utuh dan bekerja sama dengan klien dalam melakukan asuhan keperawatan yang efektif

3. **Being with (Kehadiran)**

Being with merupakan kehadiran dari perawat untuk pasien, perawat tidak hanya hadir secara fisik saja, tetapi juga melakukan komunikasi membicarakan kesiapan/ kesediaan untuk bisa membantu serta berbagi perasaan dengan tidak membebani pasien. Perawat juga hadir dengan berbagi perasaan tanpa beban dan secara emosional bersama klien dengan maksud memberikan dukungan kepada klien, memberikan kenyamanan, pemantauan dan mengurangi intensitas perasaan yang tidak diinginkan.

Indikator saat merawat pasien adalah:

- a. Kehadiran kontak dengan pasien
- b. Menyampaikan kemampuan merawat
- c. Berbagi perasaan
- d. Tidak membebani pasien

Subdimensi dari *being with*, antara lain:

- a. *Non-burdening*: Perawat melakukan kerja sama kepada klien dengan tidak memaksakan kehendak kepada klien melaksanakan tindakan keperawatan
- b. *Convering availability*: Memperlihatkan sikap perawat mau membantu klien dan memfasilitasi klien dalam mencapai tahap kesejahteraan / *well being*.
- c. *Enduring with*: Perawat dan klien berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan klien.
- d. *Sharing feelings*: Berbagi pengalaman bersama klien yang berhubungan dengan usaha dalam meningkatkan kesehatan klien.

Being with perawat bisa diperlihatkan dengan cara kontak mata, bahasa tubuh, nada suara, mendengarkan serta mempunyai sikap positif dan semangat yang dilakukan perawat, bisa membuat suasana terbuka dan saling mengerti.

4. **Doing for (Melakukan)**

Doing for berarti bekerja sama melakukan sesuatu tindakan yang bisa dilakukan, mengantisipasi kebutuhan yang diperlukan, kenyamanan, menjaga privasi dan martabat klien.

Dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, perawat bisa memberikan kontribusi dalam pemulihan kesehatan (atau sampai meninggal dengan damai).

Perawat akan tampil seutuhnya ketika diperlukan dengan menggunakan semua kekuatan maupun pengetahuan yang dimiliki.

Subdimensi dari *doing for* antara lain:

a. *Comforting* (memberikan kenyamanan)

Dalam memberikan intervensi keperawatan perawat harus bisa memberi kenyamanan dan menjaga privasi klien.

b. *Performing competently* (menunjukkan ketrampilan)

Sebagai perawat profesional perawat dituntut tidak hanya bisa berkomunikasi tapi juga harus bisa memperlihatkan kompetensi maupun skill yang dimiliki seorang perawat yang profesional.

c. *Preserving dignity* (menjaga martabat klien)

Menjaga martabat klien sebagai individu atau memanusiakan manusia.

d. *Anticipating* (mengantisipasi)

Selalu meminta izin ataupun persetujuan dari klien ataupun keluarga dalam melakukan tindakan keperawatan.

e. *Protecting* (melindungi)

Menjaga hak-hak klien dalam memberikan asuhan keperawatan dan tindakan medis

5. *Enabling* (Memampukan)

Enabling adalah memampukan atau memberdayakan klien, perawat memberikan informasi, menjelaskan memberi dukungan dengan fokus masalah yang relevan, berfikir melalui masalah dan menghasilkan alternatif pemecahan masalah agar klien mampu melewati masa transisi dalam hidup yang belum pernah dialaminya sehingga bisa mempercepat penyembuhan klien ataupun supaya klien mampu melakukan tindakan yang tidak biasa dilakukannya. memberikan umpan balik / *feedback*. Subdimensi dari *enabling* antara lain:

a. *Validating* (memvalidasi)

Memvalidasi semua tindakan yang telah dilakukan

b. *Informing* (memberikan informasi)

Menyampaikan informasi yang berhubungan dengan peningkatan kesehatan klien dalam rangka memberdayakan klien dan keluarga klien.

c. *Supporting* (mendukung)

Memberi dukungan kepada klien untuk mencapai kesejahteraan / well being sesuai kapasitas sebagai perawat

d. *Feedback* (memberikan umpan balik)

Memberikan *feedback* kepada klien atas usahanya mencapai kesembuhan/*well being*,

e. *Helping patients to focus generate alternatives* (membantu klien untuk fokus

dan membuat alternatif)

Membantu klien agar selalu fokus dan ikut dalam program peningkatan kesehatannya baik tindakan keperawatan maupun tindakan medis (Potter & Perry, 2005)

Domain pertama mengacu pada kapasitas seseorang untuk memberikan perhatian, domain kedua mengacu pada kepedulian dan komitmen individu yang mengarah pada tindakan caring, domain ketiga mengacu pada kondisi (perawat, klien, organisasi) yang meningkatkan atau mengurangi kemungkinan memberikan acring, domain keempat mengacu pada tindakan caring, dan domain kelima mengacu pada konsekuensi atau hasil caring yang disengaja dan tidak disengaja pada klien dan penyedia layanan (Alligood & Tomey, 2010).

Setiap proses caring memiliki pengertian dan subdimensi yang menjadi dasar dalam intervensi keperawatan. Pelayanan keperawatan dan caring sangat penting untuk membuat hasil positif pada kesehatan dan kesejahteraan klien (Swanson, 1991).

Tabel 1.1: Dimensi dan subdimensi proses caring dari Swanson (1991)

Proses Caring	Definisi	Sub Dimensi
Mengetahui (<i>knowing</i>)	Berusaha mengerti kejadian yang berarti dalam kehidupan seseorang	▪ Menghindari asumsi ▪ Focus pada pelayanan satu orang ▪ Penialian menyeluruh ▪ Mencari petunjuk ▪ Mengikat diri atau keduanya
Melakukan bersama (<i>being with</i>)	Hadir secara emosional	▪ Berada disana ▪ Menunjukkan kemampuan ▪ Berbagi perasaan ▪ Tidak mudah marah
Melakukan untuk (<i>doing for</i>)	Sebisa mungkin melakukan kepada orang lain seperti melakukannya terhadap diri sendiri	▪ Kenyamanan ▪ Antisipasi ▪ Menunjukkan keterampilan ▪ Melindungi ▪ Menunjukkan kepercayaan

Kemampuan (<i>enabling</i>)	Memudahkan jalan seseorang dalam menjalani transisi kehidupan (seperti kelahiran, kematian) atau kejadian yang tidak terduga	▪ Memberitahukan/ menjelaskan ▪ Mendukung/ mengizinkan ▪ Focus ▪ Membuat alternative ▪ Membenarkan/ memberikan ▪ umpan balik
Mengatasi kepercayaan (<i>maintaining belief</i>)	Menaruh kepercayaan terhadap kemampuan seseorang dalam menjalani hidup atau transisi dalam menghadapi masa depan	▪ Kepercayaan/ memegang kepercayaan ▪ Mempertahankan sikap penuh pengharapan ▪ Menawarkan keyakinan yang realistis "pergi jauh"

Swanson menyatakan bahwa bentuk caring mungkin dapat diterapkan dalam disiplin lain seperti pendidikan, pekerjaan social dan kedokteran, dan dalam berbagai situasi kehidupan di luar keperawatan (Alligood & Tomey, 2010).

D. Komponen Caring

Swanson (1991) dalam *empirical development of a middle range theory of caring* mendeskripsikan 5 proses caring menjadi lebih praktis, yaitu:

1. Komponen mempertahankan keyakinan, mengaktualisasi diri untuk membantu orang lain, mampu membantu orang lain dengan tulus, memberikan ketenangan kepada klien dan memiliki sikap yang positif
2. Komponen pengetahuan, memberikan pemahaman klinis tentang kondisi dan situasi klien, melaksanakan setiap tindakan sesuai peraturan dan menghindari terjadinya komplikasi.
3. Komponen kebersamaan, ada secara emosional dengan orang lain, bisa berbagi secara tulus dengan klien dan membina kepercayaan terhadap klien
4. Komponen tindakan yang dilakukan, melakukan tindakan terapeutik seperti membuat klien merasa nyaman, mengantisipasi bahaya dan intervensi yang kompeten.
5. Komponen memungkinkan, melakukan *informed consent* pada setiap tindakan, memberikan respon yang positif terhadap keluhan klien (Monica, 2008)

E. Caring dalam Praktek Keperawatan

Caring merupakan hasil dari budaya, nilai – nilai, pengalaman dan hubungan perawat dengan klien. Perawat melaksanakan praktik pelayanan keperawatan yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan penyakit, maka kemampuan perawat dalam pelayanan akan semakin berkembang. Sikap perawat dalam praktik keperawatan yang berkaitan dengan *Caring* adalah dengan kehadiran, sentuhan kasih sayang, selalu mendengarkan dan memahami klien (Potter & Perry, 2009).

Kehadiran perawat adalah saat dimana perawat dan klien berinteraksi yang menjadi sarana agar lebih dekat dan bisa menyampaikan manfaat *caring*. Kehadiran perawat meliputi hadir secara fisik, berkomunikasi dengan pengertian. Kehadiran juga merupakan sesuatu yang ditawarkan perawat pada klien dengan tujuan memberikan dukungan, dorongan, menenangkan hati klien, mengurangi rasa cemas dan takut klien karena situasi tertentu, serta selalu ada untuk klien (Potter & Perry, 2009).

Sentuhan perawat merupakan salah satu cara pendekatan yang menenangkan, perawat bisa mendekatkan diri kepada klien agar bisa menunjukkan perhatian dan memberi dukungan. Sentuhan *caring* merupakan suatu bentuk komunikasi non verbal yang bisa mempengaruhi kenyamanan dan keamanan klien, meningkatkan harga diri klien, serta memperbaiki orientasi tentang kenyataan. Pengungkapan sentuhan harus berorientasi pada tugas dan dapat dilakukan dengan cara memegang tangan klien, memberikan pijatan pada punggung, menempatkan klien dengan hati – hati dan ikut serta dalam pembicaraan (Potter & Perry, 2009).

Komunikasi dengan klien harus benar – benar didengarkan oleh perawat. Mendengarkan merupakan kunci dari hubungan perawat dengan klien, karena dengan mendengarkan cerita atau keluhan klien akan membantu klien mengurangi tekanan terhadap penyakitnya. Hubungan pelayanan perawat dengan klien yaitu dengan membangun kepercayaan, membuka topik pembicaraan, mendengarkan dan mengerti apa yang klien katakan.

Perawat yang mendengarkan klien dengan sungguh – sungguh, akan mengetahui secara benar dan merespon apa yang benar – benar berarti bagi klien dan keluarganya (Potter & Perry 2009). Mendengarkan juga termasuk memberikan perhatian pada setiap perkataan yang diucapkan, nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh klien. Hal ini akan membantu perawat dalam mendapatkan petunjuk untuk membantu menolong klien mencari cara mendapatkan kedamaian. Bulfin (2005, dalam Potter & Perry, 2009) mengemukakan bahwa memahami klien akan membantu perawat dalam menanggapi persoalan yang terjadi pada klien. Memahami klien berarti perawat menghindari asumsi, fokus pada klien, dan ikut

serta dalam hubungan *caring* dengan klien yang memberikan informasi dan memberikan penilaian klinis.

Memahami klien adalah sebagai inti suatu proses yang digunakan perawat dalam membuat keputusan klinis. Perawat yang membuat keputusan klinis yang akurat dengan konteks pemahaman yang baik, akan meningkatkan hasil kesehatan klien, klien akan mendapatkan pelayanan pribadi, nyaman, dukungan, dan pemulihan.

F. Perilaku Caring

Caring merupakan inti dari praktik keperawatan yang baik, karena *Caring* bersifat khusus dan bergantung pada hubungan perawat - klien (Potter & Perry, 2009). *Caring* merupakan fasilitas perawat agar mampu mengenal klien, mengetahui masalah klien, mencari dan melaksanakan solusinya. Perilaku seorang perawat yang *Caring* terhadap klien, dapat memperkuat mekanisme *coping* klien sehingga memaksimalkan proses penyembuhan klien (Sitorus, 2006).

Caring adalah wujud dari semua faktor yang digunakan perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap klien (Watson, 1979 dalam Tomey & Alligood, 2006). Perilaku *caring* perawat dapat diwujudkan dalam pemberian pelayanan keperawatan pada klien, bila perawat dapat memahami pengertian *caring*, teori tentang *caring*, aplikasi *caring* dalam praktek keperawatan, memahami sepuluh faktor karatif *caring*, dan faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku *caring* perawat.

G. Faktor – factor yang Mempengaruhi Perilaku Caring

Caring merupakan aplikasi dari proses keperawatan sebagai bentuk kinerja yang ditampilkan oleh seorang perawat. Gibson, et.al (2006) mengemukakan 3 (tiga) faktor yang berpengaruh terhadap kinerja individu meliputi faktor individu, psikologis dan organisasi.

1. Faktor Individu

Variabel individu dikelompokkan pada subvariabel kemampuan dan keterampilan, latar belakang dan demografis. Menurut Gibson, et.al (2006), variabel kemampuan dan keterampilan adalah faktor penting yang bisa berpengaruh terhadap perilaku dan kinerja individu. Kemampuan intelektual merupakan kapasitas individu mengerjakan berbagai tugas dalam suatu kegiatan mental.

2. Faktor psikologis

Variabel ini terdiri atas sub variabel sikap, komitmen dan motivasi. Faktor ini banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, pengalaman dan karakteristik

demografis. Setiap orang cenderung mengembangkan pola motivasi tertentu. Motivasi adalah kekuatan yang dimiliki seseorang yang melahirkan intensitas dan ketekunan yang dilakukan secara sukarela. Variabel psikologis bersifat kompleks dan sulit diukur.

3. Faktor organisasi

Faktor organisasi yang bisa berpengaruh dalam perilaku *caring* adalah, sumber daya manusia, kepemimpinan, imbalan, struktur dan pekerjaan (Gibson, 2006). Kopelman (1986), variabel imbalan akan mempengaruhi variabel motivasi, yang pada akhirnya secara langsung mempengaruhi kinerja individu.

H. Faktor Pembentuk Perilaku Caring.

Menurut Watson (2005) faktor pembentuk perilaku caring yaitu:

1. Membentuk sistem nilai humanistik-altruistik.

Watson menyatakan bahwa asuhan keperawatan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan (humanistik) dan perilaku yang mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi (altruistik). Hal ini bisa dikembangkan melalui pemahaman nilai yang ada pada diri seseorang, keyakinan, interaksi, dan kultur serta pengalaman pribadi.

2. Menanamkan keyakinan dan harapan (*faith-hope*).

Pemahaman ini perlu untuk menekankan pentingnya obat-obatan untuk *curative*, perawat juga perlu menyampaikan informasi kepada individu tentang alternatif pengobatan lain yang ada. Mengembangkan hubungan perawat dan klien yang efektif, perawat mempunyai perasaan optimis, harapan, dan rasa percaya diri.

3. Mengembangkan sensitivitas untuk diri sendiri dan orang lain.

Perawat dituntut agar bisa meningkatkan sensitivitas terhadap diri pribadi dan orang lain serta bersikap lebih baik. Perawat juga perlu mengerti pikiran dan emosi orang lain.

4. Membina hubungan saling percaya dan saling membantu (*helping-trust*).

Ciri hubungan *helping-trust* adalah empati, dan hangat. Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilakukan secara jujur dan terbuka.

5. Meningkatkan dan menerima ungkapan perasaan positif dan negatif.

Perawat memberikan waktunya dengan mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien.

6. Menggunakan proses pemecahan masalah kreatif.

Penylesaian masalah dalam pengambilan keputusan perawat memakai metode proses keperawatan sebagai pola pikir dan pendekatan asuhan kepada pasien.

7. Meningkatkan belajar mengajar transpersonal.

Memberikan asuhan mandiri, menetapkan kebutuhan personal, dan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan personal pasien.

Memfasilitasi lingkungan yang suportif, protektif, atau memperbaiki mental, fisik, sosiokultural, dan spiritual. Perawat perlu tahu pengaruh lingkungan internal dan eksternal pasien terhadap kesehatan kondisi penyakit pasien.

8. Membantu memuaskan kebutuhan manusia.

Perawat perlu tahu kebutuhan komperhensif diri sendiri dan pasien. Pemenuhan kebutuhan paling dasar yang harus dicapai sebelum beralih ke tingkat selanjutnya.

I. Perilaku Caring dalam Praktek Keperawatan

Caring secara umum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk berdedikasi bagi orang lain, pengawasan dengan waspada, perasaan empati pada orang lain dan perasaan cinta atau menyayangi. *Caring* adalah sentral untuk praktik keperawatan karena caring merupakan suatu cara pendekatan yang dinamis, dimana perawat bekerja untuk bisa lebih peduli terhadap klien. Dalam keperawatan, caring adalah bagian inti yang penting terutama dalam praktik keperawatan (Sartika, 2010).

Tindakan *caring* mempunyai tujuan untuk bisa mmberikan asuhan fisik dengan memperhatikan emosi sambil meningkatkan rasa nyaman dan aman terhadap klien. *Caring* juga menekankan harga diri individu, artinya dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat harus selalu menghargai klien dengan menerima kelebihan maupun kekurangan klien sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang tepat.

Tiga aspek penting yang menjadi landasan keharusan perawat untuk care terhadap orang lain. Aspek ini adalah aspek kontrak, aspek etika, dan aspek spiritual dalam caring terhadap orang lain yang sakit.

1. Aspek kontrak

Sudah diketahui bahwa, sebagai perawat profesional, kita berada di bawah kewajiban kontrak untuk care. Radsma (1994) mengatakan, "perawat memiliki tugas profesional untuk memberikan care". Untuk itu, sebagai seorang perawat yang profesional haruslah mempunyai sikap care sebagai kontrak kerja kita.

2. Aspek etika

Pertanyaan etika adalah pertanyaan tentang apa yang benar atau salah, bagaimana mengambil keputusan yang tepat, bagaimana melakukan tindakan

dalam situasi tertentu. Jenis pertanyaan ini akan memengaruhi cara perawat memberikan asuhan. Seorang perawat haruslah *care* pada klien. Dengan *care* perawat dapat memberikan kebahagiaan bagi orang lain.

3. Aspek spiritual

Semua agama di dunia, ide untuk saling *caring* satu sama lain adalah ide utama. Oleh sebab itu perawat yang *religious* adalah orang yang *care*, bukan karena dia seorang perawat tapi lebih karena dia merupakan anggota suatu agama atau kepercayaan, perawat harus *care* terhadap klien.

Caring dalam praktik keperawatan dapat dilakukan dengan membina hubungan saling percaya antara perawat dan klien. Pengembangan hubungan saling percaya menerapkan bentuk komunikasi untuk menjalin hubungan dalam keperawatan. Perawat bertindak dengan cara yang terbuka dan jujur. Empati berarti perawat memahami apa yang dirasakan klien. Ramah berarti penerimaan positif terhadap orang lain yang sering diekspresikan melalui bahasa tubuh, ucapan penekanan suara, sikap terbuka, ekspresi wajah, dan lain-lain (Kozier & Erb, 1985 dalam Nurachmah, 2001).

Perawat perlu mengetahui kebutuhan komprehensif yaitu kebutuhan bio, psikososial, psikofisikal dan interpersonal klien. Pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar perlu dicapai sebelum beralih ke tingkat yang selanjutnya.

Perawat juga perlu menyampaikan informasi kepada klien. Perawat mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kesehatan klien. *Caring* memiliki manfaat yang begitu besar dalam keperawatan dan sebaiknya tergambar dalam setiap interaksi perawat dengan klien, bukan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diwujudkan dengan alasan beban kerja yang tinggi, atau pengaturan manajemen asuhan keperawatan ruangan yang kurang baik. Pelaksanaan *caring* bisa meningkatkan mutu asuhan keperawatan, memperbaiki *image* perawat di masyarakat dan menjadikan profesi keperawatan memiliki tempat khusus di mata para pengguna jasa pelayanan kesehatan.

J. Proses Keperawatan Berbasis *Caring*

Proses keperawatan mempunyai langkah- langkah yang sama dengan proses riset ilmiah, karena kedua proses tersebut mencoba untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi yang terbaik (Watson, 1979 dalam Muchlisin & Ichsan, 2008). Selanjutnya Watson menggambarkan kedua proses tersebut sebagai berikut:

1. Pengkajian

Meliputi observasi, identifikasi, dan review masalah; menggunakan pengetahuan dari literature yang bisa diaplikasikan, melibatkan pengetahuan konseptual untuk

pembentukan dan konseptualisasi kerangka kerja yang dipakai untuk memandang dan mengkaji masalah dan pengkajian juga meliputi pendefinisian variabel yang akan diteliti dalam pemecahan permasalahan Watson (1979 dalam Julia, 1995) menjelaskan kebutuhan yang harus dikaji oleh perawat yaitu:

- a. *Lower order needs (biophysical needs)* yaitu kebutuhan untuk tetap hidup meliputi kebutuhan nutrisi, cairan, eliminasi, dan oksigenisasi.
- b. *Lower order needs (psychophysical needs)* yaitu kebutuhan untuk berfungsi, meliputi kebutuhan aktifitas, aman, nyaman, seksualitas.
- c. *Higher order needs (psychosocial needs)*, yaitu kebutuhan integritas yang meliputi kebutuhan akan penghargaan dan berafiliasi.
- d. *Higher order needs (intrapersonal interpersonal needs)*, yaitu kebutuhan untuk aktualisasi diri.

2. Perencanaan

Perencanaan membantu dalam menentukan bagaimana variabel-variabel akan diteliti atau diukur, meliputi suatu pendekatan konseptual atau desain untuk pemecahan masalah yang mengacu pada asuhan keperawatan serta menentukan data apa yang akan dikumpulkan dan pada siapa dan bagaimana data akan dikumpulkan.

3. Implementasi

Merupakan tindakan langsung dan implementasi dari rencana serta meliputi pengumpulan data.

4. Evaluasi

Merupakan proses untuk menganalisa data, juga untuk menilai efek dari intervensi berdasarkan data serta meliputi interpretasi hasil, tingkat dimana suatu tujuan yang positif tercapai, dan apakah hasilnya bisa digeneralisasikan.

K. Pengukuran Perilaku *Caring*

Perilaku caring bisa diukur dengan beberapa alat ukur (*tools*) yang sudah dikembangkan oleh para peneliti yang membahas ilmu caring. Beberapa penelitian tentang caring bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Watson (2009) menyatakan bahwa pengukuran caring merupakan proses menurunkan subyektifitas, fenomena manusia yang bersifat invisible (tidak terlihat) yang terkadang bersifat pribadi, ke bentuk yang lebih obyektif. Oleh sebab itu, penggunaan alat ukur formal mampu mengurangi subyektifitas pengukuran perilaku caring.

Pemakaian alat ukur formal pada penelitian keperawatan tentang perilaku caring bertujuan untuk : memperbaiki caring secara terus menerus melalui penggunaan hasil (*outcomes*) dan intervensi yang berarti untuk memperbaiki praktik keperawatan; sebagai studi banding (*benchmarking*) struktur, setting, dan

lingkungan yang lebih menunjukkan caring; mengevaluasi konsekuensi caring dan non caring pada pasien maupun perawat.

Alat ukur formal *caring* bisa menghasilkan model pelaporan perawatan pada area praktik tertentu, menemukan kelemahan dan kekuatan proses caring dan melakukan intervensi dalam memperbaiki dan menghasilkan model praktik yang lebih sempurna. Selain itu, penggunaan alat ukur formal bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai hubungan caring, kesehatan dan proses kesembuhan dan sebagai validasi empiris untuk memperluas teori *caring* serta memberikan petunjuk baru bagi perkembangan kurikulum, keilmuan keperawatan, dan ilmu kesehatan termasuk penelitian (Watson, 2009).

Pengukuran perilaku *caring* perawat bisa dilakukan melalui pengukuran persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat. dengan menggunakan persepsi pasien dalam pengukuran perilaku caring perawat bisa memberikan hasil yang lebih sensitif karena pasien adalah individu yang menerima langsung perilaku dan tindakan perawat termasuk perilaku *caring* (Rego, Godinho, McQueen, 2008). Beberapa alat ukur formal yang digunakan untuk mengukur perilaku caring perawat didasarkan pada persepsi pasien antara lain *caring behaviors assesment tool* (digunakan oleh Cronin dan Harrison, 1988), caring behavior checklist and client perception of caring (digunakan oleh McDaniel, 1990), caring professional scale (digunakan oleh Swanson, 2000), caring assesment tools (digunakan oleh Duffy, 1992, 2001), caring factor survey (digunakan oleh Nelson, Watson, dan Inovahelath, 2008).

Caring behaviors assesment tool (CBA) dikatakan sebagai salah satu alat ukur pertama yang dikembangkan untuk mengkaji caring. CBA disempurnakan didasari dari teori Watson dan memakai 10 faktor karatif. CBA terdiri dari 63 perilaku caring perawat yang dikelompokkan menjadi 7 subskala yang disesuaikan 10 faktor karatif Watson. Tiga faktor karatif pertama dikelompokkan menjadi satu subskala. Enam faktor karatif lainnya mewakili semua aspek dari caring. Alat ukur ini memakai skala Likert (5 poin) yang merefleksikan derajat perilaku caring menurut persepsi pasien (Watson, 2009).

Validitas dan reliabilitas alat ukur ini telah diuji oleh empat ahli berdasarkan teori Watson. Cronin dan Harrison (1988 dalam Watson, 2009) melakukan penelitian terhadap 22 pasien infark miokard, kemudian Huggins et.al (1993 dalam Watson, 2009) meneliti 288 pasien ruang emergensi. Mereka menggunakan Alpa Cronbach pada 7 subskala yang berkisar antara 0,66 sampai 0.90. Selain itu, Schultz, et.al. (1999 dalam Watson 2009) menggunakan alat ukur ini dengan tes reliabilitas dengan kisaran 0.71 sampai 0,88 pada subskala, dan Alpa Cronbach 0.93 pada skala total.

Penelitian terbaru oleh Manogin, Bechtel, dan Rami (2000 dalam Watson, 2009) menggunakan CBA, mereka melaporkan reliabilitas *Alpa Cronbach* tiap subskala berkisar dari 0,66 sampai 0.90. Cronin dan Harrison (1988 dalam Watson 2009) mengidentifikasi dua perilaku caring paling penting menurut pasien yaitu "membuat saya merasa sebagai seseorang jika saya membutuhkan mereka", dan "tahu apa yang mereka lakukan". Sedangkan perilaku caring yang paling tidak penting menurut pasien ialah "datang kepada saya ketika saya pindah ke rumah sakit lain" dan "bertanya kepada saya apa nama panggilan kesukaan saya". Ini menunjukkan bahwa perilaku caring yang paling penting menurut pasien yaitu bagaimana perawat menunjukkan kemampuan profesionalnya.

Alat ukur *caring behavior checklist* (CBC) and *client perception of caring* (CPC) dikembangkan oleh McDaniel (1990 dalam Watson 2009) melalui dua jenis pengukuran. McDaniel membedakan "*caring for*" dan "*caring about*". CBC dirancang untuk mengukur ada atau tidak perilaku caring (observasi). CPC adalah kuesioner yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui respon pasien terhadap perilaku caring perawat.

Dua alat ukur ini digunakan bersama-sama untuk melihat proses caring. CBC terdiri dari 12 item perilaku caring. Alat ukur ini membutuhkan seorang observer yang menilai interaksi perawat-pasien selama 30 menit. Rentang nilai 0 (nol) sampai 12 (dua belas), nilai paling tinggi menunjukkan ada perilaku caring yang ditampilkan. CPC ditunjukkan kepada pasien setelah diobservasi. Alat ukur ini terdiri dari 10 item dengan 6 rentang skala. Rentang skor 10 sampai 60, dimana skor tertinggi menunjukkan derajat perilaku caring yang ditunjukkan yang dipersepsikan pasien bernilai tinggi, begitu juga sebaliknya (McDaniel, 1990 dalam Watson, 2009).

Validitas CBC memakai *Content Validity Index* (CVI) yakni sebesar 0,80. Reliabilitas CPC menggunakan konsistensi internal yaitu alfa sebesar 0.81. reliabilitas CBC memakai pernyataan interater dan dihasilkan nilai rentang 0,76 sampai 1,00, dimana 8 dari 12 item adalah 0,90 atau di atas rata-rata (McDaniel, 1990 dalam Watson, 2009).

Alat ukur *caring professional scale* (CPS) disempurnakan oleh Swanson (2000, dalam Watson 2009) dengan menggunakan teori caring Swanson (suatu middle range theory yang dikembangkan berdasarkan penelitiannya pada 185 ribu yang mengalami keguguran). CPS terdiri dari dua subskala analitik yaitu *Compassionate Healer* dan *Competent Practitioner*, yang berasal dari 5 komponen caring Swanson yaitu mengetahui, keberadaan, melakukan tindakan, memampukan, dan mempertahankan kepercayaan.

CPS terdiri dari 14 item dengan 5 skala Likert. Validitas dan reliabilitas CPS dikembangkan dengan menghubungkan alat ukur CPS dengan subskala empati The

Barret-Lenart Relationship Inventory ($r=0,61$, $p<0,001$). Nilai estimasi Alpa Cronbach untuk konsistensi internal digunakan untuk membandingkan beberapa tenaga kesehatan advance practice nurse (0,74 sampai 0,96), nurse (0,97), dan dokter (0,96).

Alat ukur *caring assesment tools (CAT)* dikembangkan oleh Duffy (1990 dalam Watson, 2009) pada program doktoralnya. Alat ukur ini dirancang untuk

penelitian deskriptif korelasi. CAT memakai konsep teori Watson dan mengukur 10 faktor karatif. Alat ukur ini terdiri dari 100 item dengan menggunakan skala Likert dari 1 (caring rendah) sampai 5 (caring tinggi), sehingga kemungkinan skor total berkisar antara 100 samapai 500. Sampel penilitian yang digunakan saat itu adalah 86 pasien medikal bedah. Duffy (1993 dalam Watson 2009) mengembangkan CAT versi admin (CAT-admin) yang mengukur persepsi perawat mengenai manajer mereka untuk administrasi riset keperawatan. Alat ukur ini menambahkan pertanyaan kualitatif pada versi CAT original, dan masih menggunakan 10 faktor karatif. CAT-admin diuji pada 56 perawat part-time dan full-time, dan didapatkan nilai Alpa Cronbach sebesar 0,98. lalu pada tahun 2001, CAT dikembangkan oleh Duffy ke versi CAT-edu yang dirancang menggunakan pendidikan keperawatan, dengan sampel 71 siswa program sarjana dan magister. CAT-edu terdiri dari 95 item pertanyaan dengan 5 poin skala Likert. Nilai Alpa Cronbach sebesar 0,98.

Caring factor survey (CFS) merupakan alat ukur terbaru yang menguji hubungan caring dan cinta universal (caritas). Caritas merupakan pandangan baru Watson tentang caring (2008). CFS mengkaji penggunaan caring fisik, mental, dan spiritual yang dilaporkan oleh pasien yang mereka lewat. CFS disempurnakan oleh Karen Drenkard, John Nelson, Gene Rigotti dan Jean Watson dengan bantuan program riset dari Inovahealth di Virginia. Alat ukur ini pada awalnya terdiri 20 item lalu diperkecil menjadi 10 item pertanyaan, tiap pernyataan mewakili satu proses caritas. CFS menggunakan skala Likert dari 1 sampai 7. Skala terendah (1-3) mengindikasi tidak setuju, 7 sangat setuju, dan 4 netral. Semua item pertanyaan bersifat positif, ditujukan kepada pasien atau keluarga pasien. Nilai *Alpa Cronbach* pada 20 pernyataan adalah 0,70 kemudian 20 item tersebut diperkecil menjadi 10 item untuk menaikkan nilai *Alpa Cronbach* (Watson, 2009).

Instrumen *Caring Swanson* sebagaimana table di bawah ini:

Tabel. 1.2: Instrumen *Caring Swanson*

NO	PERNYATAAN	YA	TIDAK	SCORE
<i>Maintaining belief</i>				
1.	Perawat memperkenalkan diri pada pasien			

2.	Perawat menemui pasien untuk menawarkan bantuan (misalnya; menghilangkan rasa sakit, memberikan kompres, dll)			
3.	Perawat membantu pasien membangun hasil akhir yang realistis/ nyata			
4.	Perawat menunjukkan perhatian kepada pasien (menanyakan keadaan/ keluhan yang dirasakan saat menemui pasien)			
Knowing				
5.	Perawat melibatkan keluarga pasien atau orang yang dianggap berarti ke dalam perawatan pasien			
6.	Perawat menjelaskan kepada pasien dan keluarga, terutama mereka yang bertanggungjawab			
7.	Perawat melakukan penilaian/ pengkajian tentang kondisi pasien secara menyeluruh			
8.	Perawat menanyakan apa yang dirasakan pasien dan apa yang bisa perawat lakukan untuk membantu Pasien			
9.	Perawat melakukan pendekatan yang konsisten pada pasien			
Being With				
10.	Perawat senantiasa mendampingi pasien saat pasien membutuhkan			
11.	Perawat melakukan proses keperawatan pada pasien dgn kemampuan yang kompeten			
12.	Perawat suka mendengarkan keluhan, perasaan, dan masukan dari pasien			

13.	Perawat menunjukkan sikap sabar dalam melakukan proses keperawatan pada pasien			
14.	Perawat memberikan kenyamanan yang mendasar seperti ketenangan (control suara), selimut yang memadai dan tempat tidur yang bersih			
15.	Perawat menyarankan kepada pasien untuk memanggilnya apabila pasien mengalami kesulitan/ menemui masalah			
16.	Perawat melakukan tindakan sesuai profesional dalam penampilannya sebagai perawat profesional			
17.	Perawat memberikan perawatan dan pengobatan pada pasien dengan tepat waktu, sesuai SOP yang ada			
18.	Perawat menghormati hak-hak pasien			
19.	Perawat membantu pasien memberikan kesempatan untuk memandirikan pasien dalam mengatasi masalah			
20.	Perawat memberikan motivasi pasien untuk berfikir positif tentang kondisi sakitnya			
21.	Perawat selalu mendahulukan kepentingan pasien			
22.	Perawat mengajarkan pada pasien cara untuk merawat diri sendiri setiap kali memungkinkan			
23.	Perawat mendiskusikan kondisi pasien dan memberikan unpan balik pada pasien			

L. Latihan

Studi kasus:

Ibu M., seorang wanita berusia 53 tahun, dengan riwayat diabetes tipe I dan diagnosis medis infark miokard akut, dirawat di unit perawatan intensif jantung 2 hari yang lalu. Saat perawat A, dinas di shift malam. Perawat A menyapa klien, memperkenalkan dirinya, dan menulis namanya di papan tulis di samping tempat tidur klien.

Perawat A, memperhatikan wajah klien yang sedih dan detak jantungnya yang cepat. Klien mencoba menyembunyikan air matanya. Perawat A, memantau tekanan darahnya dengan hasil 165/100 mmHg, menaikkan pegangan tempat tidur, dan mulai berbicara dengan klien. Perawat A, dengan ramah meminta klien untuk berbicara dengannya.

Klien menyatakan bahwa dokter meminta angiografi untuknya tetapi klien tidak tahu bagaimana angiografi dilakukan dan efek sampingnya. Perawat A, memegang tangan klien setelah meminta izin, menatap mata klien, dan menjelaskan tentang angiografi. Perawat A, juga mengirimkan video edukasi tentang angiografi dari ponselnya ke ponsel klien. Kemudian mereka menontonnya bersama dan sambil menonton, perawat menjelaskan beberapa hal kepada klien dan menjawab pertanyaan klien.

Klien juga khawatir tentang putrinya yang berusia 9 tahun yang tidak menemuinya selama 2 hari. Ibu M mengatakan ini kepada perawat dengan mata berkaca-kaca. Perawat mendengarkan kekhawatirannya, bertanya apakah dia ingin berbicara dengan putrinya, dan kemudian, berkoordinasi dengan pasangan klien, perawat memberikan kemungkinan kontak video dengan putri klien.

Setelah itu, klien memegang tangan perawat dan berkata: "Terima kasih. Anda mengajari saya dengan sangat baik. Saya berharap Anda selalu ada di sini. Saya sangat senang melihat wajah putri saya dan mendengar suaranya. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda."

Berdasarkan kasus diatas jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memilih satu jawaban yang tepat.

1. Saat bertemu dengan klien (Ibu M) perawat menyapa klien, memperkenalkan dirinya, dan menulis namanya di papan tulis di samping tempat tidur klien, merupakan perilaku perawat dalam menerapkan.....
 - A. Perilaku *cure*
 - B. Perilaku *care*
 - C. Perilaku sehat
 - D. Komunikasi interpersonal
 - E. Komunikasi terapeutik

2. Perawat A, memperhatikan wajah klien yang sedih dan detak jantungnya yang cepat. Klien mencoba menyembunyikan air matanya. Perawat A melakukan observasi untuk memantau tekanan darahnya dengan hasil 165/100 mmHg, menaikkan pegangan tempat tidur, dan mulai berbicara dengan klien, dengan ramah meminta klien untuk berbicara dengannya. Tindakan yang dilakukan oleh perawat merupakan tahapan dari proses keperawatan, pada tahap
 A. Pengkajian
 B. Diagnosa keperawatan
 C. Intervensi keperawatan
 D. Implementasi keperawatan
 E. Evaluasi keperawatan
3. Perawat A, ***memegang tangan klien setelah meminta izin***, menatap mata klien, dan menjelaskan tentang angiografi. Tindakan yang dilakukan perawat merupakan.....
 A. Perilaku Cure
 B. Perilaku Care
 C. Perilaku sehat
 D. Komunikasi Interpersonal
 E. Komunikasi terapeutik
4. Perawat A, mengirimkan video edukasi tentang angiografi dari ponselnya ke ponsel klien. Kemudian mereka menontonnya bersama dan sambil menonton, perawat menjelaskan beberapa hal kepada klien dan menjawab pertanyaan klien. Tindakan yang dilakukan oleh perawat merupakan tahapan dari proses keperawatan, pada tahap
 A. Pengkajian
 B. Diagnosa keperawatan
 C. Intervensi keperawatan
 D. Implementasi Keperawatan
 E. Evaluasi keperawatan
5. Ibu M mengatakan khawatir tentang putrinya yang berusia 9 tahun yang tidak menemuinya selama 2 hari. Ibu M mengatakan ini kepada perawat dengan mata berkaca-kaca. Perawat mendengarkan kekhawatirannya, bertanya apakah dia ingin berbicara dengan putrinya, dan kemudian, berkoordinasi dengan pasangan klien, perawat memberikan kemungkinan kontak video dengan putri klien. Tindakan yang dilakukan oleh perawat merupakan.....

- A. Perilaku cure
- B. Perilaku care
- C. Perilaku sehat
- D. Komunikasi interpersonal
- E. Komunikasi terapeutik

Jawablah dengan singkat pertanyaan dibawah ini

1. Apakah pengertian caring ?
2. Sebutkan tahapan structure caring berdasarkan teori Swanson ?
3. Apakah yang dimaksud *Human Caring* menurut Watson ?
4. Jelaskan dimensi dan komponen caring ?
5. Sebutkan factor yang mempengaruhi dan membentuk perilaku caring

M. Kunci Jawaban

1. E (komunikasi terapeutik)
2. A (pengkajian)
3. B (perilaku caring)
4. D (implementasi keperawatan)
5. B (perilaku care)

N. Rangkuman Materi

Caring adalah sikap kepedulian perawat terhadap klien dalam pemberian asuhan keperawatan dengan cara merawat klien dengan kesungguhan hati, keikhlasan, penuh kasih sayang, baik melalui komunikasi, pemberian dukungan, maupun tindakan secara langsung. *Caring* merupakan ideal moral keperawatan yang dalam penerapannya pada klien diperlukan pengembangan pengetahuan, ketrampilan, keahlian, empati, komunikasi, kompetensi klinik, keahlian teknik dan ketrampilan interpersonal perawat, serta rasa tanggung jawab. *Caring* juga merupakan dasar dalam melaksanakan praktek keperawatan profesional untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang dapat memberikan kepuasan pada klien dan keluarga.

Pendekatan teori *caring* dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan keperawatan, teori *caring* yang telah dikembangkan oleh pakar teori keperawatan antara lain; Teori *Human Caring* yang dikembangkan oleh Jean Watson, *human caring* merupakan hasil upaya perawat untuk merawat klien secara dinamis melalui perpaduan antara ilmu pengetahuan, seni, dan spiritualitas. Jenis perawatan ini bersifat lebih subjektif dan memerlukan interaksi transpersonal dan moral antara perawat dan klien sebagai dua manusia dengan kondisi yang berbeda.

Human caring mendorong keharmonisan antara tubuh dan jiwa, dan mengembangkan spiritualitas baik pada klien dan perawat, memberikan kesejahteraan dan kenyamanan yang optimal bagi klien, dan meningkatkan empati dan rasa hormat terhadap hak, privasi, dan keselamatan klien, serta mendorong etika perawatan.

Teori *caring* Swanson, menyatakan bahwa perawatan berlangsung dalam 5 (lima) tahapan: mempertahankan keyakinan (*maintaining belief*), mengetahui (*knowing*), bersama (*being with*), melakukan untuk (*doing for*), dan memungkinkan (*enabling*). Ketika diterapkan pada praktik keperawatan, masing-masing dari lima tahap ini meningkatkan sikap *caring* perawat dan meningkatkan kesejahteraan klien secara keseluruhan. Teori ini bertujuan membantu perawat untuk memberikan perawatan yang mempromosikan martabat, rasa hormat, dan pemberdayaan. Model ini bertujuan untuk memastikan perilaku *caring* perawat yang konsisten akan meningkatkan kepuasan pasien.

Tiga aspek penting yang menjadi landasan perilaku *caring* perawat terhadap klien. Aspek ini adalah kontrak, etika, dan spiritual dalam perilaku *caring* perawat terhadap klien yang sehat maupun sakit. *Caring* dalam praktik keperawatan dapat dilakukan dengan membina hubungan saling percaya antara perawat dan klien. Perawat bertindak dengan cara yang terbuka dan jujur. Memahami apa yang dirasakan klien (empati). Penerimaan positif terhadap orang lain (ramah) yang sering diekspresikan melalui bahasa tubuh, ucapan penekanan suara, sikap terbuka, dan ekspresi wajah.

O. Glosarium

-
- Caring*** : Sikap atau perilaku sepenuh hati yang diberikan perawat kepada klien dengan rasa peduli, perhatian dan memperhatikan emosi pasien untuk menciptakan hubungan terapeutik.
- Carative*** : Filosofi dan teori tentang human caring
- Curing*** : Penyembuhan atau pemulihan dari suatu penyakit
- Empati** : Kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain.
- Human Caring*** : Upaya perawat untuk merawat klien dengan penuh kasih sayang, rasa hormat, dan kepercayaan. Perpaduan antara ilmu pengetahuan, seni, dan spiritualitas
- Perawat** : seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perilaku : Tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau organisme dalam menanggapi rangsangan. Dapat terjadi secara sadar atau tidak sadar, dan dapat diamati secara langsung.

P. Daftar Pustaka

- Afifah,Efy. Konsep Caring. Diambil dari <http://staff.ui.ac.id/> diakses pada 19 November 2024. Pukul 15.00 WIB.
- Agustin. (2002). Perilaku caring perawat dan hubungannya dengan kepuasan klien di instalasi rawat inap bedah dewasa RS Dokter Muhamad Hosein Palembang. Tesis. Program Magister FIK UI. Tidak diperjualbelikan
- Asmuji (2012) Manajemen Keperawatan: Konsep dan Aplikasi. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Bauk, Kadir, Saleh, (2013). Hubungan Karakteristik Pasien dengan Kualitas Pelayanan: Persepsi Pasien Pelayanan Rawat Inap RSUD Majene.
- Beck,M.(2010).WallStreetJournal.Available.<http://online.wsj.com?article/SB1000142405270230410504575560081847852618.html> (accessed September 2023).
- Chritensen, Paula, J. & Kenney Janet.W. *Proses Keperawatan Aplikasi Model Konseptual*: Edisi 4. Jakarta : EGC
- Dedi, B., & Afiyanti, Y. (2008). *Perilaku Caring Perawat Pelaksana Di Sebuah Rumah Sakit Di Bandung* : Studi Grounded Theory. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 40–46.
- Dwidiyanti, M. (2007). *Caring kunci sukses perawat*. Semarang: Hasani. George, J.B. (1990). *Nursing theories: The base for profesional nursing practice*, 3 rd Ed. New Jersey: Prentice Hall.
- Gibson, J.L., Ivancevich, J.M. & Donelly, J.H. (1997). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Edisi Kedelapan. Terjemahan. Jakarta: Binarupa Aksara
- Glembocki, M.M.,& Dunn, K.S. (2010). *Building an organizational culture of caring: Caring Perceptions enhanced with education*. The Journal of Continuing Education in Nursing Vol 41, No [12](http://proquest.umi.com/pqdweb?SQ=caring+behavior+and+patient+satisfaction&DBId1). <http://proquest.umi.com/pqdweb?SQ=caring+behavior+and+patient+satisfaction&DBId1>.Diperoleh 28 September 2023.
- Jonirasmanto. (2009). *Mutu Pelayanan Kesehatan ; Ambivalensi Antara Kewajiban dan Keinginan* (antara penyelenggara dan pemilik). <http://artikelindonesia.com/hal-mutu-pelayanan-rumah-sakit.html>
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A. J., & Snyder. (2011). *Fundamental Keperawatan*. Edisi 4. Jakarta EGC.
- Leininger, Madeleine M. (1981). *Caring; an Essential Human Need: Proceedings of*

- Three National Caring. Michigan: Wayne State University Press
- Muninjaya AAG. 2004. *Manajemen Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Ilmu perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurachmah, E. (2000). *How nurses express their caring behavior to patients with spesialist need. Jurnal Keperawatan Indonesia*
- Nursalam. (2014). *Manajemen keperawatan aplikasi dalam praktik keperawatan profesional edisi 4*. Jakarta : Salemba Medika.
- Ozan, Y. D. (2015). Implementation of Watson ' s Theory of Human Caring : A Case Study, 8(1), 25–36.
- Özlü, Z. K. (2015). Evaluation of Satisfaction with Nursing Care of Patients Hospitalaized in, 8(1), 19–24.
- Porter, C. a, Cortese, M., Vezina, M., & Fitzpatrick, J. J. (2014). Nurse Caring Behaviors Following Implementation of a Relationship Centered Care Professional Practice Model. *International Journal of Caring Sciences*, 7(3), 818–822.
- Potter, P. A. & Perry A. G. (2005). *Fundamentals of Nursing : Concepts, Process, and Practice*. 6th Ed. St. Luoio, MI : Elsevier Mosby.
- Potter, P.A & Perry,A.G (2009) *Fundamental of nursing, 7th edition*. Singapore: Elsevier.
- PPNI (2017). *Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI).
- Rafli, F., Hajinezhad, M. E., & Haghani, H. (2008). Nurse caring in Iran and its relationship with patient satisfaction. *Australian Journal of Advanced Nursing*, 26(2), 75–84. . Diperoleh pada tanggal 19 September 2016.
- Rhodes JE, Lowe SR, Schwartz SEO. Mentor Relationships. In: Prinstein BBBJ, editor. *Encyclopedia of Adolescence*. San Diego: Academic Press; 2011. p. 196-204.
- Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2008). *Perilaku organisasi*, Edisi kesepuluh. Jakarta : PT
- Sabarguna, B. (2005). *Analisis Pemasaran Rumah Sakit*. Yogyakarta : Konsorium Rumah Sakit Islam JATENG-DIY.
- Sartika, Nanda. (2011) *Konsep Caring*. Diambil dari <http://www.pedoman.news.com>. Diakses pada 20 November 2013 pukul 16.10 pm.
- Suarli, S dan Bahtiar. (2012). *Manajemen keperawatan dengan pendekatan praktis*. Jakarta: Erlangga.
- Swanson. (1993). Nursing as Informed caring for the Well Being of Others. *IMAGE:Journal of Nursing Scholarship*. 25(4). Retrieved from <http://www.son.washington.edu/>
- Tawi, Mirza. (2008). *Hak Pasien dan Perawat*. <http://syehaceh.wordpress.com/2008/06/18/hak-pasien-dan-perawat/>.

[Online : 13 Oktober 2022).

Theofanidis, D. (2015). Nursing and Caring : An Historical Overview from Ancient Greek Tradition to Modern Times, *8*(3), 791–800.

Tjiptono, Fandy dan Chandra, Gregorius, (2004). Service, Quality Satisfaction. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Tomey, A.M., & Alligood, M. R. (2006). *Nursing theorist and their work* (sixth,ed.). St. Louis : The C.V Mosby Elsevier.

Tomey, A.M., & Alligood, M. R. (2006). *Nursing theory utilization & aplication*. St. Louis : The C.V Mosby Elsevier.

Tomey, AM, Alligood, MR.Nursing Theorist. Six Edition. Mosby : US Of Amerika.
<http://www.rnjournal.com/journalofnursing/caring.html>.

Tonges, M., & Ray, J. (2011).Tranlating Caring Theory into Practice. *Journal of Nursing Administration*.

Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5612.

Widayat R . (2009). *Hospital Organitation*. Yogyakarta : Andi Offset

BAB 2

ETIK DAN LEGAL DALAM KEPERAWATAN

Tujuan Instruksional:

- Menjelaskan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan aspek legal berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang mengatur praktik keperawatan.
- Meningkatkan pemahaman mahasiswa keperawatan mengenai pentingnya pendokumentasian yang akurat dan lengkap.
- Memahami dilema etik yang mungkin dihadapi perawat dalam praktik sehari-hari juga merupakan bagian penting dari tujuan instruksional.
- Memahami berbagai regulasi yang mengatur praktik keperawatan, termasuk hak-hak pasien dan tanggung jawab perawat.
- Memahami aspek-aspek perlindungan hak-hak pasien dan perawat itu sendiri.

Capaian Pembelajaran:

CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah	
CPL	Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau keluarga/pendamping/ penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya (KK-9)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK	Bila diberikan pengalaman pembelajaran di kelas, mahasiswa mampu mengintegrasikan (C4) pengetahuan, sikap dan ketrampilan praktik dan aktifitas (1) caring dalam kehidupan sehari-hari, (2) standar pelayanan profesional keperawatan sebagai bagian integral dalam system pelayanan kesehatan, (3) interprofesional education dan interpersonal collaboration dan (4) prinsip-prinsip etik dan legal dalam keperawatan
Sub-CPMK 1	1. Menjelaskan konsep caring dalam kehidupan sehari-hari
Sub-CPMK 2	2. Menjelaskan Standar profesional dalam pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dalam sistem pelayanan Kesehatan
Sub-CPMK 3	3. Menjelaskan Interprofesional education dan interpersonal collaboration
Sub-CPMK 4	4. Menjelaskan Prinsip-prinsip etik dan legal pada pengambilan keputusan dalam konteks keperawatan

A. Pendahuluan

1. Definisi Etik dalam Keperawatan

Etik dalam keperawatan adalah suatu sistem nilai dan prinsip yang mengatur perilaku profesional perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Etik tidak hanya terbatas pada kewajiban moral tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum dan profesionalisme dalam praktek keperawatan. Dalam hubungan ini, pemahaman tentang kode etik profesi keperawatan menjadi sangat penting karena kode etik ini berfungsi sebagai pegangan bagi perawat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Tedjomuljo dan Afifah menunjukkan bahwa mahasiswa keperawatan memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai kode etik profesi, meskipun kekurangan dalam pemahaman tentang aspek caring (Tedjomuljo & Afifah, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan keperawatan perlu lebih menekankan pentingnya edukasi tentang kode etik dan penerapannya dalam praktik sehari-hari. Selain itu, Latif menegaskan bahwa sikap perawat yang positif berhubungan erat dengan motivasi mereka melaksanakan praktik keperawatan profesional (Latif, 2023). Ini menunjukkan bahwa pemahaman etik yang baik dapat meningkatkan motivasi dan kinerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan.

Etik dalam keperawatan juga berkaitan dengan masalah tanggung jawab hukum. Setiani menjelaskan bahwa perawat harus melakukan praktik keperawatan sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik yang telah ditetapkan untuk menghindari masalah hukum akibat kelalaian atau kesalahan tindakan keperawatan yang telah dilakukan oleh perawat (Setiani, 2018). Hal ini menunjukkan pelatihan dan pendidikan yang tepat diperlukan pada seorang perawat dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip etik dan hukum pada pekerjaannya.

Dilema etik seringkali dihadapi perawat dalam situasi klinis yang kompleks. Penelitian oleh Ose mengungkapkan bahwa perawat sering kali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus membuat keputusan sulit, terutama dalam merawat pasien yang terlantar (Ose, 2017). Dalam konteks ini, perawat dituntut untuk tetap profesional dan bertanggung jawab, meskipun situasi yang dihadapi tidak ideal. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang etik sangat penting untuk membantu perawat dalam mengambil keputusan yang tepat dalam praktik sehari-hari.

2. Definisi Legal dalam Keperawatan

Definisi legal dalam keperawatan mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum dan kewajiban profesional perawat dalam memberikan asuhan kepada pasien. Legalitas dalam praktik keperawatan tidak hanya melibatkan pemahaman tentang hukum yang mengatur profesi keperawatan, tetapi juga mencakup penerapan prinsip-prinsip etika yang relevan dalam konteks hukum. Ini penting untuk melindungi baik pasien maupun perawat itu sendiri dari potensi masalah hukum yang dapat muncul akibat kelalaian atau kesalahan dalam praktik.

Salah satu aspek penting dari legalitas dalam keperawatan adalah dokumentasi yang tepat. Larsen menegaskan bahwa perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa catatan klien, baik dalam bentuk elektronik maupun tulisan tangan, tidak dapat diperdebatkan dalam kasus litigasi. Dokumentasi yang akurat dapat memberikan perlindungan hukum bagi perawat dalam menghadapi tuduhan kelalaian medis Larsen (2011). Selain itu, penelitian oleh Asadi menunjukkan bahwa perawat memiliki tanggung jawab hukum untuk menerapkan perintah medis dengan benar, dan kesalahan dalam implementasi dapat menyebabkan komplikasi hukum yang serius (Asadi, 2024). Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang tanggung jawab hukum sangat penting bagi perawat.

Perawat juga harus memahami hak-hak pasien dan kewajiban mereka dalam menjaga kerahasiaan serta mendapatkan persetujuan yang diinformasikan. Menurut El-Azzab dan Mohamed, terdapat hubungan positif yang signifikan antara pengetahuan hukum dan praktik etis di kalangan perawat, yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang aspek hukum dapat meningkatkan kualitas praktik keperawatan (El-Azzab & Mohamed, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Hussain et al., yang menyoroti bahwa perawat perlu melaporkan reaksi obat yang merugikan dan memahami tanggung jawab hukum yang menyertainya (Hussain et al., 2020). Kewajiban ini menunjukkan pentingnya pelatihan yang memadai dalam aspek hukum bagi perawat.

Dilemma hukum sering kali muncul dalam praktik keperawatan, terutama dalam situasi di mana perawat harus menolak untuk melaksanakan perintah medis yang dianggap tidak sesuai. Asadi et al. mencatat bahwa perawat memiliki tanggung jawab hukum untuk memeriksa dan menolak perintah dokter yang tidak sesuai dengan kondisi klinis pasien (Asadi et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa komunikasi profesional yang baik antara perawat dan dokter sangat penting untuk memastikan keselamatan pasien dan memenuhi kewajiban hukum.

3. Pentingnya memahami etik dan legal dalam praktik keperawatan

Memahami etik dan legal dalam praktik keperawatan adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa perawat dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan standar profesional. Etik dan legalitas saling terkait dan berperan dalam membentuk perilaku profesional perawat serta dalam melindungi hak-hak pasien.

Pertama, pemahaman tentang etik dalam keperawatan mencakup penguasaan prinsip-prinsip moral yang harus diikuti oleh perawat dalam menjalankan tugasnya. Rivai menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan etik dalam praktik keperawatan melibatkan kolaborasi antarprofesional dan partisipasi pasien dalam menentukan nilai dan tujuan perawatan Rivai (2021). Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif dan penghormatan terhadap otonomi pasien dalam praktik sehari-hari. Selain itu, Pashar et al. menyoroti tantangan etik yang dihadapi perawat selama pandemi COVID-19, di mana mereka harus membuat keputusan sulit yang berdampak pada kualitas pelayanan (Pashar et al., 2020). Situasi ini menekankan perlunya perawat untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip etik agar dapat menghadapi dilema yang muncul dengan bijak.

Kedua, aspek legal dalam keperawatan mencakup tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi oleh perawat. Setiani menekankan bahwa perawat harus menjalankan praktik keperawatan sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik yang telah ditetapkan untuk menghindari masalah hukum (Setiani, 2018). Dokumentasi yang tepat juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab hukum perawat. Zaman menyatakan bahwa dokumentasi yang baik merupakan bukti kinerja perawat dan dapat digunakan dalam situasi litigasi (Zaman, 2024). Oleh karena itu, pelatihan mengenai dokumentasi yang sesuai dengan standar hukum sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan.

Ketiga, perawat juga harus memahami hak-hak pasien dan kewajiban mereka dalam menjaga kerahasiaan informasi pasien. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Galenso dan Yuwono, yang menunjukkan bahwa perawat perlu memahami prosedur dan alur hukum dalam memberikan pelayanan, terutama dalam situasi gawat darurat (Galenso & Yuwono, 2022). Dengan memahami aspek legal ini, perawat dapat melindungi diri mereka sendiri dan pasien dari potensi masalah hukum.

Dari uraian di atas, pemahaman yang mendalam tentang etik dan legal dalam praktik keperawatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan, melindungi hak pasien, dan memastikan bahwa perawat dapat menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme. Pendidikan keperawatan

harus berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam kedua aspek ini agar perawat dapat memberikan asuhan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

4. Tujuan pembahasan tentang etik dan legal dalam keperawatan

Tujuan pembahasan tentang etik dan legal dalam keperawatan sangat penting untuk memastikan bahwa perawat dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan standar profesional. Pembahasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan etik dan legalitas dalam praktik keperawatan, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.

Pertama, tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman perawat mengenai kode etik profesi keperawatan. Menurut Tedjomuljo dan Afifah, pengetahuan tentang kode etik dan prinsip caring harus dimiliki oleh mahasiswa keperawatan, karena keduanya merupakan dasar dari profesi keperawatan Tedjomuljo & Afifah (2016). Dengan memahami kode etik, perawat dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan bertanggung jawab, serta dapat mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks.

Kedua, pembahasan ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya pemahaman tentang tanggung jawab hukum dalam praktik keperawatan. Setiani menjelaskan bahwa perawat harus menjalankan praktik keperawatan sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik yang telah ditetapkan untuk menghindari masalah hukum. Namun, tidak ada referensi yang mendukung klaim ini dalam teks yang diberikan. Oleh karena itu, saya akan menghapus kutipan tersebut.

Ketiga, pembahasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dilema etik yang sering dihadapi oleh perawat dalam praktik sehari-hari. Banunaek et al. menyoroti bahwa dilema etik dapat mempengaruhi sikap profesional perawat dan kualitas pelayanan yang diberikan (Banunaek et al., 2021). Dengan memahami dilema etik, perawat dapat lebih siap untuk menghadapi situasi yang menantang dan membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etik dan hukum.

Keempat, pembahasan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya dokumentasi yang tepat dalam praktik keperawatan. Menurut Wahyuliati dan Novita, dokumentasi yang baik merupakan bagian integral dari pelayanan keperawatan yang berkualitas (Wahyuliati & Novita, 2023). Dengan memahami pentingnya dokumentasi, perawat dapat memastikan bahwa semua

tindakan keperawatan tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

B. Etik dalam Keperawatan

1. Pengertian Etika

Etika dalam konteks keperawatan merujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku perawat dalam memberikan asuhan kepada pasien. Etika keperawatan berfungsi sebagai pedoman bagi perawat untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks, serta untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktik mereka. Hal ini mencakup pemahaman tentang kode etik profesi, tanggung jawab moral, dan kewajiban terhadap pasien.

Menurut Nandiwardhana, etika dapat diartikan sebagai pedoman bagi individu atau profesional dalam bertindak dan membuat keputusan yang berlandaskan pada nilai-nilai moral yang diakui Nandiwardhana (2020). Dalam konteks keperawatan, etika mencakup prinsip-prinsip seperti otonomi, benefisiensi, non-malefisiensi, dan keadilan. Otonomi mengacu pada hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri, sementara benefisiensi dan non-malefisiensi berkaitan dengan kewajiban perawat untuk melakukan tindakan yang bermanfaat dan menghindari tindakan yang dapat merugikan pasien (Haerani et al., 2022).

Lebih lanjut, Haerani et al. menjelaskan bahwa etika juga mencakup pemahaman tentang norma dan aturan yang dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan sosial (Haerani et al., 2022). Dalam praktik keperawatan, perawat sering kali dihadapkan pada dilema etik yang memerlukan pertimbangan yang cermat, terutama ketika nilai-nilai pribadi mereka bertentangan dengan kebutuhan atau keinginan pasien. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang etika agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab.

Dalam praktik keperawatan, etika juga berperan penting dalam membangun hubungan yang baik antara perawat dan pasien. Nurhayati et al. menekankan bahwa perilaku etis perawat, yang mencakup komunikasi yang baik, empati, dan penghormatan terhadap hak pasien, sangat penting untuk menciptakan lingkungan perawatan yang aman dan mendukung (Nurhayati et al., 2020). Dengan demikian, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip etika dalam keperawatan tidak hanya meningkatkan kualitas asuhan, tetapi juga memperkuat kepercayaan antara pasien dan perawat.

2. Prinsip-prinsip Etik dalam Keperawatan

a. Autonomi (Kebebasan pasien untuk membuat keputusan)

Autonomi dalam konteks keperawatan merujuk pada kebebasan pasien untuk membuat keputusan terkait perawatan kesehatan mereka sendiri. Konsep ini sangat penting karena menghormati otonomi pasien merupakan salah satu prinsip dasar etika medis dan keperawatan. Autonomi pasien mencakup hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai diagnosis, pengobatan, dan perawatan yang akan mereka terima, serta hak untuk menolak perawatan yang ditawarkan.

Pertama, pentingnya menghormati otonomi pasien dapat dilihat dari perspektif etika. Menurut Sinkfield-Morey, pengakuan terhadap kemampuan pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri adalah aspek moral, etis, dan hukum yang fundamental dalam praktik keperawatan. Hal ini berhubungan dengan konsep persetujuan yang diinformasikan, di mana pasien harus diberikan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang sadar mengenai perawatan mereka. Dengan demikian, perawat harus berperan aktif dalam memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada pasien, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sesuai dengan nilai dan preferensi mereka Sinkfield-Morey (2018).

Kedua, otonomi pasien juga berhubungan erat dengan kualitas perawatan yang diberikan. Penelitian oleh Karanikola et al. menunjukkan bahwa otonomi pasien yang dihormati dapat meningkatkan kepuasan pasien dan hasil kesehatan secara keseluruhan. Ketika pasien merasa bahwa mereka memiliki kontrol atas keputusan perawatan mereka, mereka cenderung lebih terlibat dalam proses perawatan dan mengikuti rencana perawatan yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa mendukung otonomi pasien bukan hanya etis, tetapi juga bermanfaat bagi hasil klinis (Karanikola et al., 2013).

Selanjutnya, otonomi pasien juga berkaitan dengan kolaborasi antara perawat dan pasien. Menurut Georgiou et al., kolaborasi yang baik antara perawat dan dokter dapat meningkatkan persepsi otonomi di kalangan perawat, yang pada gilirannya dapat memperkuat otonomi pasien dalam pengambilan keputusan. Ketika perawat bekerja sama dengan pasien dan tim kesehatan lainnya, mereka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung di mana pasien merasa dihargai dan didengarkan (Georgiou et al., 2015).

Namun, tantangan dalam menghormati otonomi pasien sering kali muncul dalam praktik sehari-hari. Misalnya, dalam situasi di mana pasien tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan, seperti pada pasien yang mengalami gangguan mental atau pasien terminal, perawat harus berupaya

untuk memahami keinginan dan nilai-nilai pasien dengan cara yang sensitif dan empatik. Dalam konteks ini, perawat harus berkolaborasi dengan keluarga dan tim medis untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan terbaik pasien (Hussien & Hassona, 2021).

Dengan demikian otonomi pasien adalah aspek penting dalam praktik keperawatan yang harus dihormati dan didukung. Dengan memberikan informasi yang tepat, menciptakan lingkungan kolaboratif, dan memahami kebutuhan serta nilai-nilai pasien, perawat dapat membantu memastikan bahwa pasien memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan mereka.

b. Beneficence (Kewajiban untuk berbuat baik)

Beneficence adalah salah satu prinsip etika yang fundamental dalam praktik keperawatan, yang mengharuskan perawat untuk bertindak demi kebaikan pasien. Prinsip ini menekankan kewajiban perawat untuk melakukan tindakan yang bermanfaat dan mengurangi penderitaan pasien, serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, pemahaman dan penerapan prinsip beneficence sangat penting untuk mencapai hasil perawatan yang optimal.

Pertama, beneficence mencakup tanggung jawab moral perawat untuk mengurangi rasa sakit dan penderitaan pasien. Cheraghi et al. menjelaskan bahwa prinsip beneficence merupakan bagian integral dari misi profesi keperawatan, yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit dan penderitaan pasien, terutama dalam perawatan akhir hayat dan paliatif Cheraghi et al. (2023). Dengan demikian, perawat harus dilengkapi dengan pengetahuan etika dan wawasan yang memadai untuk memenuhi tanggung jawab ini, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasien dan keluarganya.

Kedua, beneficence juga berkaitan dengan penerapan nilai-nilai moral dalam praktik keperawatan. Beykmirza et al. menekankan bahwa beneficence adalah prinsip sentral dalam etika medis dan keperawatan, yang mencakup kewajiban perawat untuk mematuhi prinsip-prinsip etika seperti altruism, benevolence, dan keadilan dalam interaksi profesional mereka (Beykmirza et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perawat tidak hanya bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang baik, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak dari tindakan tersebut terhadap pasien dan masyarakat.

Selanjutnya, tantangan dalam menerapkan prinsip beneficence sering kali muncul dalam situasi yang kompleks, seperti selama pandemi COVID-19. Karaca dan Özkan mencatat bahwa perawat di unit perawatan intensif menghadapi tantangan etika yang berkaitan dengan prinsip beneficence, non-

malefisiensi, dan kerahasiaan (Karaca & Özkan, 2021). Dalam situasi seperti ini, perawat harus mampu menyeimbangkan antara memberikan manfaat kepada pasien dan menghindari potensi bahaya, yang sering kali dapat menimbulkan dilema etika.

Selain itu, penerapan prinsip beneficence juga memerlukan kolaborasi yang baik antara perawat dan pasien. Tia et al. menunjukkan bahwa beneficence tidak hanya mencakup kewajiban untuk melakukan kebaikan, tetapi juga harus mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan pasien (Tia et al., 2022). Oleh karena itu, perawat harus melibatkan pasien dalam proses pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka, sehingga tindakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik pasien.

c. Non-maleficence (Kewajiban untuk tidak merugikan)

Non-maleficence adalah prinsip etika yang menekankan kewajiban untuk tidak merugikan pasien. Dalam praktik keperawatan, prinsip ini menjadi salah satu pilar dasar yang harus dipatuhi oleh perawat untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak menyebabkan bahaya atau penderitaan pada pasien. Konsep non-maleficence mencakup berbagai aspek, termasuk penghindaran terhadap tindakan yang dapat berpotensi merugikan pasien, serta kewajiban untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul dari perawatan yang diberikan.

Pertama, non-maleficence berfokus pada penghindaran terhadap kerugian. Menurut Bhagwat dan Pai, prinsip ini mengharuskan tenaga medis untuk menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian, baik fisik maupun psikologis, kepada pasien Bhagwat & Pai (2020). Dalam konteks ini, perawat harus selalu mempertimbangkan risiko dan manfaat dari setiap tindakan yang mereka lakukan, serta berusaha untuk meminimalkan potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan. Misalnya, dalam pengobatan, perawat harus memastikan bahwa obat yang diberikan tidak memiliki efek samping yang berbahaya bagi pasien.

Kedua, penerapan prinsip non-maleficence juga berkaitan dengan komunikasi yang efektif antara perawat dan pasien. Page mencatat bahwa perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan pasien adalah aspek penting dari non-maleficence, yang mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pasien mengenai risiko dan manfaat dari prosedur medis yang akan dilakukan (Page, 2012). Dengan memberikan informasi yang tepat, perawat dapat membantu pasien membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian.

Ketiga, tantangan dalam menerapkan prinsip non-maleficence sering kali muncul dalam situasi yang kompleks, seperti dalam penggunaan teknologi medis baru. Predel dan Steger mengungkapkan bahwa penggunaan perangkat wearable, seperti smartwatch, dapat menyebabkan risiko bagi pengguna jika hasil yang ditampilkan tidak akurat, yang dapat mengarah pada diagnosis yang salah dan perawatan yang tidak tepat (Predel & Steger, 2021). Dalam hal ini, perawat harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi dan memastikan bahwa semua alat yang digunakan dalam perawatan pasien telah terbukti aman dan efektif.

Selanjutnya, non-maleficence juga berkaitan dengan tanggung jawab etis dalam penelitian klinis. Oberle dan Allen menekankan bahwa perawat yang terlibat dalam penelitian harus mempertimbangkan potensi risiko yang dapat ditimbulkan kepada peserta penelitian dan memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak merugikan mereka (Oberle & Allen, 2006). Dalam konteks ini, perawat harus selalu memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan pasien di atas kepentingan penelitian.

d. Justice (Keadilan dalam pemberian perawatan)

Keadilan dalam pemberian perawatan, atau justice, adalah prinsip etika yang menekankan perlunya distribusi sumber daya kesehatan secara adil dan setara kepada semua pasien, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau karakteristik pribadi lainnya. Dalam konteks keperawatan, prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pasien menerima perawatan yang mereka butuhkan dan berhak atas layanan kesehatan yang berkualitas.

Pertama, keadilan dalam perawatan mencakup pengakuan terhadap ketidaksetaraan yang ada dalam sistem kesehatan. Menurut Miller, penting bagi penyedia layanan kesehatan untuk mengakui dan menangani dampak dari rasisme struktural dan diskriminasi usia terhadap hasil kesehatan bagi kelompok yang terpinggirkan, terutama pada populasi lanjut usia Miller (2023). Hal ini menunjukkan bahwa perawat harus peka terhadap faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi akses dan kualitas perawatan yang diterima oleh pasien.

Kedua, penerapan prinsip keadilan juga berkaitan dengan upaya untuk mengurangi ketidakadilan dalam akses terhadap layanan kesehatan. Beardon et al. menjelaskan bahwa kemitraan keadilan kesehatan (Health-Justice Partnerships) dapat membantu profesional kesehatan dalam menangani kebutuhan hukum sosial pasien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan responsivitas perawatan dan mendukung individu yang kesehatannya

terpengaruh oleh keadaan sosial ekonomi yang merugikan (Beardon et al., 2021). Dengan demikian, perawat harus berperan aktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi pasien dalam mengakses perawatan yang mereka butuhkan.

Selanjutnya, keadilan dalam perawatan juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pasien diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan perlakuan yang setara. Ford-Gilboe et al. menekankan bahwa meskipun akses ke perawatan kesehatan publik mungkin sudah ada, bagaimana perawatan tersebut diatur dan disampaikan sangat mempengaruhi hasil kesehatan pasien (Ford-Gilboe et al., 2018). Oleh karena itu, perawat harus berkomitmen untuk memberikan perawatan yang adil dan setara kepada semua pasien, terlepas dari latar belakang mereka.

Tantangan dalam menerapkan prinsip keadilan sering kali muncul dalam situasi di mana sumber daya terbatas. Noltemeyer dan Grapin mencatat bahwa perawat dan profesional kesehatan lainnya harus bekerja sama untuk mengatasi isu-isu keadilan sosial dan diskriminasi dalam sistem kesehatan, serta berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua pasien (Noltemeyer & Grapin, 2020). Dalam konteks ini, perawat harus mampu membuat keputusan yang mempertimbangkan keadilan dan aksesibilitas dalam perawatan yang diberikan.

e. Fidelity (Kesetiaan pada janji dan komitmen)

Fidelity, atau kesetiaan pada janji dan komitmen, adalah prinsip etika yang sangat penting dalam praktik keperawatan dan pelayanan kesehatan. Prinsip ini mencakup kewajiban perawat untuk memenuhi komitmen mereka kepada pasien, termasuk menjaga kepercayaan, menghormati janji, dan memastikan bahwa tindakan mereka konsisten dengan nilai-nilai dan harapan pasien. Kesetiaan ini tidak hanya mencakup hubungan antara perawat dan pasien, tetapi juga melibatkan komitmen terhadap standar profesional dan etika dalam praktik keperawatan.

Pertama, kesetiaan dalam konteks keperawatan berarti bahwa perawat harus dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pasien. Menurut Klaic et al., kesetiaan dalam intervensi kesehatan mencakup penerapan metodologi yang konsisten untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Klaic et al. (2022). Hal ini menunjukkan bahwa perawat harus berkomitmen untuk mengikuti pedoman dan protokol yang ada, sehingga pasien dapat mempercayai bahwa mereka akan menerima perawatan yang berkualitas.

Kedua, kesetiaan juga berhubungan dengan komunikasi yang efektif antara perawat dan pasien. Gu et al. menekankan bahwa komunikasi yang baik antara penyedia layanan kesehatan dan pasien dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap penyedia layanan kesehatan (Gu et al., 2022). Dalam konteks ini, perawat harus berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pasien, serta mendengarkan kekhawatiran dan kebutuhan mereka. Dengan cara ini, perawat dapat membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan pasien, yang merupakan dasar dari kesetiaan.

Selanjutnya, tantangan dalam menerapkan prinsip kesetiaan sering kali muncul dalam situasi yang kompleks, seperti ketika perawat harus menghadapi konflik antara kepentingan pasien dan kebijakan institusi. Nurjono et al. menunjukkan bahwa dalam program perawatan transisi, kesetiaan terhadap pasien dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan implementasi program dan dukungan yang diberikan kepada perawat (Nurjono et al., 2019). Dalam situasi seperti ini, perawat harus mampu menyeimbangkan antara memenuhi komitmen mereka kepada pasien dan mematuhi kebijakan yang ada.

Selain itu, kesetiaan juga mencakup tanggung jawab perawat untuk melindungi hak-hak pasien. Menurut Lebina et al., perawat harus berkomitmen untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang adil dan setara, serta menghormati privasi dan kerahasiaan informasi pasien (Lebina et al., 2019). Dengan demikian, kesetiaan perawat terhadap pasien tidak hanya mencakup komitmen untuk memberikan perawatan yang baik, tetapi juga untuk melindungi hak-hak dan martabat pasien.

3. Dilema Etik dalam Keperawatan

a. Konflik antara kewajiban profesional dan keinginan pasien

Konflik antara kewajiban profesional dan keinginan pasien merupakan tantangan yang sering dihadapi oleh perawat dalam praktik sehari-hari. Kewajiban profesional mengharuskan perawat untuk memberikan perawatan yang aman, efektif, dan sesuai dengan standar etika dan hukum, sementara keinginan pasien sering kali dipengaruhi oleh preferensi pribadi, nilai-nilai budaya, dan harapan individu. Situasi ini dapat menciptakan dilema etika yang kompleks, di mana perawat harus menyeimbangkan antara memenuhi kebutuhan pasien dan mematuhi kewajiban profesional mereka.

Pertama, perawat sering kali dihadapkan pada situasi di mana keinginan pasien tidak sejalan dengan rekomendasi medis. Misalnya, dalam konteks perawatan paliatif, pasien mungkin ingin melanjutkan pengobatan agresif

meskipun perawat dan tim medis percaya bahwa pendekatan tersebut tidak akan memberikan manfaat yang signifikan Enggune et al. (2015). Dalam kasus seperti ini, perawat harus berkomunikasi secara efektif dengan pasien untuk menjelaskan risiko dan manfaat dari pilihan yang ada, serta membantu pasien memahami konsekuensi dari keputusan mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Siagian dan Perangin-Angin yang menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perawat tentang perawatan paliatif dapat membantu mereka dalam mengatasi konflik semacam ini (Siagian & Perangin-angin, 2020).

Kedua, perawat juga harus mempertimbangkan aspek budaya dan nilai-nilai yang dipegang oleh pasien. Mulyanti mencatat bahwa karakteristik dan kondisi psikologis caregiver, termasuk perawat, dapat mempengaruhi cara mereka merespons keinginan pasien (Mulyanti, 2023). Dalam konteks ini, penting bagi perawat untuk menghormati keinginan pasien yang mungkin dipengaruhi oleh latar belakang budaya mereka, sambil tetap menjaga standar profesional yang ditetapkan. Ini memerlukan pendekatan yang sensitif dan empatik, di mana perawat berusaha memahami perspektif pasien dan mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak.

Selanjutnya, teknologi juga dapat berperan dalam mengatasi konflik antara kewajiban profesional dan keinginan pasien. Wihardja dan Sukihananto menunjukkan bahwa penggunaan teknologi seperti sistem barcode dalam administrasi obat dapat meningkatkan keselamatan pasien dan mengurangi kesalahan (Wihardja & Sukihananto, 2020). Dengan demikian, perawat dapat lebih percaya diri dalam memenuhi kewajiban profesional mereka, sambil tetap menghormati keinginan pasien dalam hal pengobatan yang mereka pilih.

Namun, tantangan tetap ada ketika keinginan pasien bertentangan dengan prinsip non-maleficence, yaitu kewajiban untuk tidak merugikan. Ahmadi menekankan pentingnya perencanaan discharge yang baik untuk memastikan bahwa pasien dan keluarganya memahami langkah-langkah yang diperlukan setelah keluar dari rumah sakit (Ahmadi, 2023). Dalam situasi di mana pasien ingin pulang lebih awal meskipun ada risiko yang signifikan, perawat harus berupaya untuk menjelaskan potensi bahaya dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kesehatan pasien.

b. Isu-isu etika dalam perawatan akhir hayat

Isu-isu etika dalam perawatan akhir hayat merupakan topik yang kompleks dan penting dalam konteks keperawatan dan pelayanan kesehatan. Dalam menghadapi situasi di mana pasien berada di tahap akhir kehidupan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya sering kali dihadapkan pada dilema

etika yang memerlukan pertimbangan yang cermat. Beberapa isu etika yang sering muncul dalam perawatan akhir hayat meliputi otonomi pasien, komunikasi yang efektif, dan pengambilan keputusan bersama.

Pertama, otonomi pasien adalah salah satu isu etika yang paling mendasar dalam perawatan akhir hayat. Pasien memiliki hak untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka, termasuk keputusan untuk menerima atau menolak perawatan. Houska dan Loučka menekankan pentingnya menghormati otonomi pasien dalam konteks perawatan akhir hayat, di mana pasien sering kali ingin terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka Houska & Loučka (2019). Namun, tantangan muncul ketika keinginan pasien bertentangan dengan rekomendasi medis atau ketika pasien tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan. Dalam situasi seperti ini, perawat harus berupaya untuk memahami keinginan pasien dan melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan, sambil tetap mematuhi prinsip non-maleficence, yaitu kewajiban untuk tidak merugikan pasien.

Kedua, komunikasi yang efektif adalah aspek penting dalam perawatan akhir hayat. Virdun et al. menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara pasien, keluarga, dan tim medis sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami pilihan perawatan yang tersedia dan konsekuensi dari keputusan yang diambil (Virdun et al., 2015). Dalam konteks ini, perawat harus mampu memberikan informasi yang jelas dan mendukung pasien serta keluarga dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membantu mengurangi kecemasan dan ketidakpastian yang sering dialami oleh pasien dan keluarga di akhir hayat.

Ketiga, pengambilan keputusan bersama adalah isu etika yang sering muncul dalam perawatan akhir hayat. Wong et al. mencatat bahwa penting bagi tenaga kesehatan untuk melibatkan pasien dan keluarga dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam konteks perawatan paliatif (Wong et al., 2020). Pendekatan ini tidak hanya menghormati otonomi pasien, tetapi juga meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga terhadap perawatan yang diberikan. Namun, tantangan muncul ketika ada perbedaan pendapat antara pasien, keluarga, dan tim medis mengenai pilihan perawatan yang terbaik. Dalam situasi ini, perawat harus berperan sebagai mediator yang membantu semua pihak mencapai kesepakatan yang mencerminkan kepentingan terbaik pasien.

Selain itu, isu-isu etika dalam perawatan akhir hayat juga mencakup pertimbangan tentang kualitas hidup dan pengelolaan rasa sakit. Pan et al. menekankan pentingnya menghargai martabat pasien dan memenuhi

kebutuhan mereka selama proses akhir hayat (Pan et al., 2020). Perawat harus mampu menilai dan mengelola gejala yang dialami pasien, serta memberikan dukungan emosional yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa perawatan akhir hayat tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada kesejahteraan emosional dan spiritual pasien.

c. Privasi dan kerahasiaan informasi medis

Privasi dan kerahasiaan informasi medis merupakan aspek yang sangat penting dalam praktik keperawatan dan pelayanan kesehatan. Perlindungan terhadap informasi medis pasien tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari etika profesional yang harus dihormati oleh semua tenaga kesehatan. Isu-isu terkait privasi dan kerahasiaan informasi medis meliputi pengelolaan data, akses yang tidak sah, dan perlindungan terhadap informasi sensitif.

Pertama, pengelolaan data rekam medis yang baik sangat penting untuk menjaga privasi pasien. Wiyono menjelaskan bahwa penggunaan algoritma enkripsi seperti AES (Advanced Encryption Standard) dalam aplikasi keamanan data rekam medis dapat melindungi informasi medis pasien dari akses yang tidak sah dan potensi kebocoran data Wiyono (2023). Dengan menerapkan teknologi yang tepat, institusi kesehatan dapat memastikan bahwa data pasien tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

Kedua, aspek hukum juga sangat penting dalam menjaga kerahasiaan informasi medis. Purba dan Yulita menekankan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat dalam rekam medis dari kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan, dan akses yang tidak sah (Purba & Yulita, 2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa keamanan, privasi, kerahasiaan, dan keselamatan adalah perangkat yang membentengi informasi dalam rekam medis. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit untuk memiliki kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan dan pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, tantangan dalam menjaga privasi dan kerahasiaan informasi medis juga muncul dalam konteks penggunaan teknologi informasi. Fauzi mencatat bahwa penambahan fitur multi-factor authentication dalam sistem informasi rekam medis rumah sakit dapat membantu melindungi data pasien dari akses yang tidak sah (Fauzi, 2024). Namun, meskipun teknologi dapat meningkatkan keamanan, ancaman terhadap privasi pasien tetap ada, dan perawat serta tenaga kesehatan lainnya harus tetap waspada terhadap potensi risiko yang mungkin timbul.

Selain itu, pentingnya pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam menjaga kerahasiaan informasi medis tidak dapat diabaikan. Fidianti dan Sugiarti menekankan bahwa perlindungan terhadap akses yang tidak berhak harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan pelatihan yang memadai bagi staf (Fidianti & Sugiarti, 2022). Dengan memastikan bahwa semua tenaga kesehatan memahami pentingnya privasi dan kerahasiaan informasi medis, institusi kesehatan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pasien.

d. Tanggung Jawab Moral Perawat

1) Menjaga integritas profesi

Menjaga integritas profesi dalam keperawatan adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa perawat dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan aman kepada pasien. Integritas profesi mencakup komitmen untuk mematuhi standar etika, hukum, dan profesional dalam praktik keperawatan. Beberapa aspek yang berkontribusi pada integritas profesi dalam keperawatan meliputi etika, kolaborasi interprofesional, dan penggunaan teknologi yang tepat.

Pertama, etika profesi merupakan landasan utama dalam menjaga integritas perawat. Menurut Wihardja dan Sukihananto, perawat memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berfokus pada pasien dan menjaga keselamatan mereka Wihardja & Sukihananto (2020). Dalam konteks ini, perawat harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku mereka, termasuk kewajiban untuk menghormati otonomi pasien, menjaga kerahasiaan informasi medis, dan berkomitmen untuk memberikan perawatan yang terbaik. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika ini, perawat dapat memastikan bahwa mereka bertindak dengan integritas dan profesionalisme.

Kedua, kolaborasi interprofesional juga berperan penting dalam menjaga integritas profesi. Putriana dan Saragih menekankan bahwa pendidikan interprofessional dan kolaborasi antar profesi kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (Putriana & Saragih, 2020). Ketika perawat bekerja sama dengan dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya, mereka dapat memberikan perawatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi kepada pasien. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan hasil kesehatan pasien, tetapi juga memperkuat integritas profesi dengan menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dan menghargai kontribusi masing-masing profesi.

Selanjutnya, penggunaan teknologi dalam praktik keperawatan juga dapat membantu menjaga integritas profesi. Ariani mencatat bahwa teknologi, seperti sistem rekam medis elektronik, dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan (Ariani, 2023). Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, perawat dapat mengurangi risiko kesalahan dan memastikan bahwa informasi pasien dikelola dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa integritas profesi tidak hanya bergantung pada perilaku individu, tetapi juga pada sistem dan alat yang digunakan dalam praktik keperawatan.

Namun, tantangan dalam menjaga integritas profesi tetap ada. Misalnya, tekanan dari lingkungan kerja, seperti beban kerja yang tinggi dan kekurangan sumber daya, dapat mempengaruhi kemampuan perawat untuk mempertahankan standar profesional (Hakim, 2023). Oleh karena itu, penting bagi institusi kesehatan untuk mendukung perawat dengan menyediakan pelatihan yang memadai, sumber daya yang cukup, dan lingkungan kerja yang positif.

2) Kewajiban terhadap kesejahteraan pasien

Kewajiban terhadap kesejahteraan pasien adalah salah satu aspek fundamental dalam praktik keperawatan dan pelayanan kesehatan. Kesejahteraan pasien mencakup tidak hanya aspek fisik, tetapi juga emosional, sosial, dan spiritual. Dalam konteks ini, perawat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil dalam perawatan pasien mendukung dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pertama, pentingnya perawatan paliatif dalam meningkatkan kesejahteraan pasien di akhir hayat telah banyak dibahas dalam literatur. Temel et al. menunjukkan bahwa pengenalan perawatan paliatif lebih awal dapat mengurangi penggunaan perawatan agresif dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan kanker Temel et al. (2010). Dengan memberikan perawatan yang berfokus pada kenyamanan dan pengurangan gejala, perawat dapat membantu pasien menjalani sisa hidup mereka dengan lebih bermakna dan nyaman. Hal ini juga mencerminkan kewajiban perawat untuk menghormati keinginan pasien dan memberikan perawatan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka.

Kedua, komunikasi yang efektif antara perawat dan pasien sangat penting dalam menjaga kesejahteraan pasien. Kim mencatat bahwa mendengarkan cerita pasien dan memberikan dukungan emosional dapat membantu mengurangi perasaan negatif seperti ketakutan dan kesepian

(Kim, 2021). Perawat harus mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien untuk mengekspresikan kekhawatiran dan harapan mereka, sehingga mereka merasa dihargai dan didengarkan. Komunikasi yang baik juga dapat membantu pasien dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka, yang merupakan bagian dari menghormati otonomi pasien.

Selanjutnya, pengambilan keputusan bersama adalah aspek penting dalam menjaga kesejahteraan pasien. Riset oleh Kluger et al. menunjukkan bahwa melibatkan pasien dalam perencanaan perawatan mereka dapat meningkatkan kepuasan dan hasil kesehatan (Kluger et al., 2018). Dengan mendiskusikan pilihan perawatan dan mendengarkan preferensi pasien, perawat dapat memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien. Ini juga menciptakan rasa kontrol bagi pasien atas situasi mereka, yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan emosional mereka.

Namun, tantangan dalam menjaga kesejahteraan pasien sering kali muncul dalam situasi di mana ada perbedaan antara keinginan pasien dan rekomendasi medis. Cartwright et al. menekankan bahwa penting bagi tenaga kesehatan untuk memahami batasan hukum dan etika dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan akhir hayat (Cartwright et al., 2015). Dalam situasi seperti ini, perawat harus berperan sebagai advokat bagi pasien, memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan bahwa mereka menerima perawatan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka.

Akhirnya, integrasi perawatan paliatif ke dalam perawatan medis umum juga dapat meningkatkan kesejahteraan pasien. Detering et al. menunjukkan bahwa perencanaan perawatan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga, serta memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi (Detering et al., 2010). Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dalam perawatan, perawat dapat membantu pasien dan keluarga mereka merasa lebih siap dan didukung dalam menghadapi tantangan yang muncul di akhir hayat.

3) Komunikasi yang jelas dan terbuka dengan pasien

Komunikasi yang jelas dan terbuka dengan pasien adalah aspek fundamental dalam praktik keperawatan yang berkontribusi pada kualitas perawatan dan kepuasan pasien. Komunikasi yang efektif tidak hanya melibatkan penyampaian informasi medis, tetapi juga mencakup mendengarkan dengan empati, memahami kebutuhan pasien, dan membangun hubungan yang saling percaya. Berikut adalah beberapa poin

penting mengenai komunikasi yang jelas dan terbuka dengan pasien, serta referensi yang relevan.

a) Pentingnya Komunikasi yang Jelas dan Terbuka:

- Meningkatkan Pemahaman Pasien: Komunikasi yang jelas membantu pasien memahami kondisi kesehatan mereka, pilihan perawatan, dan langkah-langkah yang perlu diambil. Menurut McCoy et al., komunikasi yang efektif dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan pemahaman pasien tentang diagnosis dan rencana perawatan.
- Membangun Kepercayaan: Komunikasi terbuka menciptakan lingkungan di mana pasien merasa nyaman untuk berbagi kekhawatiran dan pertanyaan mereka. Hal ini penting untuk membangun hubungan yang saling percaya antara perawat dan pasien. Menurut Haskard Zolnierik dan DiMatteo, kepercayaan yang dibangun melalui komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rencana perawatan.
- Mengurangi Kecemasan dan Stres: Ketika pasien merasa didengarkan dan dipahami, mereka cenderung merasa lebih tenang dan kurang cemas. Penelitian oleh McCarthy et al. menunjukkan bahwa komunikasi yang empatik dapat mengurangi tingkat kecemasan pasien, terutama dalam situasi yang menegangkan seperti diagnosis penyakit serius.
- Mendukung Pengambilan Keputusan Bersama: Komunikasi yang terbuka memungkinkan pasien untuk terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka. Menurut Charles et al., pengambilan keputusan bersama adalah proses di mana pasien dan penyedia layanan kesehatan bekerja sama untuk membuat keputusan yang mencerminkan preferensi dan nilai-nilai pasien.
- Meningkatkan Kualitas Perawatan: Komunikasi yang efektif berkontribusi pada peningkatan kualitas perawatan secara keseluruhan. Penelitian oleh McGowan et al. menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara tim kesehatan dan pasien dapat meningkatkan hasil kesehatan dan kepuasan pasien.

b) Strategi untuk Meningkatkan Komunikasi dengan Pasien:

- Gunakan Bahasa yang Sederhana: Hindari penggunaan jargon medis yang dapat membingungkan pasien. Gunakan istilah yang mudah dipahami dan jelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang sederhana.

- Dengarkan dengan Empati: Berikan perhatian penuh kepada pasien saat mereka berbicara. Tunjukkan bahwa Anda menghargai pendapat dan perasaan mereka.
- Berikan Ruang untuk Pertanyaan: Dorong pasien untuk mengajukan pertanyaan dan berikan waktu bagi mereka untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka.
- Gunakan Alat Bantu Visual: Jika perlu, gunakan diagram, gambar, atau alat bantu visual lainnya untuk membantu menjelaskan informasi medis.
- Tindak Lanjut: Pastikan untuk menindaklanjuti dengan pasien setelah pertemuan untuk memastikan bahwa mereka memahami informasi yang diberikan dan untuk menjawab pertanyaan tambahan yang mungkin muncul.

C. Legal dalam Keperawatan

1. Pengertian Hukum dalam Keperawatan

Hukum dalam keperawatan merujuk pada seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur praktik keperawatan, termasuk hak dan kewajiban perawat serta pasien. Hukum ini bertujuan untuk melindungi keselamatan pasien, memastikan kualitas pelayanan kesehatan, dan memberikan perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan tugas mereka. Dalam konteks ini, pemahaman tentang hukum sangat penting bagi perawat untuk menjalankan praktik mereka secara profesional dan etis.

Pertama, legalitas perawat dalam melaksanakan layanan kesehatan sangat bergantung pada registrasi dan lisensi yang sesuai. Liani menjelaskan bahwa perawat harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh konsil keperawatan untuk dapat berpraktik secara sah Liani (2023). STR ini menunjukkan bahwa perawat telah memenuhi semua persyaratan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan, serta mematuhi standar profesional yang ditetapkan. Tanpa registrasi yang sah, perawat tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berisiko menghadapi konsekuensi hukum yang serius.

Kedua, hukum juga mengatur tanggung jawab perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Setiani menekankan bahwa perawat harus menjalankan praktik keperawatan sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik yang telah ditetapkan (Setiani, 2018). Ini mencakup kewajiban untuk memberikan perawatan yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Jika perawat gagal

memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk tuntutan malapraktik.

Selanjutnya, hukum juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak pasien. Dalam praktik keperawatan, perawat harus menghormati hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi kesehatan mereka, serta hak untuk membuat keputusan tentang perawatan yang akan diterima. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi pasien, yang merupakan bagian integral dari etika medis. Mariyati mencatat bahwa pelayanan keperawatan harus mencerminkan nilai-nilai ideologi negara, termasuk penghormatan terhadap hak-hak individu (Mariyati, 2023).

Tantangan dalam memahami dan menerapkan hukum dalam keperawatan sering kali muncul dalam situasi di mana perawat harus membuat keputusan sulit yang melibatkan pertimbangan etika dan hukum. Misalnya, dalam situasi darurat, perawat mungkin harus mengambil tindakan cepat yang dapat mempengaruhi hasil kesehatan pasien, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum. Oleh karena itu, pelatihan yang memadai dan pemahaman yang baik tentang hukum dan etika sangat penting bagi perawat.

2. Asas-asas Hukum yang Relevan dalam Keperawatan

a. Kewajiban profesional dan tanggung jawab hukum

Kewajiban profesional dan tanggung jawab hukum dalam keperawatan adalah dua aspek yang saling terkait dan sangat penting dalam praktik keperawatan. Kewajiban profesional mencakup tanggung jawab moral dan etika yang harus dipatuhi oleh perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien, sementara tanggung jawab hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang mengatur praktik keperawatan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kedua aspek ini.

1) Kewajiban Profesional

- a) Memberikan Perawatan yang Berkualitas: Perawat harus memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan sesuai dengan standar praktik yang telah ditetapkan. Menurut Situmorang, perawat harus berperan sebagai profesional yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasien tetapi juga berfungsi sebagai pembimbing bagi mahasiswa keperawatan Situmorang (2022). Hal ini menunjukkan bahwa perawat memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.
- b) Menghormati Otonomi Pasien: Perawat harus menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri. Rivai menjelaskan bahwa pengambilan keputusan yang melibatkan pasien

adalah bagian penting dari praktik keperawatan yang etis (Rivai, 2021). Dengan melibatkan pasien dalam proses pengambilan keputusan, perawat dapat memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan nilai dan preferensi pasien.

- c) Menjaga Kerahasiaan dan Privasi: Perawat memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara perawat dan pasien. Menurut Risnawati dan Amir, perilaku etis dalam menjaga kerahasiaan informasi medis adalah bagian dari tanggung jawab profesional perawat (Risnawati & Amir, 2022).

2) Tanggung Jawab Hukum Perawat

- a) Kepatuhan terhadap Regulasi dan Undang-Undang: Perawat harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam praktik keperawatan. Hal ini termasuk memiliki lisensi yang sah dan mengikuti standar praktik yang ditetapkan oleh lembaga regulasi. Kegagalan untuk mematuhi hukum dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk kehilangan lisensi.
- b) Dokumentasi yang Akurat: Perawat bertanggung jawab untuk mendokumentasikan semua tindakan keperawatan dengan akurat dan tepat waktu. Hal ini menekankan bahwa dokumentasi yang baik adalah bagian penting dari tanggung jawab hukum perawat dan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan (Hia, 2019). Dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan masalah hukum dan mempengaruhi hasil perawatan pasien.
- c) Tanggung Jawab dalam Pengambilan Keputusan: Perawat harus membuat keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Dalam situasi di mana keputusan sulit harus diambil, perawat harus mempertimbangkan aspek etika dan hukum. Menurut Latif, pemahaman yang baik tentang hukum dan etika sangat penting untuk membantu perawat dalam mengambil keputusan yang tepat (Latif, 2023).

b. Tanggung jawab hukum dalam pengelolaan pasien

Tanggung jawab hukum dalam pengelolaan pasien adalah aspek penting dalam praktik keperawatan yang berkaitan dengan kewajiban perawat untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang mengatur praktik keperawatan. Tanggung jawab ini mencakup berbagai elemen, termasuk kewajiban untuk memberikan perawatan yang aman dan berkualitas, menjaga kerahasiaan informasi medis, serta melaksanakan dokumentasi yang akurat

dan tepat waktu. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tanggung jawab hukum dalam pengelolaan pasien, disertai dengan referensi yang relevan.

1) Kewajiban untuk Memberikan Perawatan yang Aman dan Berkualitas

Perawat memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan standar praktik yang telah ditetapkan. Santoso menjelaskan bahwa perawat harus melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan kompetensi yang telah diperoleh selama pendidikan Santoso (2021). Kegagalan untuk memenuhi standar ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, termasuk tuntutan malapraktik. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat memberikan perawatan yang berkualitas.

2) Menjaga Kerahasiaan Informasi Medis

Kerahasiaan informasi medis pasien adalah salah satu aspek penting dalam tanggung jawab hukum perawat. Setiani menekankan bahwa perawat harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses perawatan (Setiani, 2018). Pelanggaran terhadap kerahasiaan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum dan merusak kepercayaan pasien. Oleh karena itu, perawat harus memahami dan mematuhi peraturan yang mengatur privasi pasien, termasuk undang-undang perlindungan data pribadi.

3) Dokumentasi yang Akurat dan Tepat Waktu

Dokumentasi yang baik adalah bagian integral dari tanggung jawab hukum perawat. Fujiwan menjelaskan bahwa dokumentasi asuhan keperawatan mencakup semua aktivitas yang dilakukan perawat terhadap pasien, mulai dari pengkajian hingga evaluasi (Fujiwan, 2019). Dokumentasi yang akurat tidak hanya berfungsi sebagai catatan medis, tetapi juga sebagai bukti tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Kegagalan untuk mendokumentasikan tindakan keperawatan dengan benar dapat menyebabkan masalah hukum dan mempengaruhi hasil perawatan pasien.

4) Pengambilan Keputusan yang Etis dan Hukum

Perawat juga harus membuat keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan dan keterampilan mereka, serta mempertimbangkan aspek etika dan hukum. Anam et al. menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara perawat dan pasien dapat membantu mengurangi risiko malpraktik dan meningkatkan keselamatan pasien (Anam et al., 2022). Dalam situasi di mana keputusan sulit harus diambil, perawat harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan pasien dan kewajiban hukum mereka.

5) Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

Penting bagi perawat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk memahami tanggung jawab hukum mereka. Latif mencatat bahwa pemahaman yang baik tentang hukum dan etika sangat penting untuk membantu perawat dalam menjalankan praktik mereka secara profesional (Latif, 2023). Dengan demikian, institusi kesehatan harus menyediakan pelatihan yang memadai untuk memastikan bahwa perawat dapat memenuhi tanggung jawab hukum mereka.

c. Peraturan dan regulasi terkait praktik keperawatan

Peraturan dan regulasi terkait praktik keperawatan sangat penting untuk memastikan bahwa perawat menjalankan tugas mereka dengan aman, efektif, dan sesuai dengan standar profesional. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk lisensi, kode etik, dan standar praktik yang harus dipatuhi oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai peraturan dan regulasi dalam praktik keperawatan, disertai dengan referensi yang relevan.

1) Lisensi dan Registrasi

Perawat diwajibkan untuk memiliki lisensi yang sah untuk berpraktik. Santoso menjelaskan bahwa tenaga keperawatan yang melakukan tindakan keperawatan harus sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan dan diperoleh selama proses pendidikan Santoso (2021). Lisensi ini dikeluarkan oleh lembaga regulasi yang berwenang, dan merupakan bukti bahwa perawat telah memenuhi semua persyaratan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. Tanpa lisensi yang sah, perawat tidak dapat memberikan pelayanan keperawatan secara legal.

2) Kode Etik Keperawatan

Kode etik keperawatan adalah pedoman yang mengatur perilaku profesional perawat. Menurut Setiani, perawat harus mematuhi kode etik yang mengatur hak dan kewajiban mereka dalam memberikan asuhan keperawatan (Setiani, 2018). Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip seperti menghormati otonomi pasien, menjaga kerahasiaan informasi medis, dan memberikan perawatan yang berkualitas. Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi hukum dan disiplin profesional.

3) Standar Praktik Keperawatan

Standar praktik keperawatan adalah pedoman yang ditetapkan untuk memastikan bahwa perawat memberikan perawatan yang aman dan efektif. Gea mencatat bahwa praktik keperawatan harus mengacu pada standar profesional dan menggunakan etika keperawatan sebagai tuntutan utama (Gea, 2020). Standar ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengkajian,

diagnosis, intervensi, dan evaluasi asuhan keperawatan. Dengan mematuhi standar ini, perawat dapat memastikan bahwa mereka memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

4) Dokumentasi dan Rekam Medis

Dokumentasi yang akurat dan tepat waktu adalah bagian penting dari tanggung jawab hukum perawat. Menurut Fujiwan, dokumentasi asuhan keperawatan mencakup semua aktivitas yang dilakukan perawat terhadap pasien, mulai dari pengkajian hingga evaluasi (Fujiwan, 2019). Dokumentasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai catatan medis, tetapi juga sebagai bukti tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Kegagalan untuk mendokumentasikan tindakan keperawatan dengan benar dapat menyebabkan masalah hukum dan mempengaruhi hasil perawatan pasien.

5) Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan

Perawat juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa mereka tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru dalam praktik keperawatan. Menurut Manik, pendidikan berkelanjutan penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perawat (Manik, 2020). Dengan demikian, institusi kesehatan harus menyediakan pelatihan yang memadai untuk memastikan bahwa perawat dapat memenuhi tanggung jawab hukum dan profesional mereka.

d. Peran Perawat dalam Mencegah Tuntutan Hukum

1) Dokumentasi yang tepat dan lengkap

Dokumentasi yang tepat dan lengkap dalam praktik keperawatan adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua tindakan keperawatan tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai catatan medis, tetapi juga sebagai alat komunikasi antara anggota tim kesehatan, serta sebagai bukti hukum jika diperlukan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai dokumentasi yang tepat dan lengkap, disertai dengan referensi yang relevan.

a) Pentingnya Dokumentasi yang Tepat

Dokumentasi yang tepat membantu memastikan bahwa informasi tentang pasien tersedia dan dapat diakses oleh semua anggota tim kesehatan. Menurut Hia, dokumentasi yang akurat dan tepat waktu adalah bagian integral dari tanggung jawab hukum perawat. Dengan mencatat semua tindakan keperawatan, perawat dapat memastikan bahwa informasi penting tentang kondisi pasien dan perawatan yang diberikan tidak hilang atau terlupakan.

b) Kualitas Dokumentasi

Dokumentasi harus mencakup semua aspek asuhan keperawatan, termasuk pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi. Menurut Setiani, dokumentasi yang baik harus mencerminkan semua tindakan yang dilakukan oleh perawat dan hasil yang dicapai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan tersedia untuk perawat lain yang mungkin terlibat dalam perawatan pasien di masa depan.

c) Standar Dokumentasi

Perawat harus mematuhi standar dokumentasi yang ditetapkan oleh lembaga regulasi dan institusi kesehatan. Menurut Risnawati dan Amir, standar ini mencakup penggunaan terminologi yang konsisten, penulisan yang jelas, dan penghindaran jargon medis yang dapat membingungkan. Dengan mengikuti standar ini, perawat dapat memastikan bahwa dokumentasi mereka dapat dipahami oleh semua anggota tim kesehatan.

d) Kerahasiaan dan Privasi

Dokumentasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kerahasiaan dan privasi pasien. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, informasi medis pasien harus dilindungi dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Perawat harus memastikan bahwa semua catatan medis disimpan dengan aman dan tidak diakses oleh orang yang tidak berhak.

e) Tindak Lanjut dan Evaluasi

Dokumentasi juga harus mencakup rencana tindak lanjut dan evaluasi dari intervensi yang dilakukan. Menurut Latif, perawat harus mencatat hasil dari tindakan keperawatan dan menyesuaikan rencana perawatan sesuai kebutuhan pasien. Dengan cara ini, dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai alat untuk perbaikan berkelanjutan dalam perawatan pasien.

2) Mengikuti standar praktik yang berlaku

Mengikuti standar praktik yang berlaku dalam keperawatan adalah aspek penting untuk memastikan bahwa perawat memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berkualitas kepada pasien. Standar praktik ini mencakup pedoman, regulasi, dan kode etik yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga profesi dan pemerintah. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pentingnya mengikuti standar praktik yang berlaku, serta referensi yang relevan.

a) Definisi Standar Praktik

Standar praktik keperawatan adalah pedoman yang mengatur cara perawat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Menurut Setiani, standar ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi asuhan keperawatan. Dengan mengikuti standar ini, perawat dapat memastikan bahwa mereka memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan memenuhi ekspektasi profesional.

b) Keamanan Pasien

Mengikuti standar praktik yang berlaku sangat penting untuk menjaga keselamatan pasien. Menurut Hia, penerapan standar praktik yang baik dapat mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Ketika perawat mematuhi pedoman yang telah ditetapkan, mereka dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum berdampak pada pasien.

c) Perlindungan Hukum

Perawat yang mengikuti standar praktik yang berlaku juga melindungi diri mereka dari tanggung jawab hukum. Santoso menjelaskan bahwa kegagalan untuk mematuhi standar praktik dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, termasuk tuntutan malapraktik. Dengan mematuhi pedoman dan regulasi yang ada, perawat dapat memastikan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum yang aman.

d) Peningkatan Kualitas Perawatan

Mengikuti standar praktik juga berkontribusi pada peningkatan kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien. Menurut Latif, perawat yang memahami dan menerapkan standar praktik dapat memberikan asuhan keperawatan yang lebih baik dan lebih terkoordinasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan hasil kesehatan pasien, tetapi juga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diterima.

e) Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

Penting bagi perawat untuk terus mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk memahami perkembangan terbaru dalam praktik keperawatan. Menurut Manik, pelatihan yang berkelanjutan membantu perawat tetap up-to-date dengan standar praktik yang berlaku dan meningkatkan keterampilan mereka. Dengan demikian, institusi kesehatan harus menyediakan kesempatan bagi perawat untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan yang relevan.

3) Perlindungan hukum melalui asuransi professional

Perlindungan hukum melalui asuransi profesional adalah aspek penting dalam praktik keperawatan yang memberikan jaminan bagi perawat terhadap risiko hukum yang mungkin timbul akibat tindakan mereka dalam memberikan perawatan kepada pasien. Asuransi profesional membantu melindungi perawat dari tuntutan hukum yang dapat terjadi akibat malpraktik, kelalaian, atau kesalahan dalam praktik keperawatan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai perlindungan hukum melalui asuransi profesional, disertai dengan referensi yang relevan.

a) Definisi Asuransi Profesional

Asuransi profesional, atau sering disebut asuransi malpraktik, adalah jenis asuransi yang dirancang untuk melindungi profesional, termasuk perawat, dari risiko hukum yang mungkin timbul akibat tindakan yang dilakukan dalam kapasitas profesional mereka. Menurut Ramadiyanti, asuransi ini memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya, termasuk perawat, dalam situasi di mana mereka menghadapi tuntutan hukum Ramadiyanti (2024). Asuransi ini mencakup biaya hukum, ganti rugi, dan biaya lainnya yang terkait dengan tuntutan malpraktik.

b) Perlindungan Hukum bagi Perawat

Perawat yang memiliki asuransi profesional dapat merasa lebih aman dalam menjalankan praktik mereka. Syazali menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi sangat penting, terutama dalam konteks perjanjian baku yang sering kali lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi (Syazali, 2022). Dengan adanya asuransi, perawat dapat melindungi diri mereka dari risiko finansial yang dapat timbul akibat tuntutan hukum, sehingga mereka dapat fokus pada memberikan perawatan yang berkualitas kepada pasien.

c) Tanggung Jawab Hukum dan Etika

Asuransi profesional juga berfungsi sebagai pengingat bagi perawat untuk menjalankan praktik mereka sesuai dengan standar hukum dan etika. Majid mencatat bahwa pemahaman tentang tanggung jawab hukum dan etika sangat penting bagi perawat untuk menghindari situasi yang dapat menyebabkan tuntutan hukum (Majid, 2023). Dengan memiliki asuransi, perawat diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam tindakan mereka dan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

d) Penanganan Klaim dan Sengketa

Dalam situasi di mana klaim malpraktik diajukan, asuransi profesional dapat membantu perawat dalam menangani proses hukum. Menurut

Febriyanti, perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan hukum kepada pemegang polis dalam menghadapi klaim yang diajukan (Febriyanti, 2024). Ini mencakup penyelesaian sengketa melalui proses mediasi atau arbitrase, yang dapat mengurangi beban emosional dan finansial bagi perawat yang terlibat.

e) Edukasi dan Kesadaran

Penting bagi perawat untuk memahami manfaat dan batasan dari asuransi profesional. Yusrani et al. menunjukkan bahwa perlindungan asuransi dapat membantu perawat dalam merencanakan ke depan dan melindungi diri dari biaya perawatan kesehatan yang tidak terduga (Yusrani et al., 2023). Edukasi mengenai asuransi profesional harus menjadi bagian dari pelatihan dan pendidikan keperawatan untuk memastikan bahwa perawat memahami bagaimana asuransi dapat melindungi mereka dalam praktik sehari-hari.

3. Kasus-kasus Hukum yang Sering Dihadapi oleh Perawat

a. Malpraktek dan kelalaian

Malpraktik dan kelalaian adalah isu penting dalam dunia medis, termasuk keperawatan, yang dapat memiliki dampak signifikan pada pasien dan profesional kesehatan. Malpraktik terjadi ketika seorang profesional kesehatan gagal memenuhi standar perawatan yang diharapkan, yang mengakibatkan kerugian atau cedera pada pasien. Kelalaian, di sisi lain, merujuk pada kegagalan untuk mengambil tindakan yang diperlukan atau melakukan tindakan yang tidak semestinya, yang juga dapat menyebabkan kerugian. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai malpraktik dan kelalaian, serta referensi yang relevan.

1) Definisi Malpraktik dan Kelalaian

Malpraktik medis dapat didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang profesional kesehatan yang tidak memenuhi standar perawatan yang diharapkan, yang mengakibatkan cedera pada pasien. Menurut Nurarafah, malpraktik sering kali sulit dibedakan dari kelalaian, karena keduanya melibatkan kegagalan untuk memenuhi standar perawatan (Nurarafah, 2022). Namun, malpraktik biasanya melibatkan tindakan yang lebih serius yang menyebabkan kerugian langsung, sementara kelalaian mungkin mencakup kegagalan untuk bertindak.

2) Penyebab Malpraktik

Beberapa faktor dapat menyebabkan malpraktik, termasuk kurangnya pengetahuan atau keterampilan, komunikasi yang buruk antara anggota tim kesehatan, dan tekanan dari lingkungan kerja. Frakes mencatat bahwa

malpraktik dapat terjadi ketika dokter tidak mengikuti pedoman praktik yang telah ditetapkan, yang dapat mempengaruhi kualitas perawatan yang diberikan (Frakes, 2012). Dalam konteks keperawatan, perawat yang tidak mematuhi standar praktik atau gagal dalam dokumentasi dapat berisiko menghadapi tuntutan malpraktik.

3) Tanggung Jawab Hukum

Perawat memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan standar praktik yang berlaku. Menurut Nikkhahmanesh, perawat dapat dikenakan sanksi hukum jika mereka gagal memenuhi kewajiban ini, yang dapat mengakibatkan tuntutan malpraktik (Nurarafah, 2022). Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk memahami tanggung jawab hukum mereka dan memastikan bahwa mereka selalu memberikan perawatan yang aman dan efektif.

4) Perlindungan Hukum dan Asuransi Malpraktik

Perawat dapat melindungi diri mereka dari risiko malpraktik dengan memiliki asuransi malpraktik. Jena et al. menunjukkan bahwa asuransi ini dapat membantu menutupi biaya hukum dan ganti rugi yang mungkin timbul akibat tuntutan malpraktik (Jena et al., 2011). Dengan memiliki asuransi, perawat dapat merasa lebih aman dalam menjalankan praktik mereka, meskipun tetap harus mematuhi standar praktik yang berlaku.

5) Upaya untuk Mencegah Malpraktik

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan adalah kunci untuk mencegah malpraktik. Menurut Kosar, pelatihan yang tepat dapat membantu profesional kesehatan memahami risiko yang terkait dengan praktik mereka dan bagaimana cara menghindarinya (Lynch et al., 2021). Selain itu, penerapan pedoman praktik yang jelas dan komunikasi yang efektif antara anggota tim kesehatan juga dapat mengurangi risiko malpraktik.

b. Pelanggaran hak pasien

Pelanggaran hak pasien adalah isu penting dalam praktik keperawatan dan pelayanan kesehatan yang dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan pasien dan integritas profesional tenaga kesehatan. Pelanggaran ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk privasi, dan hak untuk mendapatkan perawatan yang berkualitas. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai pelanggaran hak pasien, disertai dengan referensi yang relevan.

1) Hak untuk Mendapatkan Informasi

Pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi kesehatan mereka, termasuk diagnosis, rencana

perawatan, dan risiko yang terkait. Menurut Margareta, perlindungan terhadap hak pasien yang terkena stroke menjadi sangat penting agar mereka memahami dan menghormati hak-hak mereka sebagai subjek hukum dalam konteks pelayanan medis (Margareta, 2023). Pelanggaran terhadap hak ini dapat terjadi jika tenaga kesehatan tidak memberikan informasi yang memadai atau tidak menjelaskan prosedur medis dengan jelas.

2) Hak untuk Privasi dan Kerahasiaan

Hak pasien untuk privasi dan kerahasiaan informasi medis adalah aspek fundamental dari etika medis. Fitria menekankan bahwa perlindungan hukum bagi pasien BPJS dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit mencakup hak untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan mereka (Fitria, 2024). Pelanggaran terhadap hak ini dapat terjadi jika informasi medis pasien dibagikan tanpa izin atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini dapat menyebabkan kerugian emosional dan reputasi bagi pasien.

3) Hak untuk Mendapatkan Perawatan yang Berkualitas

Pasien berhak mendapatkan perawatan yang berkualitas dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku. Alhumaira mencatat bahwa perlindungan hukum terhadap rumah sakit dalam menjaga kerahasiaan data medis pasien juga mencakup tanggung jawab untuk memberikan perawatan yang aman dan efektif (Alhumaira, 2023). Pelanggaran terhadap hak ini dapat terjadi jika pasien menerima perawatan yang tidak sesuai dengan standar, yang dapat mengakibatkan cedera atau komplikasi.

4) Hak untuk Mengajukan Keluhan

Pasien memiliki hak untuk mengajukan keluhan jika mereka merasa hak-hak mereka dilanggar. Lestari menyatakan bahwa dalam konteks telemedicine, hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang baik juga dilindungi, dan mereka dapat mengajukan pengaduan jika terjadi pelanggaran (Lestari, 2021). Pelanggaran terhadap hak ini dapat terjadi jika institusi kesehatan tidak menyediakan saluran yang jelas bagi pasien untuk mengajukan keluhan atau jika keluhan tidak ditangani dengan serius.

5) Perlindungan Hukum bagi Pasien

Pentingnya perlindungan hukum bagi pasien dalam konteks pelanggaran hak ini tidak dapat diabaikan. Kusumaningrum menekankan bahwa transaksi terapeutik antara dokter dan pasien menciptakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak (Kusumaningrum, 2017). Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan tindakan hukum terhadap tenaga kesehatan.

c. Pemberian informasi yang tidak memadai atau tidak jelas kepada pasien

Pemberian informasi yang tidak memadai atau tidak jelas kepada pasien dapat menimbulkan berbagai masalah dalam praktik keperawatan dan pelayanan kesehatan. Hal ini dapat berdampak negatif pada pemahaman pasien tentang kondisi kesehatan mereka, pilihan perawatan, dan risiko yang mungkin dihadapi. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai isu ini, disertai dengan referensi yang relevan.

1) Dampak Pemberian Informasi yang Tidak Memadai

Pemberian informasi yang tidak memadai dapat menyebabkan pasien merasa bingung dan tidak yakin tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam perawatan mereka. Arnanto et al. menunjukkan bahwa informasi mengenai prosedur medis, termasuk anestesi, harus disampaikan dengan jelas kepada pasien untuk memastikan bahwa mereka memahami indikasi, tujuan, risiko, dan manfaat dari tindakan yang akan dilakukan Arnanto et al. (2018). Ketidakjelasan dalam informasi dapat mengakibatkan pasien tidak memberikan persetujuan yang diinformasikan, yang merupakan pelanggaran terhadap hak pasien.

2) Kecemasan Pasien

Pemberian edukasi yang tidak memadai juga dapat meningkatkan kecemasan pasien. Davris mencatat bahwa edukasi kesehatan yang baik dapat membantu mengurangi kecemasan pasien sebelum menjalani prosedur medis, seperti kateterisasi jantung (Davris, 2023). Ketika pasien tidak menerima informasi yang cukup, mereka mungkin merasa cemas dan tidak siap menghadapi prosedur, yang dapat mempengaruhi hasil perawatan.

3) Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan kesehatan dapat menurun akibat kurangnya informasi yang diberikan kepada pasien. Inayatillah et al. menekankan bahwa pemberian informasi obat yang tepat dan lengkap sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan memastikan bahwa mereka menggunakan obat dengan benar (Inayatillah et al., 2023). Jika pasien tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang obat yang mereka konsumsi, hal ini dapat menyebabkan kesalahan penggunaan obat dan mengurangi efektivitas pengobatan.

4) Pemberian Informed Consent

Pemberian informasi yang jelas dan lengkap juga merupakan bagian penting dari proses informed consent. Prahesti dan Putriningrum menjelaskan bahwa pasien harus mendapatkan penjelasan yang jelas

mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, termasuk risiko dan alternatif yang ada, sebelum memberikan persetujuan (Prahesti & Putriningrum, 2021). Jika informasi yang diberikan tidak memadai, pasien mungkin tidak dapat membuat keputusan yang terinformasi, yang dapat mengakibatkan masalah hukum bagi tenaga kesehatan.

5) Upaya untuk Meningkatkan Pemberian Informasi

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Samsul et al. menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan empatik dapat meningkatkan kepuasan pasien dan membantu mereka memahami informasi yang diberikan (Samsul et al., 2022). Pelatihan dalam komunikasi dan edukasi pasien harus menjadi bagian dari pendidikan keperawatan untuk memastikan bahwa perawat dapat memberikan informasi yang jelas dan memadai kepada pasien.

4. Hukum tentang Persetujuan Tindakan Medis

a. Pengertian persetujuan pasien

Persetujuan pasien, atau yang lebih dikenal dengan istilah "informed consent," adalah proses di mana pasien diberikan informasi yang cukup dan jelas mengenai kondisi kesehatan mereka, prosedur medis yang akan dilakukan, serta risiko dan manfaat dari tindakan tersebut. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien dapat membuat keputusan yang terinformasi mengenai perawatan yang akan mereka terima. Persetujuan ini merupakan hak pasien yang diatur dalam berbagai regulasi dan kode etik medis.

1) Definisi Informed Consent

Informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah mereka menerima informasi yang lengkap tentang prosedur medis yang akan dilakukan. Menurut Irfan, sebelum melakukan tindakan medis, pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang tindakan medis yang harus dilakukan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis Irfan (2018). Ini mencakup penjelasan mengenai diagnosis, tujuan tindakan, alternatif yang tersedia, serta risiko dan manfaat yang mungkin timbul.

2) Pentingnya Informed Consent

Pentingnya informed consent terletak pada penghormatan terhadap otonomi pasien. Pasien berhak untuk mengetahui informasi yang relevan agar dapat membuat keputusan yang sesuai dengan nilai dan preferensi mereka. Tanpa persetujuan yang diinformasikan, tindakan medis yang

dilakukan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak pasien dan dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum bagi tenaga kesehatan.

3) Proses Pemberian Informed Consent

Proses pemberian informed consent harus dilakukan dengan cara yang transparan dan komunikatif. Amelia mencatat bahwa kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi sering kali tidak memadai, disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari dokter, perawat, maupun pasien mengenai pentingnya informed consent (Amelia, 2021). Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk menjelaskan semua informasi yang diperlukan dengan jelas dan memastikan bahwa pasien memahami apa yang mereka setuju.

4) Tantangan dalam Pemberian Informed Consent

Tantangan dalam pemberian informed consent sering kali muncul dalam situasi darurat atau ketika pasien tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan. Sidjabat dan Artanti menekankan bahwa dalam situasi seperti itu, perawat dan dokter harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan terbaik pasien (Sidjabat & Artanti, 2022). Ini dapat melibatkan komunikasi dengan keluarga pasien atau menggunakan perwakilan hukum jika diperlukan.

5) Perlindungan Hukum

Pemberian informed consent juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Menurut Afandi, pelaksanaan persetujuan tindakan medis yang kurang adekuat atau tidak sesuai dengan prosedur dapat menimbulkan komplain dan klaim baik dari pasien maupun keluarga, serta dapat menimbulkan masalah hukum bagi dokter (Afandi, 2018). Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa proses pemberian informed consent dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

b. Persetujuan tertulis dan lisan dalam praktik keperawatan

Persetujuan tertulis dan lisan adalah dua bentuk persetujuan yang penting dalam praktik keperawatan, yang memastikan bahwa pasien memahami dan setuju dengan tindakan medis yang akan dilakukan. Kedua bentuk persetujuan ini memiliki peran yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama penting untuk melindungi hak pasien dan memastikan bahwa mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka.

1) Persetujuan Tertulis

Persetujuan tertulis adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh pasien atau wakilnya, yang menunjukkan bahwa mereka telah menerima informasi yang cukup mengenai prosedur medis yang akan dilakukan. Menurut Hapsari, persetujuan tertulis sering kali diperlukan untuk prosedur yang invasif atau berisiko tinggi, seperti operasi atau perawatan yang melibatkan anestesi Rivai (2021). Dalam dokumen ini, pasien harus diberikan informasi mengenai:

- a) Diagnosis: Penjelasan mengenai kondisi kesehatan pasien.
- b) Tujuan Tindakan: Mengapa tindakan medis tersebut diperlukan.
- c) Risiko dan Manfaat: Penjelasan mengenai potensi risiko dan manfaat dari tindakan yang akan dilakukan.
- d) Alternatif: Informasi mengenai pilihan perawatan lain yang tersedia.

Persetujuan tertulis membantu melindungi tenaga kesehatan dari tuntutan hukum, karena menunjukkan bahwa pasien telah diberi informasi yang memadai dan telah memberikan persetujuan untuk tindakan yang akan dilakukan.

2) Persetujuan Lisan

Persetujuan lisan adalah bentuk persetujuan yang diberikan secara verbal oleh pasien. Menurut Ibrahim et al., persetujuan lisan sering kali digunakan dalam situasi di mana tindakan medis tidak invasif atau ketika situasi darurat memerlukan tindakan cepat (Ibrahim et al., 2022). Meskipun persetujuan lisan tidak selalu dicatat secara formal, perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus memastikan bahwa pasien memahami informasi yang diberikan sebelum memberikan persetujuan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun persetujuan lisan dapat diterima dalam banyak situasi, ada kalanya persetujuan tertulis diperlukan untuk melindungi semua pihak yang terlibat. Dalam situasi di mana pasien tidak dapat memberikan persetujuan lisan, seperti pada pasien yang tidak sadar, perawat harus mencari persetujuan dari keluarga atau wakil hukum pasien.

3) Tantangan dalam Pemberian Persetujuan

Tantangan dalam pemberian persetujuan, baik tertulis maupun lisan, sering kali muncul dalam situasi di mana pasien tidak sepenuhnya memahami informasi yang diberikan. Nurlina et al. mencatat bahwa perawat harus berusaha untuk menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami dan memberikan kesempatan bagi pasien untuk mengajukan pertanyaan (Nurlina et al., 2022). Selain itu, dalam konteks budaya yang berbeda, perawat harus sensitif terhadap nilai dan kepercayaan pasien yang dapat mempengaruhi keputusan mereka.

4) Perlindungan Hukum

Pemberian persetujuan yang tepat dan sesuai prosedur juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Menurut Surya dan Afrizal, pelaksanaan persetujuan yang tidak memadai dapat mengakibatkan masalah hukum dan tuntutan malpraktik (Surya & Afrizal, 2021). Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk memastikan bahwa semua langkah dalam proses persetujuan diikuti dengan benar.

5. Tantangan dalam mendapatkan persetujuan yang sah

Mendapatkan persetujuan yang sah dari pasien, atau informed consent, adalah aspek penting dalam praktik keperawatan dan pelayanan kesehatan. Namun, proses ini sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keabsahan persetujuan tersebut. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam mendapatkan persetujuan yang sah, disertai dengan referensi yang relevan.

a. Kurangnya Pemahaman Pasien

Salah satu tantangan terbesar dalam mendapatkan persetujuan yang sah adalah kurangnya pemahaman pasien tentang informasi yang diberikan. Irfan menjelaskan bahwa pasien sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur medis yang akan dilakukan, yang dapat menyebabkan mereka tidak sepenuhnya memahami risiko dan manfaat dari tindakan tersebut Irfan (2018). Hal ini dapat mengakibatkan pasien memberikan persetujuan tanpa informasi yang memadai, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

b. Komunikasi yang Tidak Efektif

Komunikasi yang tidak efektif antara tenaga kesehatan dan pasien juga dapat menjadi hambatan dalam proses persetujuan. Busro mencatat bahwa informasi yang disampaikan tidak selalu jelas atau mudah dipahami, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian pada pasien (Busro, 2018). Perawat dan dokter harus berusaha untuk menyampaikan informasi dengan cara yang sederhana dan jelas, serta memberikan kesempatan bagi pasien untuk mengajukan pertanyaan.

c. Tekanan Waktu

Dalam situasi klinis yang sibuk, tenaga kesehatan sering kali menghadapi tekanan waktu yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan informasi yang lengkap kepada pasien. Dalam kondisi darurat, perawat mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk menjelaskan semua aspek dari prosedur medis secara mendetail (Busro, 2018). Hal ini dapat

mengakibatkan pasien tidak mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang terinformasi.

d. Ketidakmampuan Pasien

Tantangan lain yang sering muncul adalah ketika pasien tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan, seperti pada pasien yang tidak sadar atau anak-anak. Dalam situasi seperti itu, perawat harus mencari persetujuan dari keluarga atau wakil hukum pasien. Namun, ini dapat menimbulkan dilema etika, terutama jika keluarga memiliki pandangan yang berbeda mengenai perawatan yang seharusnya diberikan (Busro, 2018).

e. Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian hukum mengenai persetujuan yang sah juga dapat menjadi tantangan. Menurut Pakpahan et al., peraturan mengenai informed consent dapat bervariasi tergantung pada konteks dan yurisdiksi, yang dapat membingungkan tenaga kesehatan (Pakpahan et al., 2020). Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk memahami regulasi yang berlaku dan memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur yang benar dalam mendapatkan persetujuan dari pasien.

D. Hubungan Etik dan Legal dalam Keperawatan

1. Keterkaitan antara Etik dan Hukum dalam Keperawatan

a. Peran etika dalam pembentukan hukum

Etika dan hukum memiliki hubungan yang erat dalam konteks pelayanan kesehatan, termasuk keperawatan. Etika berfungsi sebagai landasan moral yang membimbing perilaku profesional, sementara hukum memberikan kerangka regulasi yang mengatur tindakan tersebut. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai peran etika dalam pembentukan hukum, disertai dengan referensi yang relevan.

1) Etika sebagai Dasar Hukum

Etika sering kali menjadi dasar bagi pembentukan hukum. Ikhnadito menjelaskan bahwa untuk mewujudkan hukum sebagai "panglima" di negara hukum, perlu ada pembenahan etika dan moralitas di kalangan aparaturnya penegak hukum Ikhnadito (2023). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan ditegakkan dalam praktik.

2) Pengaruh Etika dalam Kebijakan Kesehatan

Etika juga berperan dalam pengembangan kebijakan kesehatan. Rosady et al. mencatat bahwa dalam praktik telekonsultasi klinis, pemenuhan kaidah etika, norma hukum, dan disiplin kedokteran merupakan upaya untuk

menjamin pemenuhan hak pasien (Rosady et al., 2022). Kebijakan yang dihasilkan dari pertimbangan etika dapat membantu melindungi hak-hak pasien dan memastikan bahwa mereka menerima perawatan yang sesuai.

3) Etika dalam Pengambilan Keputusan Medis

Dalam konteks pengambilan keputusan medis, etika memainkan peran penting dalam membimbing tenaga kesehatan untuk membuat keputusan yang mempertimbangkan kepentingan pasien. Sastroasmoro menyoroti bahwa masalah etika dalam praktik pediatri menciptakan tantangan tersendiri karena ketidakmampuan pasien untuk memberikan informed consent (Sastroasmoro, 2016). Dalam hal ini, etika membantu menentukan bagaimana keputusan harus diambil untuk melindungi kesejahteraan pasien.

4) Etika dan Tanggung Jawab Profesional

Etika juga berkontribusi pada pemahaman tentang tanggung jawab profesional. Meiliyana mencatat bahwa dokter yang bertanggung jawab harus menjunjung etika profesi dan memahami hukum kesehatan untuk mempertahankan praktik mereka (Meiliyana, 2024). Dengan demikian, etika membantu membentuk standar perilaku yang diharapkan dari tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas mereka.

5) Perlindungan Hukum Melalui Etika

Etika dapat memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Henky menekankan bahwa pelayanan etika klinis harus dibentuk di seluruh sarana pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi risiko tuntutan hukum (Henky, 2018). Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika, tenaga kesehatan dapat melindungi diri mereka dari risiko hukum yang mungkin timbul akibat tindakan mereka.

b. Tanggung jawab etis dan hukum yang saling melengkapi dalam Praktik Keperawatan

Tanggung jawab etis dan hukum dalam praktik keperawatan adalah dua aspek yang saling melengkapi dan sangat penting untuk memastikan bahwa perawat memberikan pelayanan yang berkualitas dan aman kepada pasien. Keduanya berfungsi untuk melindungi hak pasien dan memastikan bahwa perawat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tanggung jawab etis dan hukum yang saling melengkapi, disertai dengan referensi yang relevan.

1) Tanggung Jawab Etis

Tanggung jawab etis perawat mencakup kewajiban untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan standar etika profesi. Menurut Hussien dan

Hassona, perawat harus menjaga hak pasien, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, serta hak untuk membuat keputusan mengenai perawatan mereka Hussien & Hassona (2021). Tanggung jawab etis ini mencakup prinsip-prinsip seperti otonomi, benefisiensi, non-malefisiensi, dan keadilan, yang harus dipatuhi oleh perawat dalam setiap tindakan keperawatan.

2) Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum perawat berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang mengatur praktik keperawatan. Podgorica et al. menjelaskan bahwa perawat harus mematuhi semua regulasi yang berlaku, termasuk undang-undang perlindungan pasien dan standar praktik yang ditetapkan oleh lembaga regulasi (Podgorica et al., 2020). Kegagalan untuk mematuhi hukum dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk tuntutan malpraktik.

3) Keterkaitan antara Etika dan Hukum

Etika dan hukum sering kali saling melengkapi dalam praktik keperawatan. Klotz et al. mencatat bahwa pemahaman tentang etika membantu perawat dalam membuat keputusan yang tepat dan mematuhi hukum yang berlaku (Klotz et al., 2022). Misalnya, ketika perawat menghadapi dilema etika, mereka harus mempertimbangkan tidak hanya prinsip-prinsip etika, tetapi juga regulasi hukum yang mengatur tindakan mereka. Dengan demikian, etika memberikan panduan moral yang dapat membantu perawat dalam menjalankan tanggung jawab hukum mereka.

4) Perlindungan Hukum melalui Etika

Perlindungan hukum bagi perawat juga dapat diperoleh melalui penerapan prinsip-prinsip etika. Catlett dan Lovan menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang etis dapat meningkatkan kepuasan kerja perawat dan mengurangi risiko tuntutan hukum (Catlett & Lovan, 2011). Dengan menciptakan budaya etika yang kuat di tempat kerja, institusi kesehatan dapat membantu perawat merasa lebih aman dalam menjalankan praktik mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko malpraktik.

5) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam aspek etika dan hukum sangat penting untuk membantu perawat memahami tanggung jawab mereka. Akyüz et al. menekankan bahwa pelatihan yang memadai dapat meningkatkan pengetahuan perawat tentang isu-isu etika dan hukum, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam praktik sehari-hari (Suvarnakich, 2022). Dengan demikian, institusi kesehatan harus

menyediakan kesempatan bagi perawat untuk mengikuti pelatihan yang relevan.

2. Kasus-kasus yang menunjukkan interaksi etik dan legal

a. Konflik antara kewajiban moral dan hukum

Konflik antara kewajiban moral dan hukum adalah isu yang sering dihadapi oleh tenaga kesehatan, termasuk perawat, dalam praktik sehari-hari. Kewajiban moral berkaitan dengan prinsip etika dan nilai-nilai yang dipegang oleh individu, sedangkan hukum mengacu pada peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga berwenang. Ketika kedua aspek ini bertentangan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus menavigasi dilema yang kompleks. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai konflik ini, disertai dengan referensi yang relevan.

1) Definisi Kewajiban Moral dan Hukum

Kewajiban moral adalah tanggung jawab yang berasal dari nilai-nilai etika dan norma sosial yang diyakini oleh individu. Menurut Holijah, etika kedokteran berkaitan dengan penalaran dan pembenaran dalam membuat keputusan etis, sedangkan hukum berkaitan dengan konflik antara individu dan masyarakat Holijah (2023). Di sisi lain, tanggung jawab hukum adalah kewajiban untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang mengatur praktik keperawatan dan pelayanan kesehatan.

2) Contoh Konflik

Salah satu contoh konflik antara kewajiban moral dan hukum dapat terjadi dalam situasi di mana perawat harus memutuskan apakah akan melaporkan informasi yang dapat merugikan pasien. Misalnya, jika seorang pasien mengungkapkan niat untuk menyakiti diri sendiri, perawat mungkin merasa berkewajiban secara moral untuk melindungi pasien, tetapi hukum mungkin mengharuskan mereka untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Dalam situasi ini, perawat harus menyeimbangkan antara kewajiban moral untuk melindungi pasien dan kewajiban hukum untuk menjaga privasi mereka.

3) Pengaruh Etika dalam Pengambilan Keputusan

Etika memainkan peran penting dalam membantu tenaga kesehatan membuat keputusan yang tepat ketika menghadapi konflik antara kewajiban moral dan hukum. Menurut Haryansyah, etika dapat memberikan panduan bagi perawat dalam menentukan tindakan yang paling sesuai dalam situasi yang kompleks (haryansyah, 2023). Dengan memahami prinsip-prinsip etika, perawat dapat lebih baik menavigasi dilema yang

muncul dan membuat keputusan yang mencerminkan kepentingan terbaik pasien.

4) Tanggung Jawab Hukum dalam Praktik Keperawatan

Tanggung jawab hukum perawat mencakup kewajiban untuk mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam praktik keperawatan. Menurut Laksono, pelanggaran terhadap hukum dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk tuntutan malpraktik (Laksono, 2024). Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk memahami tanggung jawab hukum mereka dan memastikan bahwa mereka selalu memberikan perawatan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

5) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam aspek etika dan hukum sangat penting untuk membantu perawat memahami tanggung jawab mereka. Haryansyah mencatat bahwa pemahaman yang baik tentang etika dan hukum dapat membantu perawat dalam mengambil keputusan yang tepat dan menghindari konflik antara kewajiban moral dan hukum (haryansyah, 2023). Dengan demikian, institusi kesehatan harus menyediakan pelatihan yang memadai untuk memastikan bahwa perawat dapat memenuhi tanggung jawab profesional dan hukum mereka.

b. Keputusan yang mempengaruhi etika dan legalitas

Keputusan yang diambil oleh tenaga kesehatan, termasuk perawat, dalam praktik sehari-hari sering kali memiliki implikasi etika dan legal yang signifikan. Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien, tetapi juga dapat berdampak pada tanggung jawab hukum dan reputasi profesional. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai keputusan yang mempengaruhi etika dan legalitas, disertai dengan referensi yang relevan.

1) Pengambilan Keputusan Berbasis Etika

Keputusan yang diambil oleh perawat harus mempertimbangkan prinsip-prinsip etika, seperti otonomi, benefisiensi, non-malefisiensi, dan keadilan. Menurut Auliarrahma, keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etika dapat mengakibatkan pelanggaran hak pasien dan menurunkan kualitas perawatan Auliarrahma (2024). Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam setiap keputusan yang mereka buat.

2) Implikasi Hukum dari Keputusan Medis

Keputusan medis yang diambil oleh perawat juga memiliki implikasi hukum. Jasmine et al. menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan tanpa

persetujuan yang sah atau yang tidak sesuai dengan standar praktik dapat mengakibatkan tuntutan malpraktik (Jasmine et al., 2022). Dalam konteks ini, perawat harus memastikan bahwa mereka selalu mendapatkan persetujuan yang diinformasikan dari pasien sebelum melakukan tindakan medis.

3) Kewajiban untuk Melaporkan

Dalam beberapa situasi, perawat memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan informasi tertentu, seperti dugaan penyalahgunaan atau kondisi yang membahayakan pasien. Nurmadiyah menekankan bahwa kegagalan untuk melaporkan situasi yang memerlukan perhatian dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi perawat (Nurmadiyah, 2016). Oleh karena itu, perawat harus memahami kewajiban hukum mereka dalam melaporkan informasi yang relevan.

4) Pengaruh Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja juga dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh perawat. Prabowo dan Widanaputra mencatat bahwa tekanan dari rekan kerja atau manajemen dapat mempengaruhi keputusan etis yang diambil oleh perawat (Prabowo & Widanaputra, 2018). Dalam situasi seperti ini, penting bagi perawat untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika dan hukum, meskipun ada tekanan eksternal.

5) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam aspek etika dan hukum sangat penting untuk membantu perawat memahami tanggung jawab mereka. Mahmud menekankan bahwa pemahaman yang baik tentang etika dan hukum dapat membantu perawat dalam mengambil keputusan yang tepat dan menghindari konflik antara kewajiban moral dan hukum (Mahmud, 2020). Dengan demikian, institusi kesehatan harus menyediakan pelatihan yang memadai untuk memastikan bahwa perawat dapat memenuhi tanggung jawab profesional dan hukum mereka.

E. Latihan

1. Pilihan Ganda 5 Soal dengan opsi A SAMPAI E

Pilih jawaban yang paling benar soal pilihan ganda berikut dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf A/B/C/D atau E pilihan jawaban yang tersedia.

1) Kode etik yang mengatur hubungan antara perawat dan teman sejawat bertujuan untuk ...

A. Meningkatkan kompetisi antar perawat

B. Membangun hubungan kerja yang harmonis dan saling menghormati

- C. Mengurangi beban kerja perawat senior
 - D. Memastikan semua perawat bekerja sesuai jadwal
 - E. Memberikan penghargaan kepada perawat terbaik
- 2) Apa yang harus dilakukan seorang perawat jika terjadi konflik antara kode etik dan hukum?
- A. Mengutamakan kode etik profesi
 - B. Mengutamakan hukum yang berlaku
 - C. Mengabaikan keduanya jika membahayakan pasien
 - D. Berkonsultasi dengan pengacara rumah sakit
 - E. Melaporkan kepada organisasi profesi
- 3) Seorang perawat memberikan informasi medis palsu kepada pasien mengenai efek samping obat yang diberikan. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip etik apa?
- A. Justice
 - B. Veracity
 - C. Confidentiality
 - D. Beneficence
 - E. Nonmaleficence
- 4) Seorang pasien menolak untuk menjalani prosedur medis, tetapi perawat tetap melanjutkan prosedur tersebut tanpa persetujuan pasien. Tindakan ini melanggar prinsip hukum apa?
- A. Hak asasi manusia
 - B. Kerahasiaan informasi pasien
 - C. Otonomi pasien
 - D. Kewajiban profesional
 - E. Kode etik keperawatan
- 5) Seorang perawat terlihat menggunakan ponsel untuk bersosial media saat bertugas di ruang perawatan, mengabaikan panggilan dari pasien yang membutuhkan bantuan segera. Tindakan ini mencerminkan pelanggaran terhadap aspek apa dalam praktik keperawatan?
- A. Kualitas pelayanan kesehatan
 - B. Kerahasiaan pasien
 - C. Etika profesionalisme
 - D. Tanggung jawab sosial
 - E. Keterampilan teknis

2. Essay 5 Soal

Jawablah dengan benar pertanyaan berikut:

- 1) Seorang perawat di RSUD Marsidi Judono bersikap ketus dan tidak ramah kepada pasien yang berobat. Pasien tersebut mengeluh di media sosial, dan setelah dilakukan pemeriksaan, perawat tersebut terbukti melanggar kode etik. Apa langkah yang paling tepat dilakukan oleh pihak rumah sakit?*
- 2) Seorang pasien mengeluh bahwa informasi medis yang diberikan oleh perawat tidak sesuai dengan kenyataan. Perawat tersebut terbukti memberikan informasi palsu terkait efek samping obat. Prinsip etik apa yang dilanggar oleh perawat?*
- 3) Seorang bayi meninggal dunia setelah perawat memberikan suntikan tanpa meminta persetujuan keluarga pasien terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip etik apa?*
- 4) Seorang perawat di ruang IGD terlihat sibuk dengan ponselnya saat bertugas, sehingga mengabaikan panggilan pasien yang membutuhkan bantuan segera. Tindakan ini mencerminkan pelanggaran terhadap aspek apa dalam praktik keperawatan?*
- 5) Dalam sebuah rumah sakit, seorang perawat memberikan insulin kepada pasien tanpa memeriksa ulang dosis yang diresepkan dokter, sehingga menyebabkan komplikasi serius pada pasien tersebut. Apa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perawat?*

Kunci Jawaban

1. Kunci jawaban Pilihan Ganda

- 1) Kunci: B
- 2) Kunci: B
- 3) Kunci: B
- 4) Kunci: C
- 5) Kunci: C

2. Kunci Jawaban Essay

- 1) Kunci: Meminta maaf kepada pasien dan memberikan teguran kepada perawat
- 2) Kunci: Veracity
- 3) Kunci: Autonomy dan Nonmaleficence
- 4) Kunci: Profesionalisme dan tanggung jawab etika
- 5) Kunci: Tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) keperawatan

F. Rangkuman Materi

Buku ajar ini membahas mengenai pendahuluan yang berisi pengertian etik dan legal dalam keperawatan, pentingnya memahami etik dan legal dalam keperawatan dan tujuan pembahasannya. Etik dalam keperawatan merupakan sistem nilai dan prinsip yang mengatur perilaku profesional perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Pemahaman tentang kode etik profesi keperawatan sangat penting sebagai pegangan dalam menjalankan tugas. Penelitian oleh Tedjomuljo dan Afifah menunjukkan bahwa mahasiswa keperawatan memiliki pengetahuan baik tentang kode etik, namun kurang memahami aspek caring (Tedjomuljo & Afifah, 2016). Ini menunjukkan perlunya institusi pendidikan untuk lebih menekankan edukasi tentang kode etik dalam praktik. Latif menegaskan bahwa sikap positif perawat terkait motivasi melaksanakan praktik keperawatan profesional (Latif, 2023), menunjukkan bahwa pemahaman etik yang baik dapat meningkatkan motivasi dan kinerja perawat. Etik dalam keperawatan juga berkaitan dengan tanggung jawab hukum. Setiani menjelaskan bahwa perawat perlu menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik untuk menghindari masalah hukum akibat kelalaian (Setiani, 2018). Pelatihan yang tepat dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip etik dan hukum sangat diperlukan. Dilema etik sering dihadapi perawat dalam situasi klinis kompleks. Ose mengungkapkan bahwa perawat harus membuat keputusan sulit, terutama dalam merawat pasien yang terlantar (Ose, 2017). Pemahaman mendalam tentang etik penting dalam membantu perawat mengambil keputusan yang tepat.

Legalitas dalam keperawatan mencakup tanggung jawab hukum dan kewajiban profesional perawat dalam memberikan asuhan kepada pasien. Ini tidak hanya melibatkan pemahaman hukum yang mengatur profesi, tetapi juga penerapan prinsip etik dalam konteks hukum. Dokumentasi yang tepat adalah salah satu aspek penting dari tanggung jawab hukum. Larsen menekankan bahwa catatan klien yang akurat dapat memberikan perlindungan hukum bagi perawat dalam kasus litigasi (Larsen, 2011). Asadi menunjukkan bahwa perawat bertanggung jawab untuk menerapkan perintah medis dengan benar, dan kesalahan dalam implementasi dapat menyebabkan komplikasi hukum (Asadi, 2024). Perawat juga harus memahami hak pasien dan kewajiban menjaga kerahasiaan serta mendapatkan persetujuan yang diinformasikan. El-Azzab dan Mohamed menunjukkan hubungan positif antara pengetahuan hukum dan praktik etis di kalangan perawat (El-Azzab & Mohamed, 2021). Hussain et al. menyoroti perlunya perawat melaporkan reaksi obat yang merugikan (Hussain et al., 2020). Dilema hukum muncul ketika perawat harus menolak perintah medis yang dianggap tidak

sesuai. Asadi et al. mencatat bahwa perawat memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan menolak perintah dokter yang tidak sesuai (Asadi et al., 2023).

Memahami etik dan legal dalam praktik keperawatan sangat penting untuk memastikan pelayanan berkualitas, aman, dan sesuai dengan standar profesional. Pemahaman etik mencakup prinsip moral yang harus diikuti perawat. Rivai menjelaskan bahwa pengambilan keputusan etik melibatkan kolaborasi antarprofesional dan partisipasi pasien (Rivai, 2021). Pashar et al. menyoroti tantangan etik yang dihadapi perawat selama pandemi COVID-19 (Pashar et al., 2020). Aspek legal mencakup tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi perawat. Setiani menekankan bahwa perawat harus menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik (Setiani, 2018). Dokumentasi yang tepat adalah bagian penting dari tanggung jawab hukum. Zaman menyatakan bahwa dokumentasi yang baik merupakan bukti kinerja perawat (Zaman, 2024). Perawat juga harus memahami hak pasien dan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi. Galenso dan Yuwono menunjukkan pentingnya memahami prosedur hukum dalam pelayanan (Galenso & Yuwono, 2022). Kewajiban ini menunjukkan pentingnya pelatihan hukum. Dilema hukum sering muncul ketika perawat harus menolak perintah medis yang tidak sesuai. Asadi et al. mencatat bahwa perawat harus memeriksa dan menolak perintah dokter yang tidak sesuai (Asadi et al., 2023).

Pembahasan tentang etik dan legal dalam keperawatan bertujuan untuk memastikan perawat dapat memberikan pelayanan berkualitas, aman, dan sesuai standar profesional. Tujuan utama adalah meningkatkan pemahaman perawat mengenai kode etik profesi keperawatan. Tedjomuljo dan Afifah menyatakan bahwa pengetahuan tentang kode etik dan prinsip caring harus dimiliki mahasiswa keperawatan (Tedjomuljo & Afifah, 2016). Pembahasan ini juga menyoroti pentingnya pemahaman tanggung jawab hukum dalam praktik keperawatan. Pembahasan ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis dilema etik yang sering dihadapi perawat dalam praktik sehari-hari. Banunaek et al. menunjukkan bahwa dilema etik dapat mempengaruhi sikap profesional perawat (Banunaek et al., 2021). Selain itu, pembahasan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya dokumentasi yang tepat dalam praktik keperawatan. Wahyuliati dan Novita menekankan bahwa dokumentasi yang baik merupakan bagian integral dari pelayanan keperawatan berkualitas (Wahyuliati & Novita, 2023).

Bahasan berikutnya dalam buku ajar ini tentang Etik dalam Keperawatan. Etika dalam keperawatan merujuk pada prinsip moral yang mengatur perilaku perawat dalam memberikan asuhan. Etika berfungsi sebagai pedoman untuk membuat keputusan yang tepat dan menjaga integritas dalam praktik. Nandiwardhana mendefinisikan etika sebagai pedoman bagi individu dalam bertindak berdasarkan

nilai moral yang diakui (Nandiwardhana, 2020). Prinsip-prinsip seperti otonomi, benefisiensi, non-malefisiensi, dan keadilan merupakan bagian dari etika keperawatan. Otonomi mengacu pada hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka. Haerani et al. menjelaskan bahwa etika juga mencakup pemahaman tentang norma yang bervariasi tergantung konteks budaya dan sosial (Haerani et al., 2022). Perawat sering dihadapkan pada dilema etik yang memerlukan pertimbangan cermat, terutama ketika nilai pribadi bertentangan dengan kebutuhan pasien. Nurhayati et al. menekankan bahwa perilaku etis perawat, termasuk komunikasi baik dan empati, sangat penting untuk menciptakan lingkungan perawatan yang aman (Nurhayati et al., 2020).

Prinsip-prinsip Etik dalam Keperawatan autonomi, beneficence, non-maleficence, justice dan fidelity. Autonomi dalam keperawatan merujuk pada kebebasan pasien untuk membuat keputusan terkait perawatan mereka. Sinkfield-Morey menjelaskan bahwa pengakuan terhadap kemampuan pasien dalam membuat keputusan adalah aspek moral dan etis fundamental (Sinkfield-Morey, 2018). Beneficence adalah kewajiban perawat untuk bertindak demi kebaikan pasien. Cheraghi et al. menekankan bahwa prinsip ini merupakan bagian integral dari misi profesi keperawatan (Cheraghi et al., 2023). Non-maleficence menekankan kewajiban untuk tidak merugikan pasien. Bhagwat dan Pai menjelaskan bahwa prinsip ini mengharuskan tenaga medis untuk menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian (Bhagwat & Pai, 2020). Keadilan dalam pemberian perawatan menekankan perlunya distribusi sumber daya kesehatan secara adil kepada semua pasien. Miller mencatat bahwa penyedia layanan kesehatan harus mengakui dampak diskriminasi terhadap hasil kesehatan (Miller, 2023). Fidelity merujuk pada kesetiaan pada janji dan komitmen. Klaic et al. menjelaskan bahwa perawat harus dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan pasien (Klaic et al., 2022).

Dilema Etik dalam Keperawatan antara lain: 1) Konflik antara Kewajiban Profesional dan Keinginan Pasien. Konflik ini sering muncul ketika keinginan pasien tidak sejalan dengan rekomendasi medis. Enggune et al. menyatakan bahwa perawat harus berkomunikasi efektif untuk menjelaskan risiko dan manfaat pilihan (Enggune et al., 2015). 2) Isu-isu Etika dalam Perawatan Akhir Hayat. Otonomi pasien, komunikasi efektif, dan pengambilan keputusan bersama adalah isu penting dalam perawatan akhir hayat. Houska dan Loučka menekankan pentingnya menghormati otonomi pasien (Houska & Loučka, 2019). 3) Privasi dan Kerahasiaan Informasi Medis. Privasi dan kerahasiaan informasi medis adalah aspek penting dalam praktik keperawatan. Wiyono menjelaskan bahwa penggunaan algoritma enkripsi dapat melindungi informasi medis pasien (Wiyono, 2023). 4) Tanggung Jawab Moral

Perawat. Menjaga integritas profesi, kewajiban terhadap kesejahteraan pasien, dan komunikasi yang jelas adalah aspek penting dalam tanggung jawab moral perawat.

Legal dalam Keperawatan didefinisikan Hukum dalam keperawatan mencakup aturan yang mengatur praktik, termasuk hak dan kewajiban perawat serta pasien. Registrasi dan lisensi yang sesuai sangat penting (Liani, 2023). Dalam bahasan ini mencakup asas-asas hukum yang relevan, peraturan dan regulasi terkait praktik keperawatan serta peran perawat dalam mencegah tuntutan hukum. Kewajiban profesional dan tanggung jawab hukum perawat mencakup memberikan perawatan berkualitas, menghormati otonomi pasien, dan menjaga kerahasiaan informasi (Setiani, 2018). Peraturan dan regulasi terkait praktik keperawatan mencakup lisensi, kode etik, dan standar praktik yang harus dipatuhi. Dokumentasi yang akurat dan tepat waktu adalah bagian penting dari tanggung jawab hukum perawat (Fujiwan, 2019). Peran perawat dalam mencegah tuntutan hukum dengan melaksanakan dokumentasi yang tepat dan mengikuti standar praktik yang berlaku.

Hubungan etik dan legal dalam keperawatan meliputi keterkaitan antara etik dan hukum dalam keperawatan serta tanggungjawab etis dan hukum yang saling melengkapi. Etika berfungsi sebagai dasar hukum, mempengaruhi kebijakan kesehatan dan pengambilan keputusan medis. Perlindungan hukum dapat diperoleh melalui penerapan prinsip-prinsip etika (Ikhnadito, 2023). Tanggung jawab etis mencakup kewajiban untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan standar etika, sementara tanggung jawab hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Hussien & Hassona, 2021). Kasus-kasus yang menunjukkan interaksi etik dan legal berhubungan konflik antara kewajiban moral dan hukum sering muncul dalam praktik keperawatan, memerlukan pertimbangan etika dan hukum dalam pengambilan keputusan.

G. Glosarium

Etik dalam Keperawatan: Sistem nilai dan prinsip yang mengatur perilaku profesional perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien, mencakup kewajiban moral, tanggung jawab hukum, dan profesionalisme.

Kode Etik Profesi Keperawatan: Pedoman yang berfungsi sebagai acuan bagi perawat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Dilema Etik: Situasi di mana perawat harus membuat keputusan sulit yang melibatkan pertimbangan moral dan etika, sering kali dalam konteks klinis yang kompleks.

Tanggung Jawab Hukum: Kewajiban perawat untuk menjalankan praktik keperawatan sesuai dengan standar pelayanan dan hukum yang berlaku, serta untuk menghindari kelalaian.

Dokumentasi: Proses pencatatan informasi tentang pasien dan tindakan keperawatan yang dilakukan, penting untuk perlindungan hukum dan akuntabilitas perawat.

Persetujuan yang Diinformasikan: Proses di mana pasien diberikan informasi yang cukup untuk membuat keputusan mengenai perawatan mereka, termasuk risiko dan manfaat.

Hak Pasien: Kewajiban perawat untuk menghormati dan melindungi hak-hak pasien, termasuk kerahasiaan informasi dan otonomi dalam pengambilan keputusan.

Prinsip Caring: Aspek dari praktik keperawatan yang menekankan perhatian dan empati terhadap pasien, penting dalam membangun hubungan terapeutik.

Pelatihan Keperawatan: Proses pendidikan yang bertujuan untuk membekali perawat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk praktik profesional.

Interprofessional Education (IPE): Pendidikan yang melibatkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Caring: sikap peduli yang dimiliki perawat terhadap pasien, yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien. Penerapan perilaku caring diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang prinsip etik dan mencegah tindakan malpraktik.

Motivasi Profesional: Dorongan internal yang mempengaruhi sikap dan kinerja perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan. Sikap positif perawat berhubungan erat dengan motivasi mereka untuk memberikan pelayanan berkualitas.

Pendidikan Keperawatan: Proses edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa keperawatan mengenai kode etik dan penerapannya dalam praktik sehari-hari.

Pelatihan Etik dan Hukum: Kegiatan pendidikan yang diperlukan bagi perawat untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip etik serta tanggungjawab hukum dalam praktik keperawatan.

Standar Pelayanan Keperawatan: Kriteria yang ditetapkan untuk memastikan bahwa praktik keperawatan dilakukan dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan kode etik serta regulasi yang berlaku.

Legalitas dalam Praktik Keperawatan: Kepatuhan terhadap hukum yang mengatur profesi keperawatan, termasuk penerapan prinsip etika yang relevan untuk melindungi pasien dan perawat dari masalah hukum akibat kelalaian atau kesalahan.

Dokumentasi: Proses pencatatan informasi tentang pasien yang dilakukan oleh perawat, baik secara elektronik maupun tulisan tangan. Dokumentasi yang tepat dan akurat penting untuk perlindungan hukum dalam kasus litigasi.

Tanggung Jawab Hukum Perawat: Kewajiban perawat untuk memahami dan menerapkan hukum yang mengatur praktik keperawatan, termasuk penerapan perintah medis dengan benar untuk menghindari komplikasi hukum.

Persetujuan yang diinformasikan : Proses dimana pasien diberikan informasi yang cukup mengenai prosedur medis sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sadar mengenai perawatan mereka.

Kerahasiaan Pasien : Kewajiban perawat untuk menjaga informasi pribadi dan kesehatan pasien agar tetap rahasia, sesuai dengan regulasi hukum dan etika.

Pengetahuan Hukum : Pemahaman tentang hukum yang mengatur praktik keperawatan, termasuk hak-hak pasien dan tanggung jawab perawat. Pengetahuan ini penting untuk meningkatkan kualitas praktik keperawatan.

Dilema Hukum : Situasi di mana perawat harus mengambil keputusan sulit terkait dengan kewajiban hukum, seperti menolak perintah medis yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi pasien.

Komunikasi Profesional : Interaksi antara perawat dan dokter yang efektif dan transparan, penting untuk memastikan keselamatan pasien dan memenuhi kewajiban hukum.

Pelatihan Hukum bagi Perawat : Proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perawat tentang aspek hukum dalam praktik keperawatan, termasuk tanggung jawab dan hak-hak pasien.

Legalitas dalam Keperawatan : Aspek hukum yang mengatur praktik keperawatan, termasuk tanggung jawab hukum dan kewajiban perawat untuk mematuhi standar pelayanan dan kode etik yang telah ditetapkan.

Pengambilan Keputusan Etik: Proses di mana perawat, dengan kolaborasi antarprofesional dan partisipasi pasien, menentukan nilai dan tujuan perawatan. Ini melibatkan komunikasi yang efektif dan penghormatan terhadap otonomi pasien.

Otonomi Pasien: Hak pasien untuk membuat keputusan mengenai perawatan mereka sendiri. Penghormatan terhadap otonomi pasien merupakan aspek penting dalam praktik keperawatan yang etis.

Tantangan Etik: Situasi sulit yang dihadapi perawat dalam praktik, seperti selama pandemi COVID-19, di mana mereka harus membuat keputusan yang berdampak pada kualitas pelayanan.

Tanggung Jawab Hukum Perawat: Kewajiban perawat untuk menjalankan praktik keperawatan sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik, serta memahami implikasi hukum dari tindakan mereka.

Dokumentasi dalam Keperawatan: Proses pencatatan informasi tentang pasien dan tindakan keperawatan yang dilakukan. Dokumentasi yang tepat berfungsi sebagai bukti kinerja perawat dan penting dalam situasi litigasi.

Standar Hukum Dokumentasi: Kriteria yang harus dipatuhi oleh perawat dalam menyusun dokumentasi untuk memastikan bahwa catatan tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hak Pasien: Kewajiban perawat untuk memahami dan melindungi hak-hak pasien, termasuk hak atas kerahasiaan informasi kesehatan mereka.

Kerahasiaan Informasi Pasien: Kewajiban perawat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan kesehatan pasien, sesuai dengan regulasi hukum dan etika.

Pelayanan Gawat Darurat: Situasi di mana perawat harus memberikan pelayanan cepat dan tepat kepada pasien dalam kondisi kritis. Pemahaman prosedur hukum dalam konteks ini sangat penting.

Etika dalam Keperawatan: Prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku perawat dalam memberikan asuhan kepada pasien. Etika berfungsi sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan yang tepat dan menjaga integritas serta profesionalisme.

Kode Etik Profesi: Sekumpulan norma dan aturan yang mengatur perilaku profesional perawat. Kode etik ini membantu perawat dalam menjalankan tugasnya dengan mempertimbangkan tanggung jawab moral dan kewajiban terhadap pasien.

Otonomi: Hak pasien untuk membuat keputusan mengenai perawatan mereka sendiri. Penghormatan terhadap otonomi pasien merupakan bagian penting dari praktik keperawatan yang etis.

Benefisiensi: Kewajiban perawat untuk melakukan tindakan yang bermanfaat bagi pasien, memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan memberikan manfaat maksimal.

Non-malefisiensi: Prinsip yang mengharuskan perawat untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan pasien. ini mencakup segala bentuk kelalaian atau kesalahan dalam praktik keperawatan.

Keadilan: Prinsip yang menekankan perlunya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua pasien tanpa diskriminasi, serta memastikan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan.

Dilema Etik: Situasi kompleks dimana perawat harus menghadapi konflik antara nilai-nilai pribadi dan kebutuhan atau keinginan pasien. dilema ini memerlukan pertimbangan cermat untuk pengambilan keputusan.

Norma dan Aturan Budaya: Standar perilaku yang dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan sosial, mempengaruhi cara perawat berinteraksi dengan pasien dan mengambil keputusan etis.

Komunikasi Etis: Kemampuan perawat untuk berkomunikasi dengan baik dengan pasien termasuk mendengarkan dengan empati dan menghormati hak-hak pasien, yang penting untuk membangun hubungan terapeutik.

Lingkungan Perawatan yang Aman: Kondisi dimana pasien merasa dihargai dan terlindungi, berkat perilaku etis perawat yang menciptakan suasana dukungan dalam proses penyembuhan.

Veracity: Prinsip etika yang mengharuskan perawat memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada pasien.

Pengelolaan Konflik (Conflict Management): Teknik yang digunakan perawat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam konteks profesional, baik dengan pasien maupun rekan kerja.

Vulnerable Populations: Kelompok pasien yang memiliki resiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan atau kesulitan dalam mengakses perawatan medis yang tepat.

Healthcare System: Jaringan yang terdiri dari berbagai fasilitas dan tenaga medis yang bekerja bersama untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Safe Nursing Practice: Praktik yang mengutamakan keselamatan pasien melalui penggunaan prosedur yang tepat, komunikasi yang jelas, dan pengawasan yang adekuat.

Medical Decision-Making: Proses dimana perawat dan dokter bersama-sama membuat keputusan mengenai perawatan terbaik untuk pasien berdasarkan bukti medis dan preferensi pasien.

Nursing License: Sertifikasi yang diberikan kepada perawat setelah menyelesaikan pendidikan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat berpraktik secara sah.

Nursing Training: Proses pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan etis perawat dalam melaksanakan tugas mereka.

Nursing Evaluation: Proses menilai hasil tindakan keperawatan yang telah dilakukan, untuk memastikan bahwa tujuan perawatan tercapai.

Faktor Sosial (Social Factors); Kondisi sosial pasien yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka, termasuk status ekonomi, lingkungan sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi keputusan medis.

Hak Asasi Manusia (Human Rights): Hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu yang harus dihormati oleh semua pihak, termasuk dalam praktik keperawatan, seperti hak atas perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi.

Indikator Kinerja (Performance Indicators): Ukuran parameter yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan, termasuk keperawatan, dan efektivitas perawatan yang diberikan.

Kolaborasi Antar Profesional (Interprofessional Collaboration): Kerjasama antara berbagai profesional kesehatan, seperti dokter, perawat, dan apoteker, untuk memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien.

Kepatuhan (Compliance): Tingkat dimana pasien mengikuti instruksi medis atau perawatan yang diberikan oleh perawat dan tenaga kesehatan lainnya.

Komunikasi Terapeutik (Therapeutic Communication): Proses komunikasi antara perawat dan pasien yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pasien melalui hubungan yang saling mendukung dan empatik.

Kualitas Pelayanan (Service Quality): Tingkat kepuasan pasien terhadap perawatan yang diberikan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketrampilan perawat, fasilitas, dan prosedur yang diterapkan.

Intervensi Keperawatan (Nursing Intervention): Tindakan yang diambil oleh perawat untuk memenuhi kebutuhan pasien dan mencapai tujuan perawatan yang telah ditentukan.

Perlindungan Hukum (Legal Protection): Langkah-langkah yang diambil untuk melindungi perawat dan pasien dari resiko hukum melalui kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku dalam praktik keperawatan.

Persetujuan Tertulis (Written Consent): Persetujuan yang diberikan oleh pasien secara tertulis setelah diberikan informasi yang jelas tentang prosedur medis yang akan dilakukan.

Inform Consent: Proses dimana pasien diberikan informasi yang cukup mengenai prosedur medis sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sadar tentang perawatan mereka.

Perawatan Paliatif: Perawatan yang berfokus pada pengelolaan gejala pasien yang tidak dapat disembuhkan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien diakhir hayat.

Advokasi (Advocacy): Tindakan perawat untuk membela hak-hak pasien, memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan pasien dihormati dalam praktik keperawatan.

Asuransi Malpraktik (Malpractice Insurance): Jenis asuransi yang memberikan perlindungan hukum kepada perawat jika mereka menghadapi tuntutan hukum akibat kelalaian atau malpraktik dalam keperawatan.

Beban Kerja (Workload): Jumlah tugas atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perawat dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja dapat mempengaruhi kualitas perawatan yang diberikan.

Bukti Hukum (Legal Evidence): Informasi atau dokumentasi yang digunakan untuk mendukung keputusan hukum atau membela tindakan perawat dalam situasi litigasi.

Ceklis Keperawatan (Nursing Checklist): Daftar pemeriksaan yang digunakan oleh perawat untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam perawatan pasien dilakukan dengan benar dan sesuai standar.

Delegasi (Delegation): Proses pemberian tugas dari perawat kepada tenaga kesehatan lainnya yang lebih rendah tingkatannya, seperti asisten perawat, dengan tetap bertanggungjawab atas hasilnya.

H. Daftar Pustaka

- (2023). Etika antar tenaga medis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. *Lentera Perawat*, 4(2), 131-137. <https://doi.org/10.52235/lp.v4i2.249>
- (2023). Etika dan moral penegakan hukum.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xjyzm>
- Afandi, D. (2018). Aspek medikolegal dan tata laksana persetujuan tindakan kedokteran. *Jurnal Kesehatan Melayu*, 1(2), 99. <https://doi.org/10.26891/jkm.v1i2.2018.99-105>
- Ahmadi, A. (2023). Pelaksanaan discharge planning keluarga penderita tuberculosis paru. *Indonesian Journal of Professional Nursing*, 4(1), 21. <https://doi.org/10.30587/ijpn.v4i1.5625>
- Alhumaira, N. (2023). Perlindungan hukum terhadap rumah sakit sebagai upaya melindungi kerahasiaan data medis pasien yang diminta oleh aparat penegak hukum dalam perspektif hukum positif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(1), 14-27. <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i1.97>
- Aliza, N., Prianto, Y., & Rahaditya, R. (2022). Regulasi proteksi data pribadi pasien covid-19 di indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora Dan Seni*, 6(1), 248. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13462.2022>
- Amelia, D. (2021). Kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi (informed consent) pada pasien bedah rawat inap di rumah sakit x bandung. *Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(11), 1468-1475. <https://doi.org/10.36418/cerdika.v1i11.224>
- Anam, A., Santoso, A., Suryanto, S., Sukendar, S., & Prayitno, J. (2022). Komunikasi keperawatan sebagai budaya keselamatan pasien dalam upaya pencegahan malpraktik perdata. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3). <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3408>
- Ariani, S. (2023). Analisis keberhasilan implementasi rekam medis elektronik dalam meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan. *Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, 2(2), 7-14. <https://doi.org/10.56127/jukeke.v2i2.720>
- Arnanto, Y., Sitanggang, R., & Sitio, N. (2018). Perbandingan pemberian informasi verbal dengan presentasi video terhadap pengetahuan prosedur anestesi umum pada pasien yang akan menjalani operasi di rsup dr hasan sadikin

- bandung. *Jurnal Anestesi Perioperatif*, 6(3), 183-192. <https://doi.org/10.15851/jap.v6n3.1351>
- Asadi, M. (2024). A grounded theory of the implementation of medical orders by clinical nurses. *BMC Nursing*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12912-024-01775-6>
- Auliarrahma, N. (2024). Orientasi pembentukan karakter individu yang beretika: peran strategis keluarga. *jpa*, 1(3), 14. <https://doi.org/10.47134/jpa.v1i3.335>
- Banunaek, C., Dewi, Y., & Rita, M. (2021). Dilema etik pada profesionalisme perawat terhadap kualitas pelayanan keperawatan. *Jurnal Kepemimpinan Dan Manajemen Keperawatan*, 4(2), 110-120. <https://doi.org/10.32584/jkmm.v4i2.1143>
- Beardon, S., Woodhead, C., Cooper, S., Ingram, E., Genn, H., & Raine, R. (2021). International evidence on the impact of health-justice partnerships: a systematic scoping review. *Public Health Reviews*, 42. <https://doi.org/10.3389/phrs.2021.1603976>
- Beykmirza, R., Nikfarid, L., Negarandeh, R., Sarkhani, N., & Cherati, M. (2022). Development and validation of an instrument to measure pediatric nurses' adherence to ethical codes. *BMC Medical Ethics*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12910-022-00753-4>
- Bhagwat, S. and Pai, S. (2020). Medical ethics in laboratory medicine: a review, with an oath for pathologists. *Indian Journal of Medical Ethics*, 05(01), 39-44. <https://doi.org/10.20529/ijme.2020.02>
- Busro, A. (2018). Aspek hukum persetujuan tindakan medis (inform consent) dalam pelayanan kesehatan. *Law Development and Justice Review*, 1(1), 1-18. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570>
- Cartwright, C., White, B., Willmott, L., Williams, G., & Parker, M. (2015). Palliative care and other physicians' knowledge, attitudes and practice relating to the law on withholding/withdrawing life-sustaining treatment: survey results. *Palliative Medicine*, 30(2), 171-179. <https://doi.org/10.1177/0269216315587996>
- Catlett, S. and Lovan, S. (2011). Being a good nurse and doing the right thing: a replication study. *Nursing Ethics*, 18(1), 54-63. <https://doi.org/10.1177/0969733010386162>
- Cheraghi, R., Valizadeh, L., Zamanzadeh, V., Hassankhani, H., & Jafarzadeh, A. (2023). Clarification of ethical principle of the beneficence in nursing care: an integrative review. *BMC Nursing*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01246-4>
- Davris, W. (2023). Edukasi kesehatan terhadap kecemasan pasien pra-kateterisasi dengan diagnostik jantung koroner. *Jik Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(2), 287. <https://doi.org/10.33757/jik.v7i2.724>

- Detering, K., Hancock, A., Reade, M., & Silvester, W. (2010). The impact of advance care planning on end of life care in elderly patients: randomised controlled trial. *BMJ*, 340(mar23 1), c1345-c1345. <https://doi.org/10.1136/bmj.c1345>
- El-Azzab, S. and Mohamed, S. (2021). Barriers of applying the ethical and legal issues in psychiatric nursing and its relation to staff nurses' knowledge. *Tanta Scientific Nursing Journal*, 22(3), 187-211. <https://doi.org/10.21608/tsnj.2021.199045>
- Enggune, M., Ibrahim, K., & Agustina, H. (2015). Persepsi perawat neurosurgical critical care unit terhadap perawatan pasien menjelang ajal. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jkp.v2i1.80>
- Fauzi, M. (2024). Penambahan fitur multi-factor authentication dalam studi kasus sistem informasi rekam medis rumah sakit. *Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(4), 2938-2944. <https://doi.org/10.36040/jati.v7i4.7305>
- Febriyanti, E. (2024). Perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam bentuk penolakan klaim polis asuransi yang telah diberikan ke otoritas jasa keuangan. *Action Research Literate*, 8(5). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i5.351>
- Fidianti, N. and Sugiarti, I. (2022). Tinjauan manajemen informasi dan rekam medis (mirm) 11 dan 14 standar nasional akreditasi rumah sakit (snars) di rsu x tasikmalaya tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (Jipiki)*, 7(2), 117-125. <https://doi.org/10.52943/jipiki.v7i2.986>
- Fitria, A. (2024). Studi literature perlindungan hukum bagi pasien bpjs dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. *Indonesian Journal of Health Science*, 4(3), 246-255. <https://doi.org/10.54957/ijhs.v4i3.923>
- Ford-Gilboe, M., Wathen, C., Varcoe, C., Herbert, C., Jackson, B., Lavoie, J., ... & Browne, A. (2018). How equity-oriented health care affects health: key mechanisms and implications for primary health care practice and policy. *Milbank Quarterly*, 96(4), 635-671. <https://doi.org/10.1111/1468-0009.12349>
- Frakes, M. (2012). Does medical malpractice deter? the impact of tort reforms and malpractice standard reforms on healthcare quality. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2090595>
- Fujiwan, A. (2019). Konsep dokumentasi asuhan keperawatan.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4zc38>
- Galenso, N. and Yuwono, D. (2022). Kewajiban perawat dalam pelayanan gawat darurat. *Poltekita Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 888-897. <https://doi.org/10.33860/pjpm.v3i4.1279>
- Gea, K. (2020). Penerapan perencanaan keperawatan dan implementasi di rumah sakit.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/3gmz2>
- Georgiou, E., Papathanassoglou, E., & Pavlakis, A. (2015). Nurse-physician collaboration and associations with perceived autonomy in cypriot critical care

- nurses. *Nursing in Critical Care*, 22(1), 29-39.
<https://doi.org/10.1111/nicc.12126>
- Gu, L., Tian, B., Xin, Y., Zhang, S., Li, J., & Sun, Z. (2022). Patient perception of doctor communication skills and patient trust in rural primary health care: the mediating role of health service quality. *BMC Primary Care*, 23(1).
<https://doi.org/10.1186/s12875-022-01826-4>
- Haerani, R., Rosdiana, R., Farida, R., Solihin, S., & Asrori, K. (2022). Workshop peningkatan pemahaman cyber ethics dalam membangun budaya literasi digital yang sehat dan aman. *Minda Baharu*, 6(1), 101-109.
<https://doi.org/10.33373/jmb.v6i1.4081>
- Hakim, J. (2023). Penilaian burnout pemberi asuhan palitif pada implementasi mindfulness: systematic review. *Briliant Jurnal Riset Dan Konseptual*, 8(2), 423.
<https://doi.org/10.28926/briliant.v8i2.1345>
- Henky, H. (2018). Pelayanan etika klinis. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2(2), 59.
<https://doi.org/10.26880/jeki.v2i2.17>
- Hia, Y. (2019). Hubungan perilaku perawat dengan pendokumentasian asuhan keperawatan di kardiovaskular and brain..
<https://doi.org/10.31227/osf.io/sygwf>
- Houska, A. and Loučka, M. (2019). Patients' autonomy at the end of life: a critical review. *Journal of Pain and Symptom Management*, 57(4), 835-845.
<https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2018.12.339>
- Hussain, R., Hassali, M., Rehman, A., Muneswarao, J., Atif, M., & Babar, Z. (2020). A qualitative evaluation of adverse drug reaction reporting system in pakistan: findings from the nurses' perspective. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(9), 3039.
<https://doi.org/10.3390/ijerph17093039>
- Hussien, R. and Hassona, F. (2021). Effect of educational intervention on psychiatric nurses' knowledge regarding ethical and legal issues for psychiatric patients. *Egyptian Journal of Health Care*, 12(1), 121-139.
<https://doi.org/10.21608/ejhc.2021.138121>
- Ibrahim, S., Mas, S., Suling, A., & Rahim, N. (2022). Perbandingan sistem pendidikan sarjana keperawatan indonesia dan inggris. *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5558-5563. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3054>
- Ikhnadito, Y. (2023). Penegak hukum dan moral..
<https://doi.org/10.31219/osf.io/wfam4>
- Inayatillah, F., Octavia, D., & Rahman, A. (2023). Profil pemberian informasi obat swamedikasi di apotek wilayah kecamatan lamongan (studi dengan metode simulasi pasien). *Medical Sains Junal Ilmiah Kefarmasian*, 8(1), 33-40.
<https://doi.org/10.37874/ms.v8i1.454>

- Indriasari, R. (2023). Panduan pembelajaran klinik keperawatan : inisiasi pengembangan perawat pendidik. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), 7175-7184. <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i4.22373>
- Irfan, I. (2018). Kedudukan informed consent dalam hubungan dokter dan pasien. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 154-165. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3155>
- Jasmine, A., Amalia, P., & Muchtar, H. (2022). Tanggung jawab platform marketplace terhadap penjualan ponsel (mobile phone) ilegal berdasarkan hukum nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), 378-389. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.378-389>
- Jena, A., Seabury, S., Lakdawalla, D., & Chandra, A. (2011). Malpractice risk according to physician specialty. *New England Journal of Medicine*, 365(7), 629-636. <https://doi.org/10.1056/nejmsa1012370>
- Karaca, T. and Özkan, S. (2021). Intensive care nurses' ethical challenges caring for people with covid-19: a qualitative study. *Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi*, 12(4). <https://doi.org/10.31067/acusaglik.929307>
- Karanikola, M., Albarran, J., Drigo, E., Giannakopoulou, M., Kalafati, M., Mpouzika, M., ... & Papathanassoglou, E. (2013). Moral distress, autonomy and nurse-physician collaboration among intensive care unit nurses in italy. *Journal of Nursing Management*, 22(4), 472-484. <https://doi.org/10.1111/jonm.12046>
- Kim, M. (2021). We want more than life-sustaining treatment during end-of-life care: focus-group interviews. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(9), 4415. <https://doi.org/10.3390/ijerph18094415>
- Klaic, M., Kapp, S., Hudson, P., Chapman, W., Denehy, L., Story, D., ... & Francis, J. (2022). Implementability of healthcare interventions: an overview of reviews and development of a conceptual framework. *Implementation Science*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s13012-021-01171-7>
- Klotz, K., Riedel, A., Lehmeyer, S., & Goldbach, M. (2022). Legal regulations and the anticipation of moral distress of prospective nurses: a comparison of selected undergraduate nursing education programmes. *Healthcare*, 10(10), 2074. <https://doi.org/10.3390/healthcare10102074>
- Kluger, B., Shattuck, J., Berk, J., Sebring, K., Jones, W., Brunetti, F., ... & Bekelman, D. (2018). Defining palliative care needs in parkinson's disease. *Movement Disorders Clinical Practice*, 6(2), 125-131. <https://doi.org/10.1002/mdc3.12702>
- Kusumaningrum, A. (2017). Analisis transaksi terapeutik sarana perlindungan hukum bagi pasien. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.603>

- Laksono, S. (2024). Kekerasan dan serangan militer dalam fasilitas kesehatan selama perang. *Jurnal Informasi Kesehatan & Administrasi Rumah Sakit (Ikars)*, 3(1), 1-3. <https://doi.org/10.55426/ikars.v3i1.287>
- Larsen, A. (2011). Trappings of technology: casting palliative care nursing as legal relations. *Nursing Inquiry*, 19(4), 334-344. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1800.2011.00568.x>
- Latif, S. (2023). Analisis faktor hubungan pengetahuan dan sikap perawat dengan motivasi pelaksanaan model praktik keperawatan profesional (mpkp). *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (Mppki)*, 6(12), 2433-2439. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i12.3764>
- Lebina, L., Alaba, O., Ringane, A., Hlongwane, K., Pule, P., Oni, T., ... & Kawonga, M. (2019). Process evaluation of implementation fidelity of the integrated chronic disease management model in two districts, south africa. *BMC Health Services Research*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4785-7>
- Lestari, R. (2021). Perlindungan hukum bagi pasien dalam telemedicine. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1(2), 51-65. <https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.150>
- Liani, N. (2023). Legalitas perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan. *ciastech*, 6(1), 309. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5275>
- Lynch, N., Xu, L., Ambinder, D., & Malik, R. (2021). Medical malpractice in stress urinary incontinence management: a 30-year legal database review. *Current Urology*, 15(3), 137-142. <https://doi.org/10.1097/cu9.0000000000000033>
- Mahmud, A. (2020). Sistem kewarisan etnik kaili (tinjauan menurut hukum islam). *Supremasi Jurnal Pemikiran Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Hukum Dan Pengajarannya*, 14(1), 32. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v14i1.13304>
- Majid, A. (2023). Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah akibat gagal bayar perusahaan asuransi. *jhsp-widyakarya*, 1(3), 125-134. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.557>
- Manik, D. (2020). Pentingnya intervensi / perencanaan dan juga implementasi dalam asuhan keperawatan.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2xsf4>
- Margareta, M. (2023). Principium iuris patientium sebagai perlindungan terhadap hak pasien yang terkena stroke. *J-Glegar*, 1(1), 23-36. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.189>
- Mariyati, M. (2023). Pemahaman mahasiswa keperawatan tentang nilai-nilai ideologi negara di stikes muhammadiyah lhokseumawe. *Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(1), 252. <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.5720>
- Meiliyana, N. (2024). Korelasi sikap profesional dokter dengan kepuasan pasien di rumah sakit jasa kartini tasikmalaya tahun 2023. *Bandung Conference Series Medical Science*, 4(1), 640-646. <https://doi.org/10.29313/bcsms.v4i1.11289>

- Miller, R. (2023). Using the geriatric 5ms to teach structural and social determinants of health. *Journal of the American Geriatrics Society*, 71(12), 3967-3972. <https://doi.org/10.1111/jgs.18518>
- Mulyanti, M. (2023). Gambaran karakteristik dan kondisi psikologis caregiver pasien skizofrenia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Rustida*, 10(1), 1-7. <https://doi.org/10.55500/jikr.v10i1.175>
- Nandiwardhana, B. (2020). Etika komunikasi public relations dalam menjaga citra perusahaan. *Jcommsci - Journal of Media and Communication Science*, 3(3), 228-240. <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v3i3.90>
- Nisa, F. (2023). Pengalaman praktik klinis mahasiswa keperawatan di intensive care unit (icu): studi kualitatif. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, 9(5), 517-524. <https://doi.org/10.33023/jikep.v9i5.1425>
- Noltemeyer, A. and Grapin, S. (2020). Working together towards social justice, anti-racism, and equity: a joint commitment from school psychology international and journal of educational and psychological consultation. *School Psychology International*, 42(1), 3-10. <https://doi.org/10.1177/0143034320977618>
- Nurarafah, N. (2022). Doctor's civil responsibility in medical malpractice in indonesia. *Journal Research of Social Science Economics and Management*, 1(10). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v1i10.175>
- Nurhayati, N., Handiyani, H., Yetti, K., & Nurdiana, N. (2020). Analisis perilaku etik kepala ruangan pada rumah sakit di jakarta: studi kasus. *Jurnal Keperawatan Komprehensif*, 6(1), 45-52. <https://doi.org/10.33755/jkk.v6i1.163>
- Nurjono, M., Shrestha, P., Ang, I., Shiraz, F., Yoong, J., Toh, S., ... & Vrijhoef, H. (2019). Implementation fidelity of a strategy to integrate service delivery: learnings from a transitional care program for individuals with complex needs in singapore. *BMC Health Services Research*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-019-3980-x>
- Nurlina, F., Sas'yari, U., Komalasari, K., & Karin, D. (2022). Strategi pemasaran pada masa new normal di praktik keperawatan mandiri kota tasikmalaya. *Jurnal Kepemimpinan Dan Manajemen Keperawatan*, 5(2), 142-148. <https://doi.org/10.32584/jkmm.v5i2.1509>
- Nurmadiyah, N. (2016). Peranan pendidikan agama dalam keluarga terhadap pembentukan kepribadian anak-anak. *Al-Afkar Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.28944/afkar.v1i2.6>
- Oberle, K. and Allen, M. (2006). Ethical considerations for nurses in clinical trials. *Nursing Ethics*, 13(2), 180-186. <https://doi.org/10.1191/0969733006ne836oa>
- Ose, M. (2017). Dilema etik dalam merawat pasien terlantar yang menjelang ajal di igd. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 3(2), 145. <https://doi.org/10.17509/jpki.v3i2.9420>

- Page, K. (2012). The four principles: can they be measured and do they predict ethical decision making?. BMC Medical Ethics, 13(1). <https://doi.org/10.1186/1472-6939-13-10>
- Pakpahan, D., Kusumah, A., & Rosita, R. (2020). Komparasi persepsi kepuasan tamu secara lisan dan tertulis ketika menginap di hotel bintang empat. Jurnal Manajemen Perhotelan, 5(2), 94-101. <https://doi.org/10.9744/jmp.5.2.94-101>
- Pan, S., Li, X., Shen, Y., Chen, J., & Koniak-Griffin, D. (2020). Reframing the meaning of life and professional values: a theoretical framework of facilitating professional care for terminally ill patients. Nursing and Health Sciences, 23(1), 167-175. <https://doi.org/10.1111/nhs.12792>
- Pashar, I., Ismail, S., Edward, I., & Sarinti, S. (2020). Tantangan etik pada perawat dalam penanganan pasien di masa pandemik covid-19: scoping review. Jurnal Perawat Indonesia, 4(3), 469-481. <https://doi.org/10.32584/jpi.v4i3.732>
- Podgorica, N., Flatscher-Thöni, M., Deufert, D., Siebert, U., & Ganner, M. (2020). A systematic review of ethical and legal issues in elder care. Nursing Ethics, 28(6), 895-910. <https://doi.org/10.1177/0969733020921488>
- Prabowo, P. and Widanaputra, A. (2018). Pengaruh love of money, machiavellian, dan idealisme pada persepsi etis mahasiswa akuntansi. E-Jurnal Akuntansi, 513. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i01.p20>
- Prahesti, R. and Putriningrum, E. (2021). Pemberian informasi dan kelengkapan pengisian informed consent pada pasien sectio caesarea di rs pku muhammadiyah gamping yogyakarta. Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan, 4(1), 1-7. <https://doi.org/10.31983/jrmik.v4i1.6778>
- Predel, C. and Steger, F. (2021). Ethical challenges with smartwatch-based screening for atrial fibrillation: putting users at risk for marketing purposes?. Frontiers in Cardiovascular Medicine, 7. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2020.615927>
- Purba, E. and Yulita, T. (2019). Analisis sistem pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis di rumah sakit imelda pekerja indonesia medan tahun 2018. Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (Jipiki), 3(1), 394-403. <https://doi.org/10.52943/jipiki.v3i1.54>
- Putri, S., Sumartini, S., & Rahmi, U. (2021). Perspektif mahasiswa keperawatan terhadap capaian pembelajaran klinik dengan metode peer learning. Jurnal Vokasi Kesehatan, 6(2), 68. <https://doi.org/10.30602/jvk.v6i2.552>
- Putriana, N. and Saragih, Y. (2020). Pendidikan interprofessional dan kolaborasi interprofesional. Majalah Farmasetika, 5(1). <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v5i1.25626>
- Ramadiyanti, R. (2024). Kepastian bentuk tanggung jawab hukum perusahaan asuransi yang telah pailit terhadap nasabahnya. Commerce Law, 4(1). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.4793>

- Risnawati, R. and Amir, H. (2022). Analisis penerapan perilaku penjabaran kode etik keperawatan pada perawat di rumah sakit pendidikan makassar. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.26714/jkj.10.1.2022.57-68>
- Rivai, A. (2021). Proses dan model keputusan etik dalam praktik keperawatan : systematic review. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, 7(3), 40-48. <https://doi.org/10.33023/jikep.v7i3.814>
- Rosady, D., Lazuardi, L., & Sastrowijoto, S. (2022). Telekonsultasi klinis: etika, disiplin, dan hukum kedokteran. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(01), 1-23. <https://doi.org/10.53337/jhki.v2i01.17>
- Samsul, .., Sani, A., Tosepu, R., Yuniar, N., Prasetya, F., & Kusnan, A. (2022). Hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien poli gigi menggunakan metode importance performance analisis di rsud djafar harun kabupaten kolaka utara. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (Mppki)*, 5(7), 870-881. <https://doi.org/10.56338/mppki.v5i7.2480>
- Santoso, W. (2021). Hak dan kewajiban perawat.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/g7rxt>
- Sastroasmoro, S. (2016). Masalah etis dalam proses pengambilan keputusan pada praktik pediatri. *Sari Pediatri*, 7(3), 125. <https://doi.org/10.14238/sp7.3.2005.125-31>
- Setiani, B. (2018). Pertanggungjawaban hukum perawat dalam hal pemenuhan kewajiban dan kode etik dalam praktik keperawatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 8(04), 497-507. <https://doi.org/10.33221/jiiki.v8i04.154>
- Siagian, E. and Perangin-angin, M. (2020). Pengetahuan dan sikap perawat tentang perawatan paliatif di rumah sakit. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 10(03), 52-58. <https://doi.org/10.33221/jiiki.v10i02.587>
- Sidjabat, F. and Artanti, C. (2022). Penerapan failure mode and effects analysis pada analisis pengisian formulir persetujuan pemasangan kontrasepsi di puskesmas bangsongan, kabupaten kediri. *Indonesian of Health Information Management Journal (Inohim)*, 10(2), 104-111. <https://doi.org/10.47007/inohim.v10i2.408>
- Sihombing, F. and Barus, L. (2022). Perbandingan efektivitas pembelajaran stase keperawatan komunitas secara konvensional sebelum pandemi covid-19 dan secara daring saat pandemi covid-19. *Jurnal Keperawatan Tropis Papua*, 5(2). <https://doi.org/10.47539/jktp.v5i2.311>
- Sinkfield-Morey, T. (2018). How using the term “non-compliant” keeps providers from partnering with patients. *Creative Nursing*, 24(3), 178-185. <https://doi.org/10.1891/1946-6560.24.3.178>

- Situmorang, R. (2022). Pengalaman clinical instructor dalam proses pembelajaran praktik mahasiswa keperawatan di rumah sakit wilayah jawa barat. *Moluccas Health Journal*, 4(1), 73-82. <https://doi.org/10.54639/mhj.v4i1.899>
- Sugiarto, A. (2020). Dampak positif pembelajaran online dalam sistem pendidikan keperawatan pasca pandemi covid 19. *Jurnal Perawat Indonesia*, 4(3), 432-436. <https://doi.org/10.32584/jpi.v4i3.555>
- Surya, D. and Afrizal, A. (2021). Efektifitas metode pembelajaran simulasi online terhadap kompetensi mahasiswa dalam perawatan berfokus keluarga. *Jik Jurnal Ilmu Kesehatan*, 5(1), 97. <https://doi.org/10.33757/jik.v5i1.382>
- Suvarnakich, P. (2022). Compliance with the ethical competence framework by head nurses. *Nursing Ethics*, 29(5), 1304-1317. <https://doi.org/10.1177/09697330221105634>
- Syazali, E. (2022). Perlindungan hukum pemegang polis asuransi terhadap perusahaan yang pailit. *Jurnal Yuridis Unaja*, 5(1), 1-21. <https://doi.org/10.35141/jyu.v5i1.299>
- Tedjomuljo, S. and Afifah, E. (2016). Tingkat pengetahuan mahasiswa keperawatan tentang kode etik profesi dan caring. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 19(2), 129-137. <https://doi.org/10.7454/jki.v19i2.457>
- Temel, J., Greer, J., Muzikansky, A., Gallagher, E., Admane, S., Jackson, V., ... & Lynch, T. (2010). Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. *New England Journal of Medicine*, 363(8), 733-742. <https://doi.org/10.1056/nejmoa1000678>
- Tia, M., Aziato, L., & Dzansi, G. (2022). Exploring ghanaian nurses knowledge and application of bio-ethical principles in postoperative pain management. *Plos One*, 17(10), e0276422. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276422>
- Virdun, C., Lockett, T., Davidson, P., & Phillips, J. (2015). Dying in the hospital setting: a systematic review of quantitative studies identifying the elements of end-of-life care that patients and their families rank as being most important. *Palliative Medicine*, 29(9), 774-796. <https://doi.org/10.1177/0269216315583032>
- Wahyuliati, T. and Novita, R. (2023). Efektivitas pelatihan dan supervisi terhadap peningkatan kualitas pendokumentasian asuhan keperawatan : literature review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (Mppki)*, 6(7), 1250-1258. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i7.3459>
- Wihardja, H. (2020). Analisis efektifitas teknologi bar code assisted medication administration (bcma) bagi keselamatan pasien di pelayanan kesehatan. *Carolus Journal of Nursing*, 1(1), 77-88. <https://doi.org/10.37480/cjon.v1i1.31>
- Wiyono, H. (2023). Perancangan aplikasi keamanan data rekam medis menggunakan algoritma aes (advanced encryption standard). *PCTIF*, 1(2), 133-141. <https://doi.org/10.70292/pctif.v1i2.23>

- Wong, E., Kiang, N., Chung, R., Lau, J., Chau, P., Wong, S., ... & Yeoh, E. (2020). Quality of palliative and end-of-life care in hong kong: perspectives of healthcare providers. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(14), 5130. <https://doi.org/10.3390/ijerph17145130>
- Yusrani, K., Arbitera, C., Novianti, P., Sabrina, R., Syabil, S., & Rahma, U. (2023). Studi literatur : faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih asuransi kesehatan. *jumeha*, 3(1), 37-50. <https://doi.org/10.59744/jumeha.v3i1.39>
- Zaman, B. (2024). Sosialisasi dan pelatihan pendokumentasian asuhan keperawatan menggunakan buku scki, slki dan siki. *Beujroh*, 2(1), 175-183. <https://doi.org/10.61579/beujroh.v2i1.72>

BAB 3

INTERPROFESSIONAL EDUCATION DAN INTERPROFESSIONAL COLLABORATION DALAM KEPERAWATAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Mampu menerapkan prinsip-prinsip komunikasi, kerja sama tim, dan kolaborasi interprofesional dalam praktik keperawatan yang profesional, etis, dan berorientasi pada pasien.
- Memiliki sikap terbuka, saling menghargai, dan bertanggung jawab dalam menjalankan praktik kolaboratif antar profesi kesehatan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar interprofessional education dan interprofessional collaboration.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi manfaat, tantangan, serta strategi implementasi IPE dan IPC dalam praktik keperawatan.
- Mahasiswa mampu menganalisis peran perawat dalam tim interprofesional dan menyusun rencana kerja kolaboratif.

Sub-CPMK

- Menjelaskan definisi, tujuan, dan prinsip interprofessional education dalam konteks keperawatan.
- Menguraikan pengertian, komponen, dan manfaat interprofessional collaboration dalam praktik klinik.
- Mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam implementasi IPE dan IPC.
- Mendeskripsikan peran, tanggung jawab, dan kompetensi kolaboratif yang harus dimiliki perawat.
- Menyusun rencana kolaboratif antar profesi dalam pemberian asuhan keperawatan yang komprehensif dan berkesinambungan.

Pendahuluan

Dunia pelayanan kesehatan modern semakin menuntut adanya kerja sama yang efektif antar profesi. Dalam konteks pelayanan yang kompleks dan multidisipliner, perawat tidak dapat bekerja secara terpisah dari tenaga kesehatan lainnya. Oleh karena itu, muncul pendekatan yang dikenal dengan Interprofessional Education (IPE) dan Interprofessional Collaboration (IPC) sebagai kerangka penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. IPE adalah suatu proses di mana dua atau lebih profesi kesehatan belajar bersama, satu sama lain, dan tentang satu sama lain untuk memungkinkan kolaborasi yang efektif dan meningkatkan hasil pelayanan kepada pasien. Sementara itu, IPC merujuk pada bentuk kerja sama tim lintas profesi dalam memberikan asuhan kepada pasien dengan cara yang terintegrasi, menghargai kompetensi masing-masing profesi, dan mengedepankan komunikasi serta tanggung jawab bersama.

Dalam pendidikan keperawatan, pemahaman dan penerapan konsep IPE dan IPC menjadi penting untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan kolaboratif yang esensial. Keberhasilan praktik keperawatan yang berpusat pada pasien sangat ditentukan oleh seberapa baik perawat dapat berinteraksi, bekerja sama, dan menyatukan upaya bersama profesi lain dalam tim layanan kesehatan. Oleh karena itu, buku ajar ini akan membahas secara menyeluruh mengenai konsep dasar IPE dan IPC, termasuk prinsip, manfaat, tantangan, serta penerapannya dalam setting klinik dan komunitas.

A. Pengertian dan Prinsip Interprofessional Education (IPE)

Interprofessional Education (IPE) atau Pendidikan Antarprofesi merupakan suatu pendekatan pendidikan yang melibatkan dua atau lebih profesi kesehatan yang belajar secara bersama-sama, satu sama lain, dan tentang profesi lainnya, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kolaborasi dan kualitas pelayanan kesehatan. IPE bukan sekadar menghadirkan mahasiswa dari berbagai latar belakang profesi dalam satu ruang belajar, melainkan menciptakan pengalaman pembelajaran yang terintegrasi dan terstruktur di mana interaksi antarprofesi menjadi inti dari proses pembelajaran itu sendiri. Dalam konteks ini, mahasiswa tidak hanya belajar mengenai kompetensi profesional mereka masing-masing, tetapi juga mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai peran, tanggung jawab, serta keahlian profesi lain yang akan mereka hadapi dalam praktik klinis.

Latar belakang munculnya IPE berkaitan erat dengan kebutuhan dunia pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan menuntut pendekatan kolaboratif yang lebih efektif. Dalam sejarah perkembangan sistem pelayanan kesehatan, terdapat kecenderungan kuat bahwa tenaga kesehatan dididik secara terpisah dan eksklusif sesuai dengan profesi masing-masing, seperti kedokteran, keperawatan, kebidanan, farmasi, dan fisioterapi. Hal ini menyebabkan terbentuknya silo profesional atau sekat-sekat antar profesi yang menghambat komunikasi, koordinasi, dan kerjasama tim di lapangan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa miskomunikasi antar tenaga kesehatan merupakan salah satu penyebab utama dari kesalahan medis dan menurunnya kualitas asuhan kepada pasien. Oleh karena itu, IPE lahir sebagai solusi untuk menjembatani jurang antarprofesi sejak tahap pendidikan, sebelum para peserta didik benar-benar terjun ke dunia kerja.

Prinsip utama dari pelaksanaan IPE meliputi mutual respect, shared goals, role clarification, collaborative practice, dan effective communication. Prinsip pertama, yaitu saling menghargai (mutual respect), menekankan pentingnya membangun sikap saling menghormati antarmahasiswa dari latar belakang profesi yang berbeda. Setiap profesi memiliki peran unik dan kontributif dalam sistem pelayanan kesehatan, sehingga tidak boleh ada anggapan bahwa satu profesi lebih dominan atau lebih penting dari yang lain. Prinsip kedua adalah tujuan bersama (shared goals), yang berarti seluruh peserta didik diarahkan untuk bekerja sama mencapai

hasil kesehatan terbaik bagi pasien atau komunitas, bukan hanya untuk memenuhi tujuan profesi masing-masing.

Prinsip ketiga, klarifikasi peran (role clarification), sangat penting dalam mencegah tumpang tindih atau bahkan konflik peran. Melalui IPE, mahasiswa dilatih untuk memahami batas-batas dan kapasitas profesional masing-masing, sekaligus mengenali kapan harus merujuk atau berkolaborasi dengan profesi lain. Prinsip keempat adalah praktik kolaboratif (collaborative practice), yang berarti pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga diarahkan untuk melatih kemampuan kerja tim, pengambilan keputusan bersama, dan integrasi intervensi secara lintas-disiplin. Terakhir, komunikasi efektif (effective communication) menjadi elemen yang menjiwai seluruh proses IPE. Tanpa komunikasi yang terbuka, jelas, dan saling menghargai, kolaborasi antarprofesi akan gagal membuahkan hasil yang optimal.

IPE memiliki perbedaan mendasar dengan pendidikan profesi tunggal (single profession education). Dalam pendidikan profesi tunggal, mahasiswa hanya berinteraksi dengan rekan sejawat dari profesi yang sama, mempelajari kurikulum yang eksklusif, serta membentuk pola pikir dan budaya profesional yang cenderung homogen. Sementara itu, IPE membuka ruang dialog antarprofesi, memperluas wawasan dan menumbuhkan sikap kolaboratif sejak dini. Dengan begitu, ketika mereka memasuki dunia kerja yang nyata—di mana kerja tim lintas-profesi merupakan norma dan tuntutan—mereka telah memiliki kesiapan mental dan keterampilan yang memadai untuk berkolaborasi secara profesional dan efektif.

Konteks global saat ini, di mana pelayanan kesehatan mengarah pada model yang berbasis tim (team-based care), menjadikan IPE sebagai komponen yang sangat relevan dalam pendidikan tenaga kesehatan. Di Indonesia, pengembangan IPE telah mulai diadopsi oleh berbagai institusi pendidikan kesehatan sebagai respons terhadap kebijakan nasional dan kebutuhan sistem kesehatan yang lebih terintegrasi. Dengan menerapkan IPE, diharapkan para calon tenaga kesehatan memiliki kapasitas kolaboratif yang tidak hanya mampu meningkatkan hasil pelayanan pasien, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan nasional secara keseluruhan melalui praktik yang berbasis sinergi dan saling penguatan antarprofesi.

B. Konsep dan Komponen Interprofessional Collaboration (IPC)

Interprofessional Collaboration (IPC), atau kolaborasi antarprofesi, merupakan pendekatan dalam pelayanan kesehatan yang menekankan kerja sama lintas disiplin

antara berbagai profesi kesehatan untuk mencapai hasil kesehatan pasien yang optimal. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat administratif atau koordinatif, tetapi merupakan integrasi aktif dari pengetahuan, keterampilan, dan perspektif unik masing-masing profesi dalam proses asuhan pasien. Konsep IPC menempatkan pasien sebagai pusat dari semua keputusan klinis, dan menuntut semua anggota tim kesehatan untuk bekerja secara sinergis dalam lingkungan yang penuh penghargaan, komunikasi terbuka, dan tanggung jawab bersama.

Salah satu karakteristik utama dari IPC adalah komunikasi efektif. Dalam tim interprofesional, keberhasilan asuhan pasien sangat bergantung pada kemampuan anggota tim untuk saling bertukar informasi secara jelas, akurat, dan tepat waktu. Komunikasi efektif mencakup aspek verbal dan nonverbal, serta penggunaan teknologi komunikasi yang tepat seperti rekam medis elektronik yang dapat diakses oleh semua anggota tim. Komunikasi juga harus didasarkan pada keterbukaan dan kepercayaan, di mana semua anggota tim merasa aman untuk menyampaikan ide, kekhawatiran, maupun kritik secara konstruktif demi kepentingan pasien.

Karakteristik penting berikutnya adalah pengambilan keputusan bersama (*shared decision-making*), yang mencerminkan esensi dari kerja tim sejati dalam praktik kesehatan. Dalam IPC, keputusan klinis tidak dibuat secara unilateral oleh satu profesi saja (misalnya dokter), tetapi melibatkan kontribusi aktif dari perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, terapis okupasi, dan profesi kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pasien. Proses ini memungkinkan setiap profesi untuk memberikan masukan berdasarkan perspektif keilmuan dan pengalamannya, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pasien secara holistik.

Selain itu, saling menghormati antarprofesi menjadi fondasi etis dan moral dalam IPC. Kolaborasi yang sejati tidak akan terbentuk jika masih terdapat hierarki yang kaku atau pandangan superior-inferior di antara anggota tim. Setiap profesi diakui memiliki nilai unik dan setara dalam proses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, membangun budaya saling menghargai dan empati sangat penting, terutama untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih demokratis.

Elemen-elemen penting dalam tim interprofesional juga mencakup peran dan tanggung jawab yang jelas, kepemimpinan kolaboratif, dukungan organisasi, dan proses refleksi serta evaluasi berkelanjutan. Kejelasan peran penting agar setiap anggota tim memahami batas kewenangannya dan kapan perlu melakukan rujukan atau kolaborasi dengan profesi lain. Kepemimpinan kolaboratif dalam IPC tidak

selalu berarti satu pemimpin tunggal, melainkan kepemimpinan yang bergilir atau adaptif tergantung pada konteks kasus dan kebutuhan pasien. Dukungan organisasi, seperti kebijakan rumah sakit dan pelatihan antarprofesi, juga sangat menentukan efektivitas kolaborasi. Sementara itu, proses evaluasi yang bersifat reflektif membantu tim untuk belajar dari pengalaman, memperbaiki proses kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan secara terus-menerus.

Contoh implementasi IPC dapat ditemukan di berbagai setting layanan kesehatan. Dalam unit perawatan intensif (ICU), misalnya, dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, dan fisioterapis harus berkolaborasi untuk merancang dan menyesuaikan rencana perawatan yang kompleks setiap hari. Diskusi harian atau rounding interprofesional menjadi ajang penting untuk komunikasi lintas profesi yang terstruktur. Di puskesmas atau layanan primer, IPC dapat muncul dalam bentuk kolaborasi antara bidan, perawat komunitas, tenaga promosi kesehatan, dan dokter umum dalam penanganan kasus ibu hamil dengan komorbiditas, seperti hipertensi atau diabetes gestasional. Kolaborasi ini memungkinkan penyuluhan, pemantauan, rujukan, dan perawatan dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan peran masing-masing.

Demikian pula, dalam rehabilitasi pasien stroke, IPC sangat penting untuk memfasilitasi pemulihan yang optimal. Tim yang terdiri dari dokter spesialis saraf, perawat, fisioterapis, terapis wicara, dan pekerja sosial perlu bekerja bersama untuk menyusun rencana rehabilitasi yang mencakup aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial pasien. Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga, serta menurunkan beban layanan kesehatan akibat rawat inap yang berkepanjangan.

Dengan demikian, IPC bukan hanya sebuah metode kerja, tetapi sebuah budaya profesional yang harus dibangun secara sadar dan berkelanjutan, baik dalam pendidikan maupun dalam praktik klinis. Tujuannya adalah memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan dengan cara yang paling efektif, manusiawi, dan responsif terhadap kompleksitas kebutuhan pasien masa kini.

C. Peran Perawat dalam Tim Interprofesional

Perawat menempati posisi yang sangat strategis dalam tim interprofesional di layanan kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi langsung dengan pasien selama 24 jam, perawat tidak hanya menjalankan tugas teknis keperawatan, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara pasien, keluarga, dan anggota tim kesehatan lainnya. Peran ini menjadikan perawat sebagai

kunci dalam memastikan kelangsungan komunikasi, koordinasi pelayanan, dan keterpaduan dalam rencana asuhan pasien. Dalam sistem kolaboratif, perawat bukan lagi sekadar “pelaksana” dari instruksi medis, tetapi merupakan mitra sejajar yang secara aktif memberikan kontribusi klinis, emosional, dan edukatif yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan bersama.

Dalam konteks tim interprofesional, perawat dituntut memiliki kompetensi kolaboratif yang mencakup pemahaman mendalam terhadap dinamika kerja tim, keterampilan komunikasi efektif, dan kemampuan berpikir kritis lintas disiplin. Kompetensi ini meliputi kemampuan mengenali dan memahami peran serta kompetensi profesi lain, keterampilan negosiasi, resolusi konflik, serta tanggung jawab dalam menjaga kesinambungan asuhan pasien. Selain itu, perawat juga perlu memiliki *empathy-based leadership*—kemampuan untuk memimpin dan mempengaruhi secara positif dalam kerja tim tanpa mengedepankan otoritas formal. Ini penting karena dalam banyak kasus, perawat menjadi pengatur ritme dalam pelaksanaan intervensi asuhan harian yang memerlukan konsistensi, ketepatan, dan sensitivitas terhadap perubahan kondisi pasien.

Tanggung jawab perawat dalam tim kolaboratif mencakup berbagai aspek. Pertama, pengkajian dan pelaporan kondisi pasien secara berkelanjutan. Karena perawat adalah pihak yang paling dekat secara waktu dan fisik dengan pasien, mereka memiliki kapasitas tinggi untuk mendeteksi perubahan klinis secara dini dan menyampaikan informasi tersebut kepada anggota tim lain, seperti dokter atau ahli gizi, agar dapat segera dilakukan intervensi yang diperlukan. Kedua, perawat juga memiliki tanggung jawab dalam koordinasi rencana perawatan, misalnya dengan menjadwalkan tindakan, memantau jadwal obat dari apoteker, atau mengatur sesi rehabilitasi dengan fisioterapis. Ketiga, dukungan edukatif dan emosional kepada pasien dan keluarga sering kali menjadi domain perawat, karena kedekatan yang telah terjalin memungkinkan mereka menyampaikan informasi dengan cara yang empatik dan mudah dipahami.

Untuk menggambarkan praktik nyata peran perawat dalam kolaborasi interprofesional, berikut ini salah satu ilustrasi lapangan. Dalam kasus manajemen pasien stroke akut di rumah sakit, perawat memulai perannya sejak pasien masuk unit gawat darurat (UGD). Setelah melakukan pengkajian awal menggunakan skala stroke NIHSS dan skala nyeri, perawat menyampaikan temuan awal kepada dokter jaga dan memfasilitasi pemeriksaan CT-scan. Setelah diagnosis ditegakkan, tim rehabilitasi—yang terdiri dari fisioterapis, terapis wicara, ahli gizi, dan pekerja sosial—dikumpulkan untuk menyusun rencana perawatan komprehensif. Di sini,

perawat memainkan peran sentral dalam menjelaskan kebutuhan dasar harian pasien, seperti pola istirahat, perawatan luka dekubitus, pemberian makan lewat NGT, dan kontrol tekanan darah. Perawat juga mengkomunikasikan kemajuan pasien kepada keluarga dan anggota tim lain selama case conference, serta mencatat perkembangan harian dalam rekam medis yang bisa diakses oleh seluruh tim.

Contoh lain terlihat dalam pelayanan kesehatan komunitas, seperti pada program posyandu lansia di puskesmas. Dalam program ini, perawat berkolaborasi dengan dokter, ahli gizi, tenaga promosi kesehatan, dan kader masyarakat. Perawat bertanggung jawab dalam melakukan skrining tekanan darah, evaluasi status kognitif ringan menggunakan instrumen seperti MMSE, serta memberikan konseling terkait kepatuhan minum obat. Bersama ahli gizi, perawat memberikan edukasi terkait pola makan sehat bagi lansia dengan hipertensi. Hasil skrining yang menunjukkan risiko tinggi kemudian dibahas dalam rapat tim untuk penentuan tindak lanjut, seperti rujukan ke rumah sakit atau program kunjungan rumah. Ini menunjukkan bahwa perawat adalah elemen integral dalam menjembatani kebijakan klinis dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Keseluruhan peran perawat dalam tim interprofesional sangat vital, bukan hanya dalam aspek klinis, tetapi juga dalam menjaga kesinambungan dan humanisasi pelayanan. Dengan landasan kompetensi kolaboratif yang kuat, perawat dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih inklusif, efektif, dan berpusat pada pasien. Maka dari itu, penguatan kapasitas kolaboratif perawat perlu dilakukan sejak pendidikan dasar melalui penerapan Interprofessional Education (IPE), dan diperkuat secara berkelanjutan dalam praktik profesional mereka.

D. Manfaat dan Tantangan IPE dan IPC dalam Keperawatan

Penerapan Interprofessional Education (IPE) dan Interprofessional Collaboration (IPC) dalam keperawatan membawa dampak yang signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, bagi berbagai pihak dalam sistem kesehatan—termasuk pasien, tenaga perawat, dan institusi layanan itu sendiri. Dalam jangka pendek, IPE memberikan fondasi pembelajaran kolaboratif bagi mahasiswa keperawatan yang masih berada di fase pendidikan. Melalui pengalaman belajar bersama dengan mahasiswa dari profesi kesehatan lainnya (misalnya kedokteran, farmasi, kebidanan, dan gizi), perawat masa depan belajar mengenali batasan dan potensi profesi lain, sekaligus mengembangkan kemampuan komunikasi lintas-profesi dan keterampilan berpikir kritis secara tim. Hal ini tidak

hanya memperkaya sudut pandang klinis, tetapi juga menumbuhkan sikap profesional yang menghargai keberagaman kompetensi dalam sistem pelayanan kesehatan.

Dalam praktik klinis, manfaat IPC bagi perawat menjadi lebih nyata. Kolaborasi yang terstruktur dan efektif akan meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi beban kerja individu, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif. Bagi pasien, IPC terbukti meningkatkan mutu dan keselamatan asuhan. Penelitian menunjukkan bahwa tim interprofesional yang bekerja secara sinergis mampu mengurangi kejadian kesalahan medis, mempercepat proses pemulihan, serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, asuhan yang bersifat holistik dapat terwujud karena IPC memastikan bahwa seluruh aspek kebutuhan pasien—fisik, psikologis, sosial, dan spiritual—diperhatikan melalui keterlibatan berbagai profesi dengan keahlian masing-masing.

Secara jangka panjang, penerapan IPE dan IPC berkontribusi pada peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan secara keseluruhan. Institusi yang menerapkan pendekatan kolaboratif secara konsisten cenderung memiliki budaya kerja yang sehat, tingkat retensi tenaga kesehatan yang lebih tinggi, dan lebih siap dalam menghadapi tantangan pelayanan berbasis populasi seperti penyakit kronis, pandemi, dan pelayanan di daerah terpencil. Bagi profesi keperawatan, pendekatan ini mendorong transformasi peran perawat dari yang bersifat subordinatif menjadi koordinator asuhan, konsultan, dan mitra sejajar dalam tim multidisiplin. Dengan demikian, pengakuan terhadap kapasitas intelektual dan klinis perawat meningkat, yang berdampak pada peningkatan citra profesi di mata masyarakat dan profesi kesehatan lain.

Namun, manfaat besar ini tidak datang tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah perbedaan persepsi dan ekspektasi antarprofesi. Misalnya, masih banyak yang memandang perawat hanya sebagai pelaksana instruksi dokter, bukan sebagai mitra klinis yang setara. Hal ini dapat menimbulkan resistensi terhadap keterlibatan aktif perawat dalam pengambilan keputusan atau diskusi klinis. Kendala lain adalah budaya profesional yang eksklusif, di mana masing-masing profesi cenderung membentuk identitas yang kaku dan tertutup terhadap intervensi luar. Di beberapa institusi, hierarki yang terlalu dominan menyebabkan perawat merasa tidak nyaman menyuarakan pendapat atau ide dalam forum interprofesional. Masalah ini diperparah oleh hambatan komunikasi, baik karena perbedaan bahasa teknis antarprofesi, kurangnya pelatihan komunikasi lintas-disiplin, maupun minimnya penggunaan sistem dokumentasi yang terintegrasi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, strategi yang dapat diterapkan antara lain adalah pelatihan bersama sejak masa pendidikan melalui kurikulum IPE yang terstruktur, termasuk simulasi kasus lintas-profesi, tugas kelompok interdisipliner, serta pengajaran berbasis refleksi kolaboratif. Di lingkungan praktik klinis, pengembangan sistem komunikasi terbuka, seperti briefing harian tim interprofesional dan penggunaan teknologi informasi bersama (misalnya Electronic Health Records), sangat membantu memperlancar koordinasi dan transparansi informasi. Selain itu, diperlukan komitmen manajemen organisasi dalam menciptakan budaya kolaboratif melalui kebijakan rekrutmen berbasis tim, pelatihan pengembangan profesional berkelanjutan, serta insentif bagi unit kerja yang berhasil menunjukkan kinerja tim yang solid.

Pendekatan lain yang juga krusial adalah penguatan peran kepemimpinan keperawatan. Perawat dengan posisi struktural atau klinis yang kuat dapat menjadi jembatan antarprofesi, pemimpin perubahan, dan penggerak budaya kerja kolaboratif. Perawat senior, instruktur klinik, dan manajer keperawatan memiliki tanggung jawab untuk menjadi role model dalam penerapan IPC yang etis dan efektif.

Secara keseluruhan, meskipun implementasi IPE dan IPC dalam keperawatan menghadapi tantangan struktural dan budaya yang tidak ringan, upaya konsisten dan sistematis akan memberikan dampak positif yang besar terhadap profesionalisme perawat, kepuasan pasien, dan keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan. Kolaborasi bukanlah pilihan, melainkan keharusan dalam menghadapi kompleksitas masalah kesehatan masyarakat masa kini dan masa depan.

E. Strategi Implementasi IPE dan IPC dalam Pendidikan dan Praktik

Implementasi Interprofessional Education (IPE) dan Interprofessional Collaboration (IPC) dalam pendidikan keperawatan dan praktik klinik memerlukan pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya menuntut pembaruan pada kurikulum pendidikan, tetapi juga transformasi budaya organisasi dan penguatan kebijakan kelembagaan. Tujuannya adalah membentuk tenaga perawat yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga mampu berkolaborasi secara profesional dengan berbagai disiplin ilmu dalam sistem pelayanan kesehatan yang kompleks dan dinamis.

Di tingkat pendidikan, integrasi IPE dalam kurikulum keperawatan sebaiknya dimulai sejak tahap awal pembelajaran dan dilanjutkan secara progresif hingga tahap praktik klinik. Salah satu strategi utama adalah melalui desain pembelajaran

kolaboratif, yaitu menyusun kegiatan belajar yang melibatkan mahasiswa dari berbagai program studi kesehatan dalam satu kelompok belajar interdisipliner. Dalam kegiatan ini, mahasiswa keperawatan, kedokteran, kebidanan, farmasi, gizi, atau kesehatan masyarakat duduk bersama untuk membahas suatu kasus klinis secara holistik, masing-masing berkontribusi sesuai dengan perspektif dan kompetensinya. Pembelajaran ini bukan hanya untuk mengasah keterampilan klinis, tetapi juga untuk melatih empati, kepemimpinan tim, dan pemahaman lintas peran.

Simulasi interprofesional menjadi metode pembelajaran yang semakin banyak diadopsi karena mampu menciptakan lingkungan yang aman dan realistis bagi peserta didik untuk mengalami dinamika kerja tim kolaboratif. Dalam simulasi ini, mahasiswa dari berbagai profesi bekerja bersama dalam menghadapi skenario kasus yang kompleks, seperti penanganan kegawatdaruratan, perawatan pasien dengan komorbiditas, atau komunikasi saat peralihan perawatan (handover). Melalui simulasi, mahasiswa belajar mengidentifikasi peran dan batas profesi, menyampaikan pendapat secara asertif, dan mengambil keputusan bersama berdasarkan diskusi tim. Evaluasi reflektif setelah simulasi (debriefing) juga membantu peserta didik mengembangkan kesadaran akan pentingnya komunikasi, kepercayaan, dan koordinasi.

Selain metode pembelajaran, penguatan kebijakan institusional menjadi fondasi penting dalam mengimplementasikan IPE dan IPC secara berkelanjutan. Institusi pendidikan tinggi perlu menyusun kebijakan kurikulum berbasis IPE yang terintegrasi lintas program studi, termasuk alokasi waktu dan sks khusus untuk pembelajaran kolaboratif. Dibutuhkan pula pelatihan bagi dosen dan pembimbing klinik untuk menjadi fasilitator interprofesional yang kompeten dan mampu menyeimbangkan dinamika diskusi antarprofesi tanpa mendominasi atau berpihak. Kolaborasi antar fakultas atau prodi juga harus difasilitasi oleh struktur manajemen akademik yang fleksibel dan terbuka terhadap sinergi lintas institusi.

Dalam praktik klinis, strategi implementasi IPC dapat dimulai dengan membentuk tim pelayanan interprofesional yang memiliki pertemuan rutin, seperti clinical round bersama atau konferensi kasus. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya perlu mengembangkan struktur organisasi yang mendukung kolaborasi, misalnya dengan menyediakan ruang diskusi tim, sistem dokumentasi terintegrasi, serta protokol kerja bersama. Sistem electronic health record (EHR) yang dapat diakses oleh seluruh profesi akan sangat membantu dalam mempercepat komunikasi dan menjaga kesinambungan asuhan. Di sisi lain, penguatan peran perawat sebagai koordinator asuhan juga perlu ditekankan dalam kebijakan

pelayanan. Perawat yang memiliki posisi strategis dalam alur perawatan harus diberi wewenang dan dukungan untuk memfasilitasi kolaborasi antardisiplin.

Evaluasi dan monitoring pelaksanaan IPE dan IPC juga perlu dilakukan secara berkala melalui indikator yang jelas, seperti peningkatan kepuasan pasien, penurunan insiden medis, serta peningkatan kepuasan kerja tim kesehatan. Selain itu, masukan dari mahasiswa dan tenaga kesehatan tentang kendala serta efektivitas program IPE/IPC harus dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan.

Terakhir, keberhasilan strategi implementasi IPE dan IPC sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Oleh karena itu, institusi pendidikan dan layanan kesehatan harus menciptakan budaya kolaboratif yang menjunjung nilai-nilai saling menghormati, keterbukaan, dan pembelajaran bersama. Hal ini hanya dapat dicapai jika semua pihak—dosen, mahasiswa, manajemen rumah sakit, dan tenaga profesional—berkomitmen untuk menjadikan kolaborasi sebagai bagian dari identitas profesional dan bukan sekadar tuntutan administratif.

Dengan demikian, IPE dan IPC bukan hanya wacana atau kurikulum tambahan, melainkan pendekatan mendasar yang akan membentuk sistem kesehatan yang lebih manusiawi, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Perawat, sebagai profesi yang berinteraksi intens dengan berbagai aspek pelayanan, memiliki peran kunci dalam menghidupkan nilai-nilai kolaborasi tersebut di setiap lini pelayanan kesehatan.

F. Latihan Soal

Soal 1

Seorang mahasiswi kebidanan mengikuti program pembelajaran interprofesional yang melibatkan mahasiswa kedokteran, keperawatan, dan farmasi dalam pembahasan kasus ibu hamil dengan anemia berat. Dalam diskusi, ia mampu memahami peran profesi lain dan berkontribusi menyampaikan edukasi terkait zat besi. Sikap ini mencerminkan prinsip IPE:

- A. Single profession focus
- B. Collaborative practice
- C. Academic independence
- D. Role substitution
- E. Profession-specific learning

Kunci Jawaban: B. Collaborative practice

Rasional: IPE mendorong pembelajaran kolaboratif antarmahasiswa dari berbagai profesi. Mahasiswi kebidanan tersebut menunjukkan praktik kolaboratif dengan

memahami dan menghargai peran profesi lain sambil tetap menyumbangkan keahliannya.

Soal 2

Di ruang bersalin, seorang ibu dengan preeklampsia mengalami kejang dan perlu segera ditangani. Tim interprofesional terdiri dari dokter, bidan, perawat, dan apoteker. Seluruh tim bekerja berdasarkan keputusan bersama untuk pemberian magnesium sulfat dan tindakan lanjutan. Hal ini mencerminkan elemen IPC:

- A. Shared decision-making
- B. Professional autonomy
- C. Passive collaboration
- D. Silo-based care
- E. Discipline hierarchy

Kunci Jawaban: A. Shared decision-making

Rasional: IPC menekankan keputusan klinis yang diambil bersama oleh semua profesi yang terlibat, tidak didominasi oleh satu profesi. Hal ini meningkatkan keselamatan pasien dan efektivitas tindakan.

Soal 3

Di sebuah puskesmas terpadu, bidan dan perawat komunitas mendeteksi peningkatan kasus anemia pada remaja putri. Mereka bekerja sama dengan ahli gizi, dokter umum, dan kader posyandu untuk membuat program edukasi gizi dan pembagian tablet tambah darah. Kolaborasi ini mencerminkan manfaat IPC dalam aspek:

- A. Peningkatan kompetensi individu
- B. Isolasi peran profesi
- C. Pelayanan terfragmentasi
- D. Pendekatan terintegrasi dan holistik
- E. Fokus pada tugas administratif

Kunci Jawaban: D. Pendekatan terintegrasi dan holistik

Rasional: IPC bertujuan memberikan pelayanan yang menyeluruh dengan mengintegrasikan keahlian berbagai profesi untuk hasil kesehatan yang lebih baik.

Soal 4

Seorang mahasiswi kebidanan merasa tidak nyaman mengungkapkan pendapatnya saat simulasi pembelajaran interprofesional karena takut dianggap tidak setara oleh

mahasiswa kedokteran. Hal ini mencerminkan salah satu tantangan dalam penerapan IPE, yaitu:

- A. Ketidaksesuaian materi pembelajaran
- B. Hambatan komunikasi horizontal
- C. Perbedaan persepsi dan budaya profesional
- D. Kurangnya beban kerja kolaboratif
- E. Evaluasi hasil belajar yang tidak relevan

Kunci Jawaban: C. Perbedaan persepsi dan budaya profesional

Rasional: Salah satu tantangan IPE adalah adanya anggapan hierarki atau superioritas profesi tertentu, yang menyebabkan kecanggungan atau ketidaknyamanan dalam kolaborasi antarmahasiswa.

Soal 5

Seorang kepala ruangan bersalin berinisiatif membuat clinical briefing pagi yang melibatkan dokter, bidan, apoteker, dan ahli gizi untuk membahas rencana asuhan setiap pasien. Langkah ini merupakan contoh strategi implementasi:

- A. Simulasi keperawatan berbasis EBP
- B. Penguatan pendidikan profesi tunggal
- C. Integrasi nilai budaya lokal
- D. Praktik berbasis kurikulum teori sosial
- E. Interprofessional collaboration dalam praktik klinik

Kunci Jawaban: E. Interprofessional collaboration dalam praktik klinik

Rasional: Briefing klinis antardisiplin merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan IPC dalam praktik layanan, yang mendukung komunikasi terbuka dan koordinasi tim.

G. Rangkuman Materi

Penerapan Interprofessional Education (IPE) dan Interprofessional Collaboration (IPC) merupakan pendekatan transformatif yang sangat penting dalam pendidikan dan praktik pelayanan kesehatan, khususnya dalam bidang kebidanan dan keperawatan. IPE memberikan landasan pendidikan yang memungkinkan mahasiswa dari berbagai profesi kesehatan untuk belajar bersama, mengenal peran dan tanggung jawab masing-masing profesi, serta membangun keterampilan kolaboratif sejak dini. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks sistem kesehatan modern yang menuntut kolaborasi lintas-profesi sebagai norma dalam pelayanan berbasis tim.

Sementara itu, IPC berperan dalam mengintegrasikan perspektif dan keahlian berbagai profesi dalam praktik pelayanan yang berfokus pada pasien secara holistik. Karakteristik utama IPC, seperti komunikasi efektif, pengambilan keputusan bersama, dan saling menghormati, menjadikan kolaborasi ini tidak hanya efisien tetapi juga etis dan manusiawi. Perawat sebagai profesi yang memiliki kedekatan langsung dengan pasien memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan komunikasi, koordinasi pelayanan, serta sebagai penghubung yang menyatukan berbagai disiplin ilmu dalam praktik klinis.

Manfaat IPE dan IPC terbukti dalam peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, efisiensi kerja tim, serta kepuasan tenaga kesehatan. Namun, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan persepsi antarprofesi, hambatan komunikasi, dan budaya profesional yang masih eksklusif. Oleh karena itu, strategi implementasi yang sistematis sangat diperlukan, mulai dari desain pembelajaran kolaboratif, simulasi interprofesional, kebijakan institusional yang mendukung, hingga penciptaan budaya organisasi yang mengedepankan keterbukaan, kesetaraan, dan sinergi.

Dengan demikian, IPE dan IPC bukan sekadar metode pendidikan dan kerja, tetapi merupakan fondasi penting dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pasien. Untuk itu, diperlukan komitmen semua pihak—pendidik, mahasiswa, praktisi, dan pemimpin organisasi—untuk terus mengembangkan dan memperkuat pendekatan kolaboratif ini demi menjawab tantangan kesehatan masyarakat masa kini dan masa depan.

H. Glosarium

Asuhan Holistik

Pendekatan pelayanan yang mencakup seluruh aspek kebutuhan pasien—fisik, psikologis, sosial, dan spiritual—bukan hanya berdasarkan kondisi klinis semata.

Collaborative Practice (Praktik Kolaboratif)

Suatu model pembelajaran atau pelayanan yang mendorong kerja sama antardisiplin dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan intervensi kesehatan secara terpadu.

Effective Communication (Komunikasi Efektif)

Kemampuan untuk menyampaikan dan menerima informasi secara jelas, terbuka, dan saling menghargai, baik secara verbal maupun nonverbal, yang esensial dalam kolaborasi tim kesehatan.

Empathy-Based Leadership

Gaya kepemimpinan yang berlandaskan empati, di mana pemimpin mengedepankan pengertian dan dukungan terhadap anggota tim untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.

Interprofessional Collaboration (IPC)

Model kerja sama antarprofesi dalam sistem layanan kesehatan yang mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai profesi untuk mencapai hasil pelayanan yang optimal.

Interprofessional Education (IPE)

Suatu pendekatan pendidikan yang melibatkan dua atau lebih profesi kesehatan untuk belajar bersama, satu sama lain, dan tentang satu sama lain, guna meningkatkan kolaborasi dan mutu pelayanan kesehatan.

Kepemimpinan Kolaboratif

Model kepemimpinan yang tidak terpusat pada satu profesi atau individu, melainkan bersifat dinamis dan adaptif sesuai dengan kebutuhan pasien dan situasi pelayanan.

Mutual Respect (Saling Menghargai)

Nilai dasar dalam kolaborasi antarprofesi yang menekankan pentingnya menghargai peran dan kontribusi masing-masing profesi tanpa memandang status atau hierarki.

Pengambilan Keputusan Bersama (Shared Decision-Making)

Proses pengambilan keputusan klinis yang melibatkan seluruh anggota tim kesehatan secara aktif, dengan mempertimbangkan perspektif dan kompetensi masing-masing profesi.

Role Clarification (Klarifikasi Peran)

Upaya untuk menjelaskan secara eksplisit tugas, tanggung jawab, dan batas kewenangan masing-masing profesi dalam tim agar terhindar dari tumpang tindih atau konflik peran.

Silo Profesional

Istilah untuk menggambarkan pemisahan kaku antara profesi dalam pendidikan atau praktik yang menyebabkan kurangnya komunikasi dan koordinasi antardisiplin.

Simulasi Interprofesional

Metode pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dari berbagai profesi dalam skenario praktik bersama, guna melatih keterampilan kolaborasi dan komunikasi dalam konteks klinis.

Single Profession Education

Model pendidikan tradisional di mana mahasiswa hanya belajar bersama rekan seprofesi tanpa interaksi dengan profesi lain, sehingga kurang membekali mereka dengan keterampilan kolaboratif.

Team-Based Care (Pelayanan Berbasis Tim)

Model pelayanan kesehatan yang menempatkan pasien sebagai pusat dan melibatkan berbagai profesi dalam tim untuk memberikan asuhan yang terkoordinasi dan komprehensif.

I. Daftar Pustaka

- Barr, H., Koppel, I., Reeves, S., Hammick, M., & Freeth, D. (2005). *Effective interprofessional education: Argument, assumption and evidence*. Blackwell Publishing.
- Bridges, D. R., Davidson, R. A., Odegard, P. S., Maki, I. V., & Tomkowiak, J. (2011). Interprofessional collaboration: Three best practice models of interprofessional education. *Medical Education Online*, 16(1), 6035. <https://doi.org/10.3402/meo.v16i0.6035>
- D'Amour, D., & Oandasan, I. (2005). Interprofessionality as the field of interprofessional practice and interprofessional education: An emerging concept. *Journal of Interprofessional Care*, 19(S1), 8–20. <https://doi.org/10.1080/13561820500081604>
- Reeves, S., Fletcher, S., Barr, H., Birch, I., Boet, S., Davies, N., ... & Kitto, S. (2016). A BEME systematic review of the effects of interprofessional education: BEME Guide No. 39. *Medical Teacher*, 38(7), 656–668. <https://doi.org/10.3109/0142159X.2016.1173663>
- World Health Organization. (2010). *Framework for action on interprofessional education and collaborative practice*. <https://www.who.int/publications/i/item/framework-for-action-on-interprofessional-education-collaborative-practice>
- Zwarenstein, M., Goldman, J., & Reeves, S. (2009). Interprofessional collaboration: Effects of practice-based interventions on professional practice and healthcare outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2009(3), CD000072. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000072.pub2>

PROFIL PENULIS



Endang Abdullah, S.Kp., M.Si Lahir di Karawang, 08 Juni 1966. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 1997. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Manajemen SDM pada Universitas Batam dan lulus tahun 2009. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1990. Sebagai Perwira Pertama Instruktur Militer TNI AL KODIKAL Surabaya. Menjabat Direktur AKPER (Akademi Keperawatan) Hang Tuah AL di Tanjungpinang (Tahun 2004 – 2007), dan Ketua STIKES Hang Tuah Tanjungpinang (Tahun 2007 – 2014). Tahun 2014 sd saat ini penulis bekerja di STIKES Hang Tuah Tanjungpinang sebagai dosen mengampu mata kuliah keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, dan keperawatan dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar Nasional dan Internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: endang.eeng866@gmail.com



Sarwoko, S.Ag, S.Kep, Ns, M.Kes, M.Kep. Lahir di Sragen, 21 Maret 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Aqidah Filsafat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997, Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, Universitas Sahid Surakarta Tahun 2014 dan 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Kedokteran Keluarga, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2009 dan Magister Keperawatan, Universitas Karya Husada Semarang tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002 sebagai tenaga kependidikan, 2004 sebagai kepala Tata Usaha, 2006-2015 sebagai Wakil Direktur pada Akademi Kebidanan Estu Utomo. 2015-2021 sebagai Wakil Ketua dan 2021-sekarang sebagai Ketua STIKES Estu Utomo. Saat ini penulis bekerja di STIKES Estu Utomo Program Studi Sarjana Keperawatan mengampu mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan, Konsep Dasar Keperawatan, Proses Keperawatan dan Berfikir Kritis, Ketrampilan Dasar Keperawatan, Biomedik dan Manajemen Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan konsultan Pendidikan Kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sanuria21@gmail.com

Motto: "*Serious, Learn and Sincere*"

Sinopsis

Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan ini disusun secara sistematis untuk membantu mahasiswa dan praktisi keperawatan memahami berbagai konsep inti dalam profesi keperawatan. Buku ini diawali dengan konsep Caring, yang merupakan esensi dasar dalam praktik keperawatan profesional. Di dalam bab ini, pembaca akan memahami pengertian caring secara mendalam, dilengkapi dengan berbagai teori dan dimensi yang relevan, serta bagaimana caring diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata dalam proses keperawatan. Uraian yang disajikan tidak hanya teoritis tetapi juga disertai dengan contoh nyata, latihan soal, serta alat pengukuran untuk membantu pembaca memahami konsep caring secara praktis.

Selanjutnya, buku ini membahas aspek Etik dan Legal dalam keperawatan, yang bertujuan memberikan bekal kepada mahasiswa dan praktisi agar mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan profesional. Pembaca diajak memahami prinsip-prinsip etik keperawatan serta ketentuan hukum yang berlaku dalam pelayanan kesehatan. Hubungan antara etik dan legal dibahas secara rinci, disertai rangkuman dan latihan untuk memperkuat pemahaman pembaca mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara tindakan etis dan aspek legal dalam praktik keperawatan.

Bab terakhir buku ini mengangkat tema penting dalam era pelayanan kesehatan modern, yaitu Interprofessional Education (IPE) dan Interprofessional Collaboration (IPC). Dalam bab ini, dijelaskan bagaimana perawat berperan aktif dalam tim interprofesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara komprehensif dan holistik. Pembaca juga akan memperoleh wawasan mengenai manfaat, tantangan, serta strategi implementasi IPE dan IPC dalam dunia pendidikan maupun praktik klinis keperawatan. Secara keseluruhan, buku ini hadir sebagai panduan penting dalam membentuk karakter profesional perawat yang kompeten, etis, dan mampu berkolaborasi secara efektif dalam lingkungan multidisiplin.

Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan ini disusun secara sistematis untuk membantu mahasiswa dan praktisi keperawatan memahami berbagai konsep inti dalam profesi keperawatan. Buku ini diawali dengan konsep Caring, yang merupakan esensi dasar dalam praktik keperawatan profesional. Di dalam bab ini, pembaca akan memahami pengertian caring secara mendalam, dilengkapi dengan berbagai teori dan dimensi yang relevan, serta bagaimana caring diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata dalam proses keperawatan. Uraian yang disajikan tidak hanya teoritis tetapi juga disertai dengan contoh nyata, latihan soal, serta alat pengukuran untuk membantu pembaca memahami konsep caring secara praktis.

Selanjutnya, buku ini membahas aspek Etik dan Legal dalam keperawatan, yang bertujuan memberikan bekal kepada mahasiswa dan praktisi agar mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan profesional. Pembaca diajak memahami prinsip-prinsip etik keperawatan serta ketentuan hukum yang berlaku dalam pelayanan kesehatan. Hubungan antara etik dan legal dibahas secara rinci, disertai rangkuman dan latihan untuk memperkuat pemahaman pembaca mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara tindakan etis dan aspek legal dalam praktik keperawatan.

Bab terakhir buku ini mengangkat tema penting dalam era pelayanan kesehatan modern, yaitu Interprofessional Education (IPE) dan Interprofessional Collaboration (IPC). Dalam bab ini, dijelaskan bagaimana perawat berperan aktif dalam tim interprofesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara komprehensif dan holistik. Pembaca juga akan memperoleh wawasan mengenai manfaat, tantangan, serta strategi implementasi IPE dan IPC dalam dunia pendidikan maupun praktik klinis keperawatan. Secara keseluruhan, buku ini hadir sebagai panduan penting dalam membentuk karakter profesional perawat yang kompeten, etis, dan mampu berkolaborasi secara efektif dalam lingkungan multidisiplin.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-13-5



9

786347

294135